Pflege-Ausbildung Lernf��hrer (DE���TR)

- Pflege-Ausbildung: Öğrenme ve Sınav Hazırlık Rehberi (Almanca–Türkçe)
  - Kullanım sırası (öneri)
  - Ana rehber
  - Ekler
  - İşaretler
  - Henüz bilmediklerim (bana söyleyin)
- 00 — Dosya Envanteri, Konu Haritası ve Kaynak Kalitesi (Bölüm A)
  - 1. Nasıl okudum? (dürüst durum raporu)
  - 2. Envanter (30 dosya)
  - 3. Öğrenme sırası (ön koşullar)
  - 4. Çelişkiler ve şüpheli noktalar (düzeltilmeden bırakıldı)
  - 5. Ders–konu–sınav haritası
- 01 — LF 1A: Grundverständnis beruflichen Pflegens
  - 1. Thema auf Deutsch: Was ist Pflege? – Professionelle Pflege
  - 2. Berufsbild & Handlungskompetenz
  - 3. Krohwinkel – 13 ABEDL (Lernskript S. 3)
  - 4. Pflegeprozess (6 Phasen nach Fiechter & Meier) – Bölüm E
  - 5. Gesetzliche Grundlagen: PflBG (Lernskript S. 4–5) – Bölüm K
  - 6. Prüfungswissen – Kurzfassung
- 02 — Pflegerische Kommunikation, Berührung, Nähe & Distanz
  - 1. Grundlagen: Was ist Kommunikation?
  - 2. Begrüßung, Schweigen, Gespräch eröffnen/beenden (Sequenz 2)
  - 3. Situationsorientierte Sprache & infantilisierende Sprache (Sequenz 3, S. 17)
  - 4. Berührung, Nähe & Distanz (LF 3a, T. Spingler, 13.10.2026)
  - 5. Wichtige Fachbegriffe (Kommunikation)
  - 6. Prüfungswissen & Fehler
- 02b — Pflegedeutsch: Hasta ve ekip iletişimi (Bölüm D)
  - D1 — Hastayı karşılama ve kendini tanıtma
  - D2 — Kimlik ve ihtiyaçları doğrulama
  - D3 — Ağrı hakkında soru sormak
  - D4 — Yaşamsal bulguları ölçmeden önce açıklama
  - D5 — Mobilizasyona yardım
  - D6 — Kişisel hijyen ve mahremiyet
  - D7 — Doktora değişiklik bildirimi (SBAR)
  - D8 — Vardiya devri (Übergabe)
  - D9 — İlaçlarla ilgili hasta sorusu
  - D10 — Anlaşılmayan talimatı netleştirme (Pflegende → Anleiterin)
  - D11 — Hata, risk veya acil durum bildirimi
  - D12 — Hasta yakını ile görüşme
  - Sınav simülasyonu (mündlich) – örnek soru dizisi
- 03 — LF 3a: Hygiene, Infektionen, Infektionsschutz (Arbeitsschutz)
  - 1. Hygiene – Begriff und Teilbereiche
  - 2. Infektion: Begriffe & Übertragungswege
  - 3. Persönliche Hygiene der Pflegenden (T1 S. 9)
  - 4. Händehygiene (T1 S. 14–19; H S. 5–7; BGW S. 7–9)
  - 5. Handschuhe & Schutzkleidung
  - 6. Keimreduktion: Reinigung – Desinfektion – Sterilisation (T1 S. 11–13)
  - 7. Entzündung (T2 S. 4–13; Haut Teil 2 S. 7)
  - 8. Multiresistente Erreger (MRE) (T2 S. 16–17; BGW S. 10–11)
  - 9. Arbeitsschutz & Berufskrankheiten (BGW 2018)
  - 10. Fachbegriffe (Auswahl)
  - 11. Pflegepraxis / Prüfungswissen / Fehler
- 04 — LF 3a: Zelle, Gewebe, Haut und Hautveränderungen
  - 1. Zelle (T1 S. 1–2)
  - 2. Gewebe (T1 S. 3–4)
  - 3. Haut: Aufbau & Funktion (T2 S. 1–5)

    - 4. Hautbeobachtung in der Pflege (T2 S. 5–8) – prüfungsrelevant
    - 5. Dekubitus (T2 S. 8)
    - 6. Gutartig / bösartig; ABCDE-Regel (T2 S. 8)
    - 7. Altersabhängige Besonderheiten (T2 S. 9–10)
    - 8. Fachbegriffe
    - 9. Prüfungswissen / Fehler / Merksätze / Lernkontrolle
- 05 — Körpertemperatur, Fieber, Hypo-/Hyperthermie
    - 1. Physiologie (S. 2–4)
    - 2. Wann & wo messen? (S. 5–14)
    - 3. Hypothermie (S. 15–17)
    - 4. Hyperthermie (S. 17–21) vs. Fieber
    - 5. Fieber (S. 21–29)
    - 6. Pflege-Fall: Herr Schneider mit Fieber (Übung)
    - 7. Fachbegriffe
    - 8. Prüfungswissen / Fehler / Merksätze
- 06 — LF 2: Mobilität, Bewegung im Alter und Sturzprophylaxe
    - 1. Mobilität – Begriffe (EH S. 1–2, 4)
    - 2. Was verändert sich im Alter? (EH S. 1–2)
    - 3. Folgen von Immobilität (EH S. 3)
    - 4. Prophylaxe & Prävention – Begriffe (EH S. 4)
    - 5. Sturzprophylaxe (PPP „LF 2 Sturzprophylaxe“)
    - 6. Fall Herr Schneider (Operatoren-Übung, `image.jpg` #2) – Feedback zu Ihren Antworten
    - 7. Fachbegriffe
    - 8. Prüfungswissen / Fehler / Merksätze
- 07 — LF 2: Thromboseprophylaxe, Pneumonieprophylaxe, Kontraktur
    - A. THROMBOSEPROPHYLAXE
    - B. PNEUMONIEPROPHYLAXE
    - C. Fachbegriffe
    - D. Prüfungswissen / Fehler / Merksätze
- 08 — Erste Hilfe, Basic Life Support (BLS), AED, Schock und akute Notfälle
    - 1. Warum Anatomie? (ZF S. 1)
    - 2. Notfall und Erste Hilfe – Definition & Recht
    - 3. Sicherheit, Notruf, Rettungskette
    - 4. Erste Einschätzung & Basischeck
    - 5. Basic Life Support (BLS) und AED
    - 6. Schock (ZF S. 16–17; F 195–204)
    - 7. Wichtige Notfälle
    - 8. Handlungsablauf Station (ZF S. 22–25) – „Patient liegt am Boden“
    - 9. Fachbegriffe (Auswahl)
    - 10. Prüfungswissen / Fehler / Lernkontrolle
- 09 — Pflegeprozess und klinisches Denken (Bölüm E) – Vorlage + ausgearbeiteter Plan
    - 1. Die 6 Phasen – Fragen & Checkliste
    - 2. Ausgearbeitetes Beispiel: Herr Schneider (Lernfall aus Ihrem Übungsheft)
    - 3. Fall Frau Berger (Hüftschmerz, Brille fehlt) – Plan-Skizze
    - 4. Schreib-Rahmen für die Klausur (Pflegeplan in 6 Zeilen)
- 10 — Pflegedokumentation, Operatoren und Klausur-Schreiben (Bölüm J)
    - 1. Operatoren (Handlungsanweisungen in Aufgaben)
    - 2. Grundprinzipien der Pflegedokumentation (Bölüm J)
    - 3. Falsch ↔ richtig (mit Begründung)
    - 4. Temperatur-/Sturz-/Haut-Eintrag – Vorlagen
    - 5. Wendungen für schriftliche Antworten (Bölüm J – mit Beispielen)
    - 6. Prüfungswissen/Merksätze/Lernkontrolle
- 11 — Almanca gramer ve yazma becerisi (Bölüm I)
    - 1. Artikel & Fälle (Nominativ – Akkusativ – Dativ – Genitiv)
    - 2. Tempus
    - 3. Modalverben
    - 4. Passiv (Vorgangs- & Zustandspassiv)
    - 5. Nebensätze und Konnektoren (Verb am Ende)
    - 6. Konjunktiv II – höfliche Bitten & Angebote

    - 7. Imperativ – Anleitung/Anweisung
    - 8. Objektive Sprache (Berichte/Dokumentation)
    - 9. Wortbildung/Medizinische Wörter
    - 10. Hata analizi – nasıl öğrenirsiniz?
    - 11. Pflege-Alıştırmalar (cevaplar altta)
- 12 — Berufskontext in Deutschland (Bölüm K) und Lernplan (Bölüm L)
    - Teil K — Ausbildungs- und Berufskontext
    - Teil L — Esnek çalışma planı
- Ek 1 — Mesleki Almanca–Türkçe hemşirelik sözlüğü
    - 1. Anatomi ve fizyoloji
    - 2. Hastalıklar ve belirtiler
    - 3. İlaçlar ve uygulama (belgelerde sınırlı)
    - 4. Bakım ve hijyen
    - 5. Yaşamsal bulgular
    - 6. Yara bakımı / cilt (belgelerde sınırlı)
    - 7. Beslenme ve sıvı dengesi
    - 8. Hareket ve mobilizasyon
    - 9. Acil durumlar
    - 10. Gözlem ve dokümantasyon
    - 11. İletişim ve hasta yakınları
    - 12. Etik, mahremiyet, hasta hakları
    - 13. Hukuki sorumluluklar
    - 14. Ekip ve doktorla iletişim
    - 15. Karıştırılan kelime çiftleri (Bölüm C)
- Ek 2 — Sınavda kullanılabilecek Almanca cümle kalıpları
    - 1. Tanımlama (DEFINIEREN / BESCHREIBEN)
    - 2. Erklären / Begründen
    - 3. Vergleichen
    - 4. Beschreiben von Zeichen/Beobachtungen
    - 5. Maßnahmen
    - 6. Evaluation / Kontrolle
    - 7. Eskalation / Sicherheit
    - 8. Folgern / Zusammenfassen / Urteilen (AFB III)
    - 9. Hastayla iletişim kalıpları
    - 10. Doktor / Ekip (SBAR)
    - 11. Geçiş sözcükleri
- Ek 3 — En önemli konuların kısa tekrar notları
    - 1. Pflegeverständnis (LF1A) → 01
    - 2. Kommunikation → 02
    - 3. Hygiene → 03
    - 4. Haut → 04
    - 5. Temperatur → 05
    - 6. Mobilität & Sturz → 06
    - 7. Prophylaxen → 07
    - 8. Erste Hilfe → 08
    - 9. Operatoren & Dokumentation → 10
- Ek 4 — Flashcard seti (119 kart)
    - Pflege
    - Kommunikation
    - Hygiene
    - Haut
    - Temperatur
    - Mobilität
    - Sturz
    - Thrombose
    - Pneumonie
    - Erste Hilfe
    - Operatoren
- Ek 5 — Deneme sınavları (soru kitapçığı — **cevapsız**)

- Klausur 1 — Pflegeverständnis, Pflegeprozess, Operatoren, Dokumentation
- Klausur 2 — Kommunikation, Berührung, Nähe–Distanz
- Klausur 3 — Erste Hilfe / BLS / Notfälle
- Klausur 4 — Mobilität, Sturz, Thrombose/Pneumonie, Pflegeprozess
- Klausur 5 — Hygiene, Haut, Körpertemperatur
- Ek 5b — Cevap anahtarı ve ayrıntılı açıklamalar
  - Klausur 1
  - Klausur 2
  - Klausur 3
  - Klausur 4
  - Klausur 5
- Ek 5c — Operatör formatında vaka sınavları (Übungsheft tarzı) — **soru kitapçığı**
  - Fallbeispiel A: Frau Keller *(Kaynak: 04, 06, 07)*
  - Fallbeispiel B: Herr Hoffmann *(Kaynak: 05, 03)*
  - Fallbeispiel C: Auszubildende Lena und Herr Roth *(Kaynak: 03)*
  - Fallbeispiel D: Frau Weber *(Kaynak: 02, 02b)*
  - Fallbeispiel E: Herr Lang *(Kaynak: 08, 02b)*
  - Fallbeispiel F: Frau Berger – Pflegeprozess *(Kaynak: 01, 06, 09)*
- Ek 5d — Operatör vakaları: örnek cevaplar (**Musterlösungen**)
  - Fall A: Frau Keller
  - Fall B: Herr Hoffmann
  - Fall C: Lena und Herr Roth
  - Fall D: Frau Weber
  - Fall E: Herr Lang
  - Fall F: Frau Berger
- Ek 6 — Klinik vaka dosyası (Bölüm G)
  - Fall 1 — Frau Berger (81): Veränderte Mobilität (LF 2)
  - Fall 2 — Herr Schneider (78): Sturz, Angst, Waschen, wenig getrunken
  - Fall 3 — Herr Aksoy (72): Bettlägerig, Thrombose-/Pneumoniegefahr (Post-OP/Immobil)
  - Fall 4 — Frau Wozny: Clostridioides difficile / Händehygiene (LF 3a)
  - Fall 5 — Frau Demir (84): Dekubitusrisiko und Hautbeobachtung (LF 3a)
  - Fall 6 — Patientin am Boden (Erste Hilfe, innerklinisch)
  - Fall 7 — Johanna: „Wie alt sind Sie überhaupt?“ (Kommunikation)
  - Fall 8 — Herr Becker (66): Verschlucken und Husten beim Essen (Aspirationsprophylaxe)
  - Yorum şablonu (her vaka için)
- Ek 7 — Kişisel gelişim takip tablosu (Bölüm H / Ek 7)
  - 1. Konu takibi
  - 2. Yanlış yapılan sorular (Zayıf konu listesi)
  - 3. Almanca hata günlüğü
  - 4. Haftalık özet
  - 5. Öğretmene sorulacaklar listesi
- Ek 8 — Kaynakça ve sayfa indeksi
  - 1. Yüklenen kaynaklar ve önemli sayfalar
  - 2. Dış kaynaklar (ek bilgiler — açıkça PDF dışı)
  - 3. Doğrulanamayan / eksik

Pflege-Ausbildung: Öğrenme ve Sınav Hazırlık Rehberi (Almanca–Türkçe)

Almanya’da **Pflegefachfrau/-mann Ausbildung** öğrencisi için, yüklediğiniz **30 ders dosyasına** (28 PDF/PPTX + 2 el yazılı fotoğraf) dayanan rehber. Amaç: dersi anlamak, mesleki Almanca öğrenmek, sınava hazırlanmak, güvenli hasta bakımını öğrenmek.

> ⚠ **Önce okuyun:** 00 Envanter ve çelişkiler — OCR kalitesi, okunmayan/eksik kısımlar ve belgeler arasındaki **çelişkiler** (ör. Herzdruckmassage 100–120 vs. 80–100/min) burada. Bu rehber **eğitim**

> **amaçlıdır**; klinik talimat ya da hukuki tavsiye değildir. Gerçek uygulamada Praxisanleitung, sorumlu Pflegefachkraft, Hausstandard ve güncel mevzuat geçerlidir.

Kullanım sırası (öneri)

1. 01 Pflegeverständnis → 2. 10 Operatoren/Dokumentation → 3. konu kapitelleri → 4. Ek 4 Flashcards → 5. Ek 5 Sınavlar → 6. Ek 7 Takip. Plan: 12 Lernplan.

Ana rehber

#	Dosya	İçerik
00	Envanter, konu haritası, çelişkiler	Bölüm A
01	LF1A Pflegeverständnis, ABEDL, Pflegeprozess, PflBG	B, E, K
02	Kommunikation, Berührung, Nähe–Distanz	B
02b	Pflegedeutsch-Dialoge (12 durum)	D
03	Hygiene, Infektionsschutz, BGW	B
04	Zelle, Gewebe, Haut	B
05	Körpertemperatur, Fieber	B
06	Mobilität, Sturzprophylaxe + Fall Herr Schneider	B
07	Thrombose-, Pneumonieprophylaxe	B
08	Erste Hilfe, BLS, AED, Schock, Notfälle	B
09	Pflegeprozess & klinisches Denken	E, G
10	Dokumentation, Operatoren	J
11	Grammatik	I
12	Berufskontext & Lernplan	K, L

Ekler

Ek	Dosya
1	Sözlük DE–TR (14 kategori + karıştırılan çiftler)
2	Sınav cümle kalıpları
3	Konu özetleri
4	Flashcards (119) · CSV (Anki)
5	Deneme sınavları (5) · Cevap anahtarı
5c	**Operatör formatlı vaka sınavları (6 vaka, Übungsheft tarzı)** · Örnek cevaplar
6	Klinik vakalar
7	Takip tablosu
8	Kaynakça ve sayfa indeksi

Tek dosya PDF: `Pflege_Lernfuehrer_komplett.pdf` (aynı içerik, tek belge).

İşaretler

- ⚠ = PDF'de yok / doğrulanmadı / çelişki — kendi okulunuzla kontrol edin.
- **kendi önerim** = Eselsbrücke/örnek bana ait, kaynak PDF'de yok.
- **Örnekler kurgusaldır** (hasta adları ve ölçüm değerleri uydurmadır; gerçek hasta verisi yok).
- Alıntı yaparken: *Dosya adı + PDF-S.* (bkz. Ek 8).

Henüz bilmediklerim (bana söyleyin)

Sınav tarihi · günlük çalışma süreniz · Almanca seviyeniz · sınav formatı · okulunuzun özel beklentileri. Daha fazla PDF gönderdiğinizde (siz "birkaç PDF daha" demiştiniz) ilgili bölümlere eklerim.

Not: OCR ham metinleri telif içeren ders materyalidir; depoya eklenmedi.

00 — Dosya Envanteri, Konu Haritası ve Kaynak Kalitesi (Bölüm A)

Navigasyon: README · Sonraki: 01 Pflegeverständnis

1. Nasıl okudum? (dürüst durum raporu)

Yöntem	Dosyalar
Metin katmanı vardı (doğrudan okundu)	`Zusammenfassung_Erste_Hilfe_B2` (27 S.), `Sturzprophylaxe_PPP.pptx` (15 Folie)
Taranmış/görüntü PDF → **Tesseract OCR (Almanca)**, sayfa sayfa; şüpheli sayfalar görüntüden kontrol edildi	diğer tüm PDF'ler
El yazılı fotoğraf (2 adet `image.jpg`) → OCR + görüntüden okundu	Operatoren-Training, Fallbeispiel Herr Schneider

Sınırlar (önemli):

- OCR hatası olabilir (özellikle tablolar, çizimler, Erste Hilfe slaytlarındaki grafikler). Sayısal değerler kritik yerlerde görüntüden doğrulandı (S. 22, 140, 172 Erste Hilfe).
- `Erste Hilfe` 254 sayfanın tamamı OCR'landı; ancak ilk 57 sayfa (anatomi çizimleri) ve S. 234–254 (özetin tekrarı) **yalnızca başlık düzeyinde** incelendi, içeriği `Zusammenfassung_Erste_Hilfe_B2` ile örtüşüyor.
- `BGW Take Care Infektionsschutz` 56 sayfa: S. 1–20 ayrıntılı okundu; S. 21–56 öğretmen materyali/ çalışma kâğıdı olduğu için yalnızca taranmıştır.
- Bazı çalışma kâğıtları boş (doldurulacak) — cevap yok; ben **kendi cevap önerimi** verdim ve "örnek cevap" diye işaretledim.
- Sayfa numarası: "PDF-S." = PDF'nin kaçıncı sayfası; "bas. S." = kitabın basılı sayfası (I care).

2. Envanter (30 dosya)

#	Dosya	Sayfa	Konu	Ders alanı (belgeden)
1	Lernskript (LF1A)	6	Pflegeverständnis, ABEDL, Pflegeprozess, PflBG	LF 1A
2	Arbeitsblatt LF1A	10	Aynı konunun boş çalışma kâğıdı, Frau Berger	LF 1A
3	Handlungskompetenz (I care, S. 47–48)	2	Handlungskompetenz, KMK	LF 1
4	Einstieg in die Unterrichtseinheit (9.10.2025)	15	Kommunikation: Sender-Empfänger, 4 Seiten	NaKomm
5	Sequenz 2 – Fall Simon	10	Begrüßung, Schweigen, Gesprächsbeginn/-ende	NaKomm
6	Sequenz 3 – Kommunikation	19	Nonverbal, Watzlawick, Feedback, Sprache	NaKomm
7	Sequenz 4 – Fall Johanna	8	Vier Ohren	NaKomm
8	Sequenz 5	5	Formelle/informelle Kommunikation	NaKomm
9	Fallbeispiel Merkmale u. Bedeutung pfleg. Kommunikation	2	Fälle Maria/Simon/Johanna	NaKomm
10	PPP Berührung AI 02	6	Berühren, Begriffe	LF 3a
11	PPP Berührung AI 04	14	Berührung, Nähe–Distanz	LF 3a
12	PPP Berührung AI 05	6	Beziehungsprozess, Hall-Zonen	LF 3a
13	Arbeitsinput 06b Tabuzonen	1	Tabuzonen nach Morris	LF 3a
14	Hyg. Grundlagen Teil I	21	Hygiene, Händehygiene, WHO-5-Momente	LF 3a

#	Dosya	Sayfa	Konu	Ders alanı (belgeden)
15	Hyg. Grundlagen Teil II Infektionen	24	Erreger, Entzündung, MRE, Schutzkleidung	LF 3a
16	Handout Grundlagen hygienischen Handelns	10	Übertragungswege, Handschuhe, Hautschutz	LF 3a
17	Übung Händedesinfektion (Pflegias)	2	Experiment	LF 3a
18	BGW Take Care Infektionsschutz (2018)	56	NSV, Hepatitis, MRSA, TB, Skabies	Arbeitsschutz
19	LF3A Haut Teil 1: Zelle & Gewebe	4	Zelle, Mitose/Meiose, Gewebe	LF 3a
20	LF3A Haut Teil 2: Haut & Hautveränderungen	10	Haut, Turgor, Zyanose, Dekubitus, ABCDE	LF 3a
21	Thieme CNE: Veränderung der Körpertemperatur	36	Thermoregulation, Fieber, Hypo-/Hyperthermie	LF 3
22	Erwartungshorizont Bewegung im Alter	4	Mobilität, Prophylaxe-Begriff	LF 2
23	Sturzprophylaxe (PPP)	15	Sturz, Risiko, Maßnahmen, Protokoll	LF 2
24	Thromboseprophylaxe (PPP)	4	Einstieg	LF 2
25	Auszug I care Thromboseprophylaxe (bas. S. 417–422)	6	Virchow, MTPS, Kompression (+ **Pneumonie-LISA am Anfang**)	LF 2
26	Pneumonieprophylaxe (PPP, 16.10.2026)	22	Pneumonie, Aspiration, Prophylaxe	LF 2
27	Erste Hilfe (Folien, Sept. 2026)	254	Anatomie, BLS/ALS, Schock, Notfälle	LF 1/2
28	Zusammenfassung Erste Hilfe B2	27	Lernorientierte Zusammenfassung der 228 Folien	LF 1
29	image.jpg #1	1	Operatoren-Training (AFB I–III), Türkçe notlarla	Klausur
30	image.jpg #2	1	Fallbeispiel Herr Schneider, kendi cevaplarınız	Klausur

> **Not:** Dosyalarda tarihler (2021, 2022, 2025, 2026) ve farklı yazarlar var → farklı okullar/dönemler. Bu yüzden terminoloji ve sayılar zaman zaman farklıdır (bkz. §4).

3. Öğrenme sırası (ön koşullar)

```
LF1A Pflegeverständnis (Pflege nedir? Ressource, ABEDL, Pflegeprozess, PflBG)
   ├─► Kommunikation (Sender/Empfänger → 4 Seiten → nonverbal → Berührung/Nähe-Distanz)
   ├─► Hygiene & Infektionsschutz (Händehygiene → Infektion → MRE → Schutzkleidung)
   │       └─► Haut/Zelle/Gewebe (Haut = Barriere; Entzündungszeichen; Dekubitus)
   │               └─► Körpertemperatur/Fieber
   ├─► Mobilität im Alter ──► Sturzprophylaxe
   │                   └─► Thrombose- & Pneumonieprophylaxe (Immobilität!)
   └─► Erste Hilfe (Herz-Kreislauf-Atmung A&P → BLS/AED → Schock/Notfälle)
Alle Stränge ─► Pflegeprozess & Dokumentation ─► Operatoren/Klausurtechnik
```

4. Çelişkiler ve şüpheli noktalar (düzeltilmeden bırakıldı)

#	Konu	Belge A	Belge B	Öneri
1	Herzdruckmassage Frekans	Erste Hilfe Folie 137 „optimal **100**/min“, Folie 140 ve 172 (görüntüden doğrulandı) „**80–100**/min“	Folie 121/163, Zusammenfassung: „**100–120**/min“	Sınavda **100–120/min** yaz (GRC/ERC kılavuzuyla uyumlu; ⚠ 2025 metnini doğrula) ve öğretmene sor
2	Drucktiefe	Zusammenfassung/Folie 137: „5–6 cm“	Folie 140/172: „5 cm oder ½ Thorax“ ; Folie 163: „mind. 5 cm, nicht mehr als 6 cm“	5–6 cm

#	Konu	Belge A	Belge B	Öneri
3	Sinusknoten Frequenz	Zusammenfassung S. 3: „60–80“	Folie 22 (Abb., doğrulandı): „60–100/min“	Folie 22 = standart değer; Zusammenfassung'u sor
4	Kind-BLS	Folie 131: „Kinder einheitlich 15:2“	Folie 121: ohne PBLS-Training 30:2 + 5 Beatmungen; Folie 133: 30:2	Eğitim durumuna göre değişir (Folie 121)
5	Kind Drucktiefe	Folie 141: „4 cm“	Folie 142: „5 cm“; Folie 133: ⅓ Thorax	⅓ Thoraxdurchmesser kuralı
6	„Leitlinien 2025“	Folie 84/85 başlık „2025“	Kaynak ve impressum = **2021 / Version 2022**	Başlık-içerik uyumsuz; öğretmene sor
7	Asystolie	Folie 122: „> 2 Sekunden Aussetzen“	genel tanım: Kreislaufstillstand ile EKG'de aktivite yok	Tanımı olduğu gibi öğren ama klinik tanım için doğrula ⚠
8	Hypothermie	Thieme S. 15: „< 35 °C“	aynı sayfada Einteilung „mild 32–36 °C“	iç çelişki; ≥ 35 normal sınırı kabul edilir, mild: 32–35
9	Normaltemperatur	Tab. 4: afebril 36,3–37,4	Text: Sollwert 36–37,5	Tablo rektal ölçüm içindir
10	Puls/Fieber	S. 22: 8–12 /°C	S. 28: 8–10 /°C	„≈ 8–10 (–12)“
11	Tehlikeli sıcaklık	S. 2: > 41 °C lebensbedrohlich	S. 17: 42 °C Tod; S. 22: 42,6 °C Eiweißgerinnung	Farklı eşikler (kritik / ölümcül)
12	Pneumonie-Tanım	Pneumonie PPP S. 2: „ambulant… nosokomial **+24 Std.**“	Genel kaynaklar: nosokomial ≥ 48 Std. nach Aufnahme ⚠	Sınıfta sor
14	Sturz-Expertenstandard	Sturzprophylaxe PPP S. 7: „DNQP (2013)“	Dış kaynak: 2. Aktualisierung **2022** (DNQP)	2022 sürümünü belirt
15	Autor adı	Lernskript: „Fiechter und Meier“	Arbeitsblatt: „Fichter und Meier“	Doğrusu **Fiechter & Meier** ⚠
16	Skript Haut S. 9	„Unterhaut (Dermis)“	Dermis = **Lederhaut** (S. 2)	Yazım hatası: Lederhaut
17	„Letingo“, „Elatinfasern“	Haut Teil 2	doğrusu **Lentigo**, **Elastinfasern**	yazım
18	Thromboseprophylaxe-Auszug	Dosya adı Thrombose	PDF-S. 1 başı = **Pneumonie-LISA** (bas. S. 416–417)	Dosya karışık
19	Zusammenfassung B2	„228 Folien“	Deck 254 S.	254 = PDF sayfası (ek ve kaynak sayfaları dahil)
20	MRE Teil II S. 16	„ESBL = … Enterokokken“	ESBL = Enterobakterien (Beta-Laktamase) ⚠ dış bilgi	Sınavda ESBL: Enterobakterien

5. Ders–konu–sınav haritası

Ders / Konu	Temel kavramlar	Klinik bağ	Sınav önemi	Bağlantı
Pflegeverständnis	Ressource, Bedürfnis, Autonomie, ABEDL, Pflegeprozess (6 Phasen), §4 PflBG	Frau Berger	★★★ (hep sorulur)	tüm konular
Kommunikation	Laswell, Schulz v. Thun, Watzlawick, nonverbal, Feedback, Ich-Botschaft	Begrüßung, Intimpflege, Schweigen	★★★	Berührung, Dokumentation
Berührung/Nähe-Distanz	Initialberührung, Hall-Zonen, Tabuzonen	Körperpflege	★★	Intimsphäre, Scham
Hygiene	WHO-5-Momente, HD vs. Waschen, Keimreduktion	tägliche Pflege	★★★	Haut, MRE, BGW

Ders / Konu	Temel kavramlar	Klinik bağ	Sınav önemi	Bağlantı
Infektion/MRE	endogen/exogen, nosokomial, MRSA, 5 Entzündungszeichen	Isolation	★★★	Pneumonie, Haut
Haut/Gewebe	3 Schichten, Turgor, Zyanose, Dekubitus, ABCDE-Regel	Hautbeobachtung	★★★	Dekubitus, Temperatur
Körpertemperatur	Hypothalamus, Fieberphasen, Lysis/Krisis, Wickel	Fieberpflege	★★★	Haut, Exsikkose
Mobilität/Sturz	Mobilität-Stufen, Sturzrisiko, Sturzprotokoll	Frau Berger/Herr Schneider	★★★	Prophylaxen
Thrombose	Virchow-Trias, Basismaßnahmen, MTPS	Post-OP	★★★	Lungenembolie (EH)
Pneumonie	LISA, typisch/atypisch, Aspiration, CRB-65	bettlägerige	★★★	Aspiration, Dysphagie
Erste Hilfe	BLS, 30:2, AED, Schock, Herzinfarkt, Apoplex	Station	★★★ (Praxis!)	Thrombose→LE
Klausurtechnik	Operatoren (AFB I–III)	alle Fälle	★★★	10 Dokumentation & Operatoren

01 — LF 1A: Grundverständnis beruflichen Pflegens

> ← 00 Inventar · 02 Kommunikation → Kaynaklar: *Lernskript LF1A* (PDF-S. 1–6), *Arbeitsblatt LF1A* (S. 1–10), *Handlungskompetenz* (I care S. 47–48 = PDF-S. 1–2). Bu bölüm Bölüm B, E ve K'yı kapsar.

---

1. Thema auf Deutsch: Was ist Pflege? – Professionelle Pflege

Einfache Erklärung (DE): Pflege gibt es überall: Eltern pflegen Kinder, Töchter helfen der Mutter. *Berufliche* Pflege ist anders: Sie ist **fachlich begründet, geplant und mit Verantwortung verbunden** (Lernskript S. 1). Pflegefachpersonen beobachten, erfassen den Unterstützungsbedarf, beziehen vorhandene Fähigkeiten ein, planen, führen durch und überprüfen die Wirkung.

Türkçe açıklama: Mesleki hemşirelik "yardım etmek"ten fazlasıdır: bilimsel temelli, planlı ve sorumluluk taşır. En önemli fikir: *hastanın yerine her şeyi yapmak* değil, **bağımsızlığını korumak/geliştirmek**. Sınav sorusu "Pflege vs. Alltagshilfe" ise şu üç ölçüt yazılır: Fachwissen, systematisches Vorgehen, Verantwortung (+ Beziehungsgestaltung).

Form	Beispiel (Lernskript S. 1)	Kennzeichen
Selbstpflege	Person versorgt sich selbst	eigenständig
Informelle Hilfe	Tochter kauft für Mutter ein	Angehörige/Freunde
Professionelle Pflege	PFK unterstützt nach OP	Fachwissen, systematisch, Verantwortung

Wichtige Fachbegriffe | Almanca | Türkçe | Not | |---|---|---| | die Pflegefachperson (PFK), Pl. -en | hemşire (cinsiyetten bağımsız unvan) | | | der Pflegeempfänger / die Pflegeempfängerin | bakım alan kişi | I care terimi | | das Bedürfnis, -se | ihtiyaç | | | das Problem, -e | sorun | pflegerische Unterstützung nötig | | die Ressource, -n | kaynak/güçlü yan, mevcut beceri | | | die Selbstbestimmung / Autonomie | özerklik | | | die Selbstständigkeit | bağımsızlık | | | der Unterstützungsbedarf | destek ihtiyacı | | | ganzheitlich | bütüncül | |

Praktisches Beispiel (Frau Berger, Lernskript S. 2): 78 J., nach Sturz, Schmerzen rechts Hüfte; isst/trinkt selbst; braucht Hilfe beim Aufstehen; Brille fehlt; sagt „Ich möchte so viel wie möglich selbst machen“; lebt allein; Tochter in der Nähe.

Beobachtung	Unterstützungsbedarf	Ressource
Schmerzen/vorsichtige Bewegung	Sicherheit bei Bewegung	kann Bedürfnisse äußern
Hilfe beim Aufstehen nötig	Unterstützung Mobilität	kann mitwirken
Brille fehlt	Orientierung/Sehen	kann Bedarf mitteilen
möchte viel selbst machen	Selbstbestimmung beachten	hohe Motivation
lebt allein	Unterstützung nach Entlassung bedenken	Tochter = soziale Ressource

Pflegepraxis: Statt „Frau Berger kann nicht aufstehen“ → „Frau Berger kann mit Unterstützung aufstehen und möchte mitwirken.“ (Ressourcen-Sprache.)

Prüfungswissen: Drei Begriffe immer mit **eigener Definition + Beispiel** (Arbeitsblatt S. 4): Bedürfnis, Ressource, Problem, Autonomie.

Häufige Fehler: Ressource ≠ „Problem lösen“; Ressource = was die Person *kann* (auch Angehörige). Problem ≠ Diagnose.

Merksätze: *„Pflege bedeutet nicht, einem Menschen möglichst viel abzunehmen.“* (Lernskript S. 1) · *„Was kann die Person selbst?“*

Lernkontrolle

1. Wodurch unterscheidet sich professionelle Pflege von Alltagshilfe?
2. Nenne zwei Ressourcen von Frau Berger.

3. Warum ist „Ich möchte so viel wie möglich selbst machen“ pflegerisch wichtig? (→ Autonomie, Ressourcenförderung, aktivierende Pflege)

---

2. Berufsbild & Handlungskompetenz

Handlungskompetenz (KMK 2011, I care S. 47): *sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht und verantwortlich verhalten können.* **3 Dimensionen** (I care Abb. 2.7, PDF-S. 2):

Dimension	Bedeutung (DE)	Türkçe	Pflegebeispiel (Frau Berger)
Fachkompetenz	Aufgaben auf Grundlage von Wissen und Können lösen und Ergebnis beurteilen	mesleki bilgi-beceri	weiß, wie man sicher mobilisiert; kennt Sturzrisiken
Personale Kompetenz (Selbst-/Humankompetenz)	eigene Begabungen entfalten, Verantwortung, Reflexion	kişisel yeterlilik	reflektiert nach dem Transfer: „War ich zu hektisch?“
Sozialkompetenz	Beziehungen gestalten, Empathie, Teamfähigkeit, Konfliktbereitschaft	sosyal yeterlilik	erklärt verständlich, achtet Wunsch nach Selbstständigkeit

Jede Dimension enthält 3 **Teilkompetenzen**: **Methodenkompetenz** (planmäßig, zielgerichtet; z. B. Pflegeprozess), **Lernkompetenz** (Informationen verstehen/auswerten), **kommunikative Kompetenz** (Situationen verstehen und gestalten).

> ⚠ **Terminologie-Unterschied:** Lernskript (S. 1) und Arbeitsblatt nennen „**vier Kompetenzbereiche**: Fach-, Methoden-, Sozial-, Selbstkompetenz“ und ordnen Kommunikation/Lernen der Methodenkompetenz zu. I care (KMK-Modell): **drei** Dimensionen + je drei Teilkompetenzen. In der Klausur das **Schul-Modell (Lernskript)** nennen und ggf. Unterschied erwähnen. (Kein Widerspruch in der Sache, nur andere Ordnung.)

Merksatz: *Fast jede Handlung braucht alle Kompetenzen – sie überlappen sich.* (I care S. 48)

Fort- und Weiterbildung (I care S. 47): Fortbildung = Wissen aktualisieren (Einrichtung muss anbieten; Nachweise z. B. Registrierung beruflich Pflegender). Weiterbildung = umfangreicher, meist 2 Jahre, ggf. Prüfung/neue Bezeichnung; Fachweiterbildung meist nach 2 J. Berufserfahrung. Beispiel bundesweit geregelt: **Praxisanleiter** – mind. **300 Std.** berufspädagogische Zusatzqualifikation + **24 Std./Jahr** Fortbildung (PflAPrV 2018, nach I care). ⚠ Zahlen aus dem Buch; Stand verifizieren.

---

3. Krohwinkel – 13 ABEDL (Lernskript S. 3)

Nr.	ABEDL (DE)	Türkçe	Beobachtungsbeispiel
1	Kommunizieren können	iletişim kurabilme	spricht kaum, Hörgerät?
2	Sich bewegen können	hareket edebilme	Gangbild, Transfer
3	Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten können	yaşamsal fonksiyonlar	Puls, RR, Temperatur, Atmung
4	Sich pflegen können	kendine bakım	Körperpflege, Haut
5	Essen und trinken können	yeme-içme	Trinkmenge
6	Ausscheiden können	boşaltım	Inkontinenz
7	Sich kleiden können	giyinme	Schuhe!
8	Ruhen, schlafen und sich entspannen können	dinlenme-uyku	Nachtunruhe
9	Sich beschäftigen, lernen und sich entwickeln können	uğraş, öğrenme	Aktivitäten
10	Die eigene Sexualität leben können	cinsellik	Intimsphäre
11	Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen können	güvenli ortam	Stolperfallen

Nr.	ABEDL (DE)	Türkçe	Beobachtungsbeispiel
12	Soziale Bereiche des Lebens sichern und gestalten können	sosyal alan	Tochter, Isolation
13	Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können	varoluşsal deneyimler	Angst, Verlust, Sterben

Merktipp: Reihenfolge = vom Körper (1–7) zum Alltag (8–11) zum Sozialen/Existenziellen (12–13). **Eine Beobachtung kann zu mehreren ABEDL passen** (z. B. „hat Angst zu stürzen“ → 2, 11, 13). ABEDL = Strukturhilfe, **ersetzt kein Gespräch**.

Übung (Arbeitsblatt S. 6) – Frau Berger zuordnen: „Schmerzen rechte Hüfte“ → 2, 3(Schmerz), 11 · „Brille fehlt“ → 1, 11 · „Lebt allein, Tochter besucht“ → 12 · „Möchte selbst machen“ → 4, 9, 13? (Autonomie; Begründung schreiben!).

---

4. Pflegeprozess (6 Phasen nach Fiechter & Meier) – Bölüm E

Phase	DE	Frage	Frau Berger (Lernskript S. 4)
1	Informationssammlung	Welche Infos liegen vor?	Schmerzen, Hilfebedarf beim Aufstehen
2	Probleme & Ressourcen erkennen	Was ist schwierig? Was kann sie?	unsicheres Aufstehen / will mitwirken
3	Pflegeziele festlegen	Was soll erreicht werden?	sicher aufstehen mit Unterstützung
4	Pflegemaßnahmen planen	Was konkret?	Schmerzen/Beweglichkeit beobachten, Umgebung sichern, Unterstützung anbieten, einbeziehen
5	Durchführung	Umsetzen	gemeinsam
6	Evaluation / Wirkung beurteilen	Ziel erreicht? Planung anpassen?	war Aufstehen sicher?

Merksatz: *Pflegeprozess = Kreislauf*: ohne Evaluation wird nicht angepasst (Lernskript S. 4).

Ziele richtig formulieren (kendi önerim – ⚠ Ek bilgi, genel SMART-mantığı): Ziel aus Sicht des Patienten, messbar, mit Zeit: „Frau Berger steht bis zum 3. Tag mit einer Pflegekraft sicher vom Bett auf und äußert dabei höchstens leichte Schmerzen (NRS ≤ 3).“ *(NRS-Skala PDF'lerde yok; sadece örnek.)*

Evaluation: Zielerreicht / teilweise / nicht erreicht → Ursache → Planung anpassen → dokumentieren.

Klinisches Denken – Vorlage für jeden Fall (Bölüm E soruları):

1. Hauptproblem? 2. Fehlende Infos (z. B. Schmerzstärke, Medikamente, Sehhilfe, Orientierung)? 3. Wichtige Zeichen? 4. Risiken (Sturz, Dekubitus, Thrombose, Pneumonie, Exsikkose)? 5. Ressourcen? 6. Ziele? 7. Maßnahmen? 8. Evaluation? 9. Wann PFK/Arzt informieren (Verschlechterung, neue Schmerzen, Bewusstseinsänderung)? 10. Dokumentation (was, wann, wer – Kap. 10).

---

5. Gesetzliche Grundlagen: PflBG (Lernskript S. 4–5) – Bölüm K

§	Thema	Einfach erklärt
§ 1	Berufsbezeichnung	„Pflegefachfrau/-mann“ geschützt; staatliche Erlaubnis nötig
§ 4	Vorbehaltene Aufgaben	(1) Pflegebedarf erheben/feststellen + Pflege planen; (2) Pflegeprozess organisieren, gestalten, steuern; (3) Qualität analysieren, evaluieren, sichern, weiterentwickeln
§ 5	Ausbildungsziel	selbstständig, umfassend, prozessorientiert pflegen; fachliche, methodische, soziale, kommunikative Kompetenz; Selbstständigkeit/Selbstbestimmung fördern; ethisches Pflegeverständnis
§ 6	Dauer/Struktur	Vollzeit **3 Jahre**; theoretischer + praktischer Unterricht an der Pflegeschule + praktische Ausbildung

Achtung (Lernskript S. 5): Nicht jede Pflegetätigkeit ist vorbehalten – **die Durchführung einer bereits geplanten Maßnahme** gehört nicht automatisch zu den drei Aufgaben.

Arbeitsblatt-Situationen (S. 10) – Lösungsvorschlag: | Situation | Vorbehalten? | Begründung | |---|---|---| | PFK erhebt Pflegebedarf von Frau Berger | **Ja** | § 4 Nr. 1 | | PFK hilft beim Waschen nach bestehender Planung | **Nein** | Durchführung geplanter Maßnahme | | PFK steuert Prozess, passt Planung an | **Ja** | Nr. 2 | | PFK prüft Wirksamkeit/Qualität | **Ja** | Nr. 3 |

Impuls „Pflegekräfte führen nur ärztliche Anordnungen aus“ → *stimmt nicht*: eigenverantwortlicher Bereich (Pflegeprozess), daneben ärztlich *veranlasste* Maßnahmen (Delegation) und interprofessionelle Zusammenarbeit. (Begründung aus § 4/5.)

> ⚠ **Rechtshinweis (Bölüm K, 5):** Obige Inhalte stammen aus dem Lernskript. Ich konnte den Gesetzestext nicht online abrufen (gesetze-im-internet.de war im Sandbox nicht erreichbar). Bitte Wortlaut unter https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/ prüfen. Landesrecht, Schulcurriculum und Einrichtungsstandards können abweichen. **Keine Rechtsberatung.**

Weitere Kontextbegriffe (nur in anderen PDFs genannt): Garantenstellung & § 323c StGB → 08 Erste Hilfe; Schweigepflicht/Datenschutz, Arbeitsschutz (BGW, TRBA 250, ArbMedVV, IfSG) → 03 Hygiene; Praxisanleitung/Reflexion → Handlungskompetenz (personale Kompetenz). Delegation, Kompetenzbereiche der PflAPrV, Patientenrechte (§ 630a ff. BGB) sind **nicht** in Ihren PDFs → bei Bedarf separat lernen ⚠.

---

6. Prüfungswissen – Kurzfassung

- Drei Formen Pflege + Merkmale prof. Pflege · 4 Kompetenzbereiche + Beispiel · Bedürfnis/Problem/Ressource/Autonomie · 13 ABEDL **auswendig** · 6 Phasen **in Reihenfolge** · 3 Vorbehaltsaufgaben · § 1/4/5/6.

Häufige Fehler: Phasen vertauschen (Ziel vor Problem) · Evaluation vergessen · ABEDL als Diagnose benutzen · Durchführung = vorbehalten behaupten.

Merksätze: *„Informieren – Erkennen – Ziele – Planen – Tun – Prüfen.“*

Lernkontrolle (Lernskript S. 6 + eigene): Ek 5, Klausur 1

02 — Pflegerische Kommunikation, Berührung, Nähe & Distanz

> ← 01 Pflegeverständnis · 02b Pflegedeutsch-Dialoge → Kaynaklar: *Einstieg in die Unterrichtseinheit* (9.10.2025, S. 1–15) · *Fallbeispiel* (S. 1–2) · *Sequenz 2* (Fall Simon, S. 1–10) · *Sequenz 3* (S. 1–19) · *Sequenz 4* (Fall Johanna, S. 1–8) · *Sequenz 5* (S. 1–5) · *PPP Berührung AI 02/04/05* · *Arbeitsinput 06b Tabuzonen*. Alle Seitenangaben = PDF-Seiten.

---

1. Grundlagen: Was ist Kommunikation?

DE: Kommunikation = Austausch und Übertragung von Informationen, Verständigung untereinander (Einstieg S. 5). Nach I care (2020, S. 248): *„ein Prozess zum Austausch von Informationen zwischen einem Sender und einem Empfänger“* (S. 6).

TR: İletişim bilgi alışverişidir. Hemşirelikte ek olarak bir *temel insan ihtiyacı*dır; konuşmasak bile iletişim kurarız (S. 14).

1.1 Universalmodell nach Laswell (1948) (S. 7–8)

3 Elemente: **Nachricht – Sender – Empfänger**. Mind. 2 Personen; Rollen wechseln. Jeder Sender wird zum Empfänger. **Merke:** *Auch wer keine Antwort gibt, sendet etwas.*

1.2 Vier-Seiten-Modell (Schulz von Thun) (Einstieg S. 9–10; Sequenz 4 S. 3–6)

Seite (Sender „Schnabel“)	Leitsatz	Ohr (Empfänger)	Frage des Ohrs
Sachinhalt	„Darüber informiere ich dich“	Sachverhaltsohr	„Was willst du mir sagen?“
Selbstoffenbarung	„Das lasse ich dich über mich wissen“	Selbstoffenbarungsohr	„Wer und wie bist du?“
Beziehungshinweis	„So stehen wir zueinander“	Beziehungsohr	„Was denkst du über mich?“
Appell	„Ich möchte, dass du das tust“	Appellohr	„Was willst du von mir?“

Wichtig: Nur **ein** Ohr hört die Sachinformation; drei Ohren suchen Beziehung/Selbstoffenbarung/Appell – meist über Körpersprache und Tonfall (paraverbal). Gesendet ≠ empfangen → Konflikte (Sequenz 4 S. 5–6).

Praktisches Beispiel – Fall Johanna (Fallbeispiel S. 2): Patient: „Wie alt sind Sie überhaupt?“ – Johanna: „Alt genug!“ | Ohr | mögliche Deutung der Patientenfrage | |---|---| | Sache | Er möchte das Alter wissen | | Selbstoffenbarung | Er ist unsicher/ängstlich, hat Schmerzen (stöhnt) | | Beziehung | Zweifelt an Kompetenz („Sind Sie erfahren genug?“) | | Appell | „Bitte seien Sie vorsichtig mit mir / sagen Sie mir, wer mich pflegt“ |

Bessere Antworten (Alternativantworten, Sequenz 4 S. 7 – Vorschläge):

- „Ich bin im ersten Ausbildungsjahr. Meine Praxisanleiterin Silke ist die ganze Zeit dabei. Machen Sie sich Sorgen, dass etwas wehtun könnte?“ *(nimmt Beziehungs- und Appellseite ernst)*
- „Gute Frage – ich bin noch in der Ausbildung und lerne bei erfahrenen Kolleginnen. Ich sage Ihnen vorher, was ich mache.“

1.3 Axiome nach Watzlawick (Sequenz 3, S. 10–13)

#	Axiom	Kurz	Beispiel Pflege
1	*Man kann nicht nicht kommunizieren*	jedes Verhalten (Haltung, Seufzen, Schweigen) ist	Fall Simon: Bewohnerin schweigt, Renate sagt nichts → trotzdem

#	Axiom	Kurz	Beispiel Pflege
		Kommunikation	Botschaft
2	Inhalts- und **Beziehungsaspekt**; Beziehung bestimmt Inhalt	gelingt, wenn beide zusammenpassen	„Guten Abend“ ohne Blickkontakt = Beziehung kalt
3	**Ursache-Wirkung (Interpunktion/Verhaltenskette)**	jeder meint, der andere habe angefangen	Medikamente-Beispiel (S. 12): A: „Ich habe sie bereits gebracht“ → B hört Vorwurf
4	**Digital & analog**	digital = Sachinfo; analog = Gestik, Mimik, Tonfall (Beziehung)	„Mir geht’s gut“ + trauriger Blick
5	**Symmetrisch / komplementär**	gleichrangig (Augenhöhe) vs. hierarchisch	Kolleginnen vs. Pflegekraft–Patient im Bett

> Eselsbrücke (kendi önerim): **N-B-U-D-S** → *Nicht nicht, Beziehung, Ursache, Digital/analog, Symmetrie.*
> ⚠ Quelle nennt 5 Axiome; die Literatur kennt Interpunktion als Axiom 3 — gleiche Sache.

1.4 Verbal / nonverbal / paraverbal

Nonverbal (I care S. 249–251, Sequenz 3 S. 2–6): Körpersprache, **Mimik** (7 Grundemotionen: Freude, Ekel, Trauer, Angst, Überraschung, Wut, Verachtung), **Blickkontakt**, **Gestik**, **Körperhaltung**, **äußeres Erscheinungsbild**, **räumlicher Abstand**, **Körperkontakt**. Beobachtung = grundlegende pflegerische Aufgabe. Grenzen: Fehlinterpretation (Kultur, Erkrankung, z. B. eingeschränkte Mimik bei Parkinson ⚠ Beispiel von mir; Demenz → seltener Blickkontakt, S. 5). **Kongruent** = verbal und nonverbal stimmen überein; **inkongruent** = widersprüchlich (S. 15).

1.5 Kommunikationsstörungen & Feedbackregeln (S. 14)

Empfänger versteht falsch → **nachfragen** („Habe ich Sie richtig verstanden, dass …?“). Feedbackregeln: gegenseitiger Respekt · Kritik am **Verhalten**, nicht an der Person · **Ich-Botschaften** · konkrete Situation, **keine Allgemeinplätze** („immer“, „nie“, „schon wieder“, „man“) · Wünsche formulieren. | schlecht | besser | |---|---| | „Sie sind schlecht erzogen.“ | „Sie haben sich mir gegenüber im Ton vergriffen.“ | | „Du bist immer so langsam.“ | „Ich mache mir Sorgen, dass wir den Zeitplan nicht schaffen. Können wir kurz absprechen, wer was übernimmt?“ |

1.6 Formelle vs. informelle Kommunikation (Sequenz 5)

Formell: geplant, organisatorische Vorgaben/Regeln, offiziell, geschäftsmäßig/hochsprachlich (z. B. Übergabe, Dokumentation, Arztgespräch). **Informell:** zwanglos (Gespräch mit Kolleg:innen, Freunden; E-Mail/SMS/Telefon im lockeren Setting). *(Quelle: Vogler 2020)*

1.7 Akteure & Anlässe (Einstieg S. 12–13 – eigene Sammlung)

Akteure: Pflegeempfänger, Angehörige, Pflegende, Praxisanleitung, Ärzt:innen, Therapeut:innen, Sozialdienst, Hygienefachkraft, Betreuer:innen, Seelsorge. Anlässe: Aufnahme, Begrüßung, Körperpflege, Medikamentengabe, Schmerzerfassung, Beratung/Anleitung, Übergabe, Angehörigengespräch, Sterbebegleitung, Konflikt, Beschwerde, Notfall. *Warum wichtig?* Vertrauen, Sicherheit, Information, Beteiligung (Selbstbestimmung), Fehlervermeidung, Wohlbefinden.

---

2. Begrüßung, Schweigen, Gespräch eröffnen/beenden (Sequenz 2)

Kernaussagen (Mantz 2014, S. 2–4): *Wer spricht, pflegt bereits. Reden IST pflegen, Sprache IST wie Medizin.* Jedes Wort wirkt und lässt sich nicht zurücknehmen. **Qualität vor Quantität** der Gespräche. Schon die **Begrüßung** entscheidet über Vertrauen/Misstrauen der Pflegebeziehung. Pflegende tragen **mehr Verantwortung für das Gespräch** als Pflegeempfänger (S. 7).

Fall Simon (Fallbeispiel S. 1) – Analyse (Ereignis – Beurteilung – Konsequenz): | | Ereignis | Beurteilung | Konsequenz/Verbesserung | |---|---|---|---| | **Fall Maria/Eva** | Eva beschreibt alle Handlungen,

sorgfältig; Patient hilft mit; am Ende „Und jetzt noch den Popo!“ | **gut:** ankündigen/erklären, Ressourcen nutzen; **schlecht:** infantilisierend/„Popo“, Intimsphäre | „Jetzt wasche ich noch Ihren Intimbereich/Ihr Gesäß. Möchten Sie das selbst machen?“ | | **Fall Simon/Renate** | betritt Zimmer, kein Blick/Gespräch; Blutdruck, BZ, Füße; „Guten Abend … Auf Wiedersehen“; Bewohnerin schweigt | **schlecht:** keine Vorstellung, keine Erklärung, keine Einwilligung, Ton „Die redet nie“ | vorstellen, anklopfen, Fernseher leiser, erklären, Wahrnehmung (Hören? Depression? Aphasie?) abklären, Beobachtung melden | | **Fall Maria/Patient** | Patient hört nicht auf zu reden; Hand an Türklinke | nonverbal „ich will gehen“ wurde nicht verstanden; unhöflich | „Ich muss leider weiter. Wichtig ist mir noch … Wir besprechen den Rest morgen.“ | | **Fall Johanna** | s. §1.2 | – | s. o. |

Möglichkeiten der Begrüßung: Name nennen, Funktion, Anklopfen, Blickkontakt, ggf. Händedruck, Frage nach Befinden/Anrede (Wunsch: „Wie möchten Sie angesprochen werden?“).

Gründe zu schweigen (S. 6, eigene Hypothesen): Schüchternheit, Hör-/Sprachstörung (Aphasie), Depression, Demenz, Trauer, Kränkung, Scham, Misstrauen, Müdigkeit, kulturelle/ sprachliche Barriere, „Ich werde ja nicht gefragt“. **Handlungsalternativen:** Zeit lassen, offene Fragen, gemeinsames Schweigen aushalten, Sinneskanäle prüfen, Gegenstände (Nachtkästchen, Fotos) als **„Eisbrecher“** (S. 8), Beobachtung weitergeben.

Gespräch beenden (S. 9): Zusammenfassen, Dank, Ausblick („Ich komme um 14 Uhr wieder“), Redefluss höflich unterbrechen („Ich merke, wie wichtig Ihnen das ist. Ich muss jetzt zu … Darf ich später wiederkommen?“), Verabschiedung als **Beziehungsabschluss**.

---

3. Situationsorientierte Sprache & infantilisierende Sprache (Sequenz 3, S. 17)

DE: Formulierungen an **Person und Situation** ausrichten (Beispiel Intimpflege). **Infantilisierende Sprache** (Babysprache, „Wir“ statt „Sie“, „Popo“, „Schatz“, „Opi“) wertet ab und verletzt Würde. | unpassend | angemessen | |---|---| | „Und jetzt noch den Popo!“ | „Ich wasche jetzt Ihren Intimbereich. Möchten Sie das selbst übernehmen?“ | | „Na, haben wir schön gegessen?“ | „Hat es Ihnen geschmeckt?“ | | „Opi, jetzt Pillen!“ | „Herr Müller, es ist Zeit für Ihre Tabletten.“ | **Merksatz:** *Sprache ist wie Medizin – Dosis, Ton und Wirkstoff müssen stimmen.*

---

4. Berührung, Nähe & Distanz (LF 3a, T. Spingler, 13.10.2026)

4.1 Begriffe (AI 02, S. 3)

Begriff	Definition (DE)	TR
berühren	mit der Hand eine Verbindung/Kontakt herstellen	dokunmak (temas kurmak)
anfassen	mit der Hand berühren, ergreifen, befühlen	tutmak, ele almak
tasten	vorsichtig fühlende, suchende Bewegungen; wahrnehmen	el yordamıyla yoklamak
fühlen	mit Tastsinn/Nerven wahrnehmen, körperlich spüren	hissetmek

Zitat: *„Anfassen ist simpel, Berührung ist Kunst.“* (S. 5)

4.2 Pflege als Berührungsberuf (AI 04)

Berührung ist selbstverständlich in Blutdruckmessen, EKG, Körperpflege, Blutentnahme. Hände = **Werkzeug nonverbaler Kommunikation**. Bedeutung: **Sicherheit/Vertrauen** (bes. Demenz/Wahrnehmungsstörung), **Kommunikation** (Ruhe, Eile, Empathie, Stress), **Wohlbefinden**, **physische Wirkung** (Oxytocin → Bindung, weniger Stress). Berührung kann trösten, beruhigen, Angst reduzieren (S. 5–7). **Praxis (S. 8–9): Initialberührung** (Hand auf Schulter → Orientierung); bewusster **Beginn und Ende** der Pflegehandlung; **achtsame Körperpflege** (sanft/fest, **flächig statt Pinzettengriff**); „Gedanken in den Händen haben“; eigene Bedürfnisse beachten, ggf. Unterstützung. **Sicherheitsnetz:** Vorher ankündigen, Einverständnis erfragen, Reaktion beobachten (Mimik, Anspannung) → bei Ablehnung stoppen/anpassen.

4.3 Nähe & Distanz (AI 04 S. 11–13, AI 05)

Nähe/Distanz = emotionales, räumliches, soziales Verhältnis. Nähe → Zugehörigkeit, Vertrauen, Mitgefühl (Voraussetzung helfender Beziehung); Distanz → Gleichgewicht, **psychische Selbstfürsorge**. **Professionelle Beziehung:** Akzeptanz · Kongruenz/Echtheit · Empathie · Annehmen ohne Wertung → *Aufbau liegt bei der Pflegeperson* (AI 05 S. 2). **Balance finden (S. 3):** vertrauensvolles Klima · mit eigenen Gefühlen umgehen · empathisch sein · Gespräche nicht aufzwingen · nonverbale Zeichen beachten · behutsamer Körperkontakt.

4.4 Distanzzonen nach Edward T. Hall (AI 05 S. 4–5)

Quelle nennt nur vier Zonen (Arbeitsauftrag). **Zahlenwerte stehen nicht in Ihren PDFs** → ⚠ *externe Allgemeinkenntnis (bitte prüfen, z. B. karrierebibel.de, im PPP als Bildquelle genannt):* intime Zone (bis ca. 0,5 m), persönliche (ca. 0,5–1,2 m), soziale (ca. 1,2–3,6 m), öffentliche (> 3,6 m). Pflege arbeitet oft **in der intimen Zone** → deshalb: ankündigen, Erlaubnis, Sichtschutz, Kultur beachten (Kulturunterschiede verschieben Zonen). *Beispiel positiv/negativ:* Pflegekraft kündigt an „Ich komme jetzt näher, um den Verband zu wechseln" → Sicherheit; unangekündigtes Betreten/Entkleiden → Angst/Scham.

4.5 Tabuzonen (Morris) (Arbeitsinput 06b)

Auftrag: Welche Körperzonen sind für Sie unproblematisch? Unterschiede bei Beziehung (Fremde/Freunde/Familie) und Geschlecht? Prezi „Tabuzonen in der Pflege nach Morris" (extern, Link im PDF). Inhalt der Prezi **nicht** im PDF → Zonenmodell nach Morris ⚠ nicht ausgearbeitet; im Unterricht ergänzen.

---

5. Wichtige Fachbegriffe (Kommunikation)

Almanca	Türkçe	Erklärung / Beispiel
der Sender / der Empfänger	gönderen / alıcı	
die Nachricht, -en	mesaj	
der Sachinhalt	konu/içerik	Fakten
die Selbstoffenbarung	kendini açma	Emotion, Wert
der Beziehungshinweis	ilişki mesajı	
der Appell, -e	çağrı/istek	
verbal / nonverbal / paraverbal	sözlü / sözsüz / sesle ilgili (ton)	Tonfall = paraverbal
die Mimik, Gestik	mimik, jest	
die Körperhaltung	duruş	
kongruent / inkongruent	uyumlu / uyumsuz	
die Ich-Botschaft	ben-dili	„Ich mache mir Sorgen …"
nachfragen	tekrar sormak	
die Interpretation	yorum	≠ Beobachtung
infantilisierende Sprache	çocuklaştırıcı dil	
die Initialberührung	başlangıç dokunuşu	
die Intimsphäre	mahremiyet	
die Nähe / die Distanz	yakınlık / mesafe	
die Wertschätzung	değer verme	

6. Prüfungswissen & Fehler

- **Bei Fallanalyse immer: Ereignis (welche Infos, was beeinflusst) → Beurteilung (gut/schlecht) → Konsequenz** (Einstieg S. 4).
- Modelle **namentlich** nennen (Laswell, Schulz von Thun, Watzlawick, Hall) und **auf den Fall anwenden**.
- Fehler: Vier Seiten mit vier Ohren verwechseln · Mimik interpretieren als Fakt · „Schweigen = kein Bedarf" · Intimpflege ohne Ankündigung.

Merksätze: *Man kann nicht nicht kommunizieren. · Vier Schnäbel – vier Ohren. · Ankündigen, erklären, fragen, beobachten. · Anfassen ist simpel, Berührung ist Kunst.*

Lernkontrolle

1. Nenne die vier Seiten einer Nachricht und gib je ein Beispiel für „Ich bin müde“ (Pflegekraft zum Kollegen). 2. Erkläre Axiom 3 an einem Teamkonflikt. 3. Warum ist „Und jetzt noch den Popo“ problematisch? 4. Nenne drei Feedbackregeln. 5. Was bedeutet Initialberührung? 6. Wie unterbrichst du höflich einen sehr redseligen Patienten? → Lösungen: Ek 5 Klausur 2.

02b — Pflegedeutsch: Hasta ve ekip iletişimi (Bölüm D)

> ← 02 Kommunikation · 03 Hygiene → **Not:** Diyaloglar **eğitim amaçlı örneklerdir** (kendi hazırladığım metinler, PDF'lerde birebir yok). İçerik kaynaklara dayanır (Kommunikation, Sturz, Temperatur, Erste Hilfe). Gerçek hastada kurum standardı ve PFK/Praxisanleitung talimatı geçerlidir. Kısaltmalar: **P** = Pflegende/r, **Pat.** = Patient/in, **PFK** = Pflegefachkraft.

Genel kurallar: *Sie*-Form · Namen nennen · Konjunktiv II für Bitten („Könnten Sie …?“) · kurze Sätze · ankündigen, erklären, fragen · nachfragen („Haben Sie das verstanden?“) · kein Fachjargon, wenn es einfacher geht (Bluthochdruck statt Hypertonie).

D1 — Hastayı karşılama ve kendini tanıtma

DE

- P: *Guten Morgen, Frau Berger. Mein Name ist Selin Yılmaz, ich bin Auszubildende zur Pflegefachfrau und heute für Sie da. Darf ich hereinkommen?*
- Pat.: *Ja, bitte.*
- P: *Wie möchten Sie angesprochen werden – „Frau Berger“ oder anders?*
- Pat.: *Frau Berger ist gut.*
- P: *Gern. Heute begleitet mich meine Praxisanleiterin, Frau Weber. Wie geht es Ihnen im Moment?*

TR: Günaydın Bayan Berger. Adım Selin Yılmaz, hemşirelik stajyeriyim ve bugün sizinle ilgileniyorum. İçeri girebilir miyim? … Size nasıl hitap etmemi istersiniz? … **Wörter:** anklopfen (kapıyı çalmak) · sich vorstellen · die Praxisanleiterin · hereinkommen · die Anrede. **Grammatik:** *Darf ich + Infinitiv?* (Modalverb *dürfen*) · *Wie möchten Sie angesprochen werden?* (**Passiv** + Modalverb-Variante *möchten*). **Profi-Alternativen:** „Ich stelle mich kurz vor …“ · „Ich bin für Ihre Versorgung zuständig.“ **Prüfung:** „Beschreiben Sie, wie Sie einen neuen Pflegeempfänger begrüßen und begründen Sie die Bedeutung der Begrüßung.“ (Sequenz 2 S. 4: Vertrauen/Misstrauen).

D2 — Kimlik ve ihtiyaçları doğrulama

- P: *Bitte sagen Sie mir Ihren vollständigen Namen und Ihr Geburtsdatum.* (…bitte nicht nur „Sind Sie Frau Berger?“ fragen, sondern **offen** fragen lassen.)
- P: *Haben Sie Allergien? Brauchen Sie eine Brille oder ein Hörgerät?*
- P: *Was ist Ihnen im Alltag besonders wichtig? Was möchten Sie gern selbst machen?* **TR:** Tam adınızı ve doğum tarihinizi söyler misiniz? … Alerjiniz var mı? … Gözlük ya da işitme cihazı kullanıyor musunuz? … **Wörter:** das Geburtsdatum · die Allergie · die Sehhilfe/Hörhilfe · die Gewohnheit. **Gramm.:** Fragesatz mit Modalverb; *selbst* als Betonung. **Sinn:** Ressourcen- und Bedürfniserfassung (01 §1, §4). **Prüfung:** „Nennen Sie fünf Informationen, die Sie bei der Aufnahme erfragen.“ (z. B. Sturz in letzten 12 Monaten, Unsicherheit beim Gehen, Angst zu stürzen – Sturz-PPP S. 5).

D3 — Ağrı hakkında soru sormak

- P: *Haben Sie Schmerzen? Wo genau tut es weh?*
- Pat.: *Hier an der Hüfte.*
- P: *Wie fühlt sich der Schmerz an – stechend, dumpf, brennend? Wann ist er stärker – in Ruhe oder bei Bewegung? Auf einer Skala von 0 bis 10: Wie stark ist er jetzt?*
- P: *Danke, dass Sie das sagen. Ich gebe das an die zuständige Pflegefachkraft weiter.* **TR:** Ağrınız var mı? Tam olarak neresi acıyor? … 0–10 arasında şu an kaç? Bunu sorumlu hemşireye iletiyorum. **Wörter:** die Schmerzen (Pl.) · stechend, dumpf, brennend, ziehend · die Schmerzskala · in Ruhe / bei Belastung. **Karıştırma — Schmerzen haben / äußern:** *haben* = der Patient empfindet; *äußern* = er sagt/zeigt es (verbal/nonverbal). Dokumentation: „Pat. äußert Schmerzen im rechten Hüftbereich (NRS 6)“ – nicht „Pat. hat starke Schmerzen“ (zu wertend, wenn nur beobachtet). ⚠

NRS-Skala PDF'lerde yok, genel bilgi. **Not:** Analgetika/Dosis → **ärztliche Anordnung**, öğrenci karar vermez.

D4 — Yaşamsal bulguları ölçmeden önce açıklama

- P: *Frau Berger, ich möchte jetzt Ihre Temperatur messen. Das geht im Ohr und dauert nur wenige Sekunden. Ist das in Ordnung für Sie?*
- P: *Danach messe ich noch Blutdruck und Puls. Bitte entspannen Sie den Arm und sprechen Sie nicht.* **TR:** Şimdi ateşinizi ölçmek istiyorum. Kulaktan yapılır, birkaç saniye sürer. Uygun mu? … **Wörter:** die Körpertemperatur · aurikulär/axillar/rektal · der Blutdruck · der Puls · entspannen. **Gramm.:** Imperativ-Höflichkeit „Bitte + Imperativ“; *danach/anschließend* (Temporaladverb). **Fachlich (Thieme S. 11, 13–14):** Informieren über Indikation und Durchführung; nicht direkt nach Anstrengung; Schutzkappe/Hygiene; Ergebnis, Zeit, Ort dokumentieren.

D5 — Mobilizasyona yardım

- P: *Ich helfe Ihnen jetzt beim Aufstehen. Rutschen Sie bitte langsam an die Bettkante. Stellen Sie die Füße fest auf den Boden. Auf drei stehen wir gemeinsam auf. Eins, zwei, drei.*
- P: *Wie fühlt sich das an? Ist Ihnen schwindelig?* – Pat.: *Ein bisschen.* – P: *Dann setzen wir uns noch einen Moment hin.* **TR:** Kalkmanıza yardım edeceğim. Yavaşça yatağın kenarına gelin … Başınız dönüyor mu? **Wörter:** die Bettkante · aufstehen · der Schwindel · der Transfer · die Gehhilfe/der Rollator · die Bremse. **Grammatik:** Imperativ (*rutschen Sie*, *stellen Sie*) · reflexiv *sich hinsetzen* · Nebensatz *ob*. **Sicherheit (Sturz-PPP S. 12):** Bremsen schließen, rutschfeste Schuhe, Weg frei. Bei Schwindel nicht weitergehen, PFK informieren, Blutdruck kontrollieren lassen. **Prüfung:** „Beschreiben Sie, wie Sie eine sturzgefährdete Person beim Aufstehen unterstützen.“ (Ressourcen: Eigenaktivität erhalten.)

D6 — Kişisel hijyen ve mahremiyet

- P: *Ich möchte Ihnen beim Waschen helfen. Würden Sie lieber selbst Ihr Gesicht und die Arme waschen? Ich übernehme dann den Rücken. Ich decke Sie nur an der Stelle auf, die ich wasche.*
- P: *Für den Intimbereich gebe ich Ihnen den Waschlappen. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie bitte Bescheid.*
- Pat. (verlegen): *Es ist mir unangenehm.* – P: *Das verstehe ich. Wir gehen so vor, wie es für Sie gut ist.* **TR:** Yıkanmanıza yardım etmek istiyorum. Yüzünüzü ve kollarınızı kendiniz yıkamak ister misiniz? Sadece yıkadığım bölgeyi açacağım … **Wörter:** der Waschlappen · die Intimsphäre · aufdecken/zudecken · verlegen sein · unangenehm. **Gramm.: Konjunktiv II** (*würden Sie lieber …?*, *könnten Sie …?*) für höfliche Bitten/Angebote; *nur … die Stelle, die …* (Relativsatz). **Merke:** *Nicht „Popo“ – „Intimbereich/Gesäß“* (02 §3). Fall Herr Schneider: lehnt zunächst Waschen ab, weil unangenehm → Scham respektieren, Alternativen anbieten, später erneut anbieten.

D7 — Doktora değişiklik bildirimi (SBAR)

SBAR (Übergabeformat in Folie 164/189 Erste Hilfe): **S**ituation – **B**ackground – **A**ssessment – **R**ecommendation.

- P (Telefon): *Guten Tag Dr. Schulz, hier Pflegefachkraft/Auszubildende Yılmaz, Station 3.* ***Situation:*** *Bei Herrn Schneider, Zimmer 12, ist die Temperatur seit heute Morgen von 37,2 auf 38,6 °C gestiegen.* ***Hintergrund:*** *78 Jahre, gestern Hüft-OP, wenig getrunken.* ***Einschätzung:*** *Er schwitzt, ist unruhig und hat Puls 104.* ***Empfehlung:*** *Ich bitte um ärztliche Beurteilung und Anordnung. Ich messe in 30 Minuten erneut.* **TR:** Dr. Schulz, ben … 12 numaralı odada Bay Schneider'in ateşi sabahtan beri 37,2'den 38,6 °C'ye yükseldi … Doktor değerlendirmesi ve talimat rica ediyorum. **Wörter:** die Anordnung · die Verschlechterung · der Zustand · die Einschätzung · informieren/benachrichtigen. **Gramm.: Perfekt** (*ist gestiegen*), **Präsens** für Befund; objektive Zahlen statt „sehr heiß“. *(Beispielwerte fiktiv.)* **Prüfung:** „Wann informieren Sie den Arzt?“ → bei Verschlechterung, Bewusstseinsveränderung, Fieberdelir, schweren Schüttelfrost (Thieme S. 34–36), neuen Notfallzeichen. **Fehler:** Interpretation statt Messwerte; Vorname/Zimmer vergessen; kein „Was soll ich tun?“

D8 — Vardiya devri (Übergabe)

- P1: *Zimmer 5, Frau Berger, 78, Z. n. Sturz, Schmerzen rechte Hüfte, NRS 4 nach Schmerzmittel um 7:30 Uhr laut Anordnung. Mobilisation mit Rollator und Begleitung, einmal Schwindel beim Aufstehen, Blutdruck anschließend unauffällig. Hat zwei Gläser getrunken, Trinkprotokoll läuft. Tochter kommt um 15 Uhr. Offen: Brille von zu Hause bringen lassen.* **TR:** 5 numaralı oda, Bayan Berger, 78, düşme sonrası … **Wörter:** die Übergabe · Z. n. (Zustand nach) · laut Anordnung · unauffällig · offen. **Gramm.:** Nominalstil/Kurzsatz (ohne Verb), Ellipsen sind in Übergaben üblich; Zeitangaben. **Gerçekleşmeyen işlemi „yapıldı“ gibi söylemeyin** (10).

D9 — İlaçlarla ilgili hasta sorusu

- Pat.: *Wofür ist diese Tablette?*
- P: *Das ist eine Frage, die ich nicht allein beantworten darf/kann. Ich frage die zuständige Pflegefachkraft oder den Arzt und komme gleich mit der Antwort zurück.* **TR:** İlaçla ilgili bu soruya tek başıma cevap verememem; sorumlu hemşireye/doktora soruyorum … **Wörter:** die Tablette · die Nebenwirkung · die Anordnung · zuständig · zurückkommen. **Wichtig:** Auszubildende **geben keine** medizinischen Auskünfte/Dosierungen auf eigene Faust; Information und Ablehnungsrechte des Patienten → PFK/Arzt. (Pflege-Mikroschulung nur im Rahmen der Anleitung – Erwartungshorizont S. 4.)

D10 — Anlaşılmayan talimatı netleştirme (Pflegende → Anleiterin)

- P: *Entschuldigung, Frau Weber, ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie meinen, ich soll Frau Berger erst nach dem Frühstück mobilisieren? Könnten Sie mir bitte zeigen, worauf ich dabei achten soll?* **TR:** Pardon, sizi doğru anlayıp anlamadığımdan emin değilim … **Gramm.:** *ob*-Nebensatz; indirekte Frage; Konjunktiv II (*Könnten Sie …*). **Merke:** Nachfragen ist **professionell**, nicht schwach (Feedbackregeln, Sequenz 3 S. 14).

D11 — Hata, risk veya acil durum bildirimi

Hata/Risk: *Ich habe bemerkt, dass ich bei Herrn Schneider vergessen habe, die Bettbremse festzustellen. Es ist nichts passiert, aber ich möchte es melden.* — Fehler offen, sachlich, ohne Schuldzuweisung (Fehlerkultur) ⚠ Konzept nicht in PDFs; Berichtsweg = Einrichtungsstandard. **Sturz (Sturz-PPP S. 13):** *Frau Berger ist gestürzt! Bitte kommen Sie sofort in Zimmer 5!* → beruhigen, 2. Person rufen, nicht allein bewegen, Verletzungen beachten, Puls/RR, **Sturzprotokoll**, Angehörige/Arzt informieren. **Reanimation (EH):** *Hilfe! Herr X reagiert nicht und atmet nicht normal! Rufen Sie das Reanimationsteam/112 und bringen Sie den Defibrillator!* (08). **Wörter:** der Notfall · alarmieren · das Reanimationsteam · reagieren · normal atmen · der Defibrillator.

D12 — Hasta yakını ile görüşme

- P: *Guten Tag, Frau Berger-Klein. Ich darf Ihnen aus Datenschutzgründen keine Auskünfte zum Gesundheitszustand geben, solange Ihre Mutter dem nicht zugestimmt hat. Ich frage sie gern. Möchten Sie in der Zwischenzeit etwas wissen zum Besuch, z. B. zu den Besuchszeiten?* **TR:** Veri koruma nedeniyle annenizin onayı olmadan sağlık durumu hakkında bilgi verememem … **Wörter:** der Datenschutz · die Schweigepflicht · die Einwilligung · die Angehörigen (Pl.). ⚠ **Hukuki not:** Schweigepflicht/Datenschutz PDF'lerde yalnızca kavram olarak anılır; ayrıntı için okul/kurum standardı ve resmî kaynak.

Sınav simülasyonu (mündlich) – örnek soru dizisi

1. Stellen Sie sich einer Patientin vor und kündigen Sie die Ganzkörperwaschung an. 2. Sie bemerken Fieber 38,6 °C – was tun Sie, wen informieren Sie? 3. Ein Patient redet nicht auf Ansprache – Erste-Hilfe-Schritte? 4. Erklären Sie dem Angehörigen, warum Sie keine Auskunft geben. **Bewertung:** Struktur, Höflichkeit (Konj. II), Fachbegriffe, Sicherheit, Grenzen der eigenen Kompetenz.

03 — LF 3a: Hygiene, Infektionen, Infektionsschutz (Arbeitsschutz)

← 02b Dialoge · 04 Haut → Kaynaklar: *Hyg. Grundlagen Teil I* (4.11.2025, Rech/Wein/Alt, 21 S.) · *Teil II Infektionen* (24 S.) · *Handout Grundlagen hygienischen Handelns* (Saarbrücken 13.04.2022, 10 S.) · *Übung Händedesinfektion* (Pflegias/Cornelsen, 2 S.) · *BGW Take Care – Infektionsschutz* (Stand 09/2018, S. 1–20 ausgewertet). PDF-Seitenzahlen. Teil I = „T1“, Teil II = „T2“, Handout = „H“.

1. Hygiene – Begriff und Teilbereiche

DE: Hygiene = Lehre von der **Erhaltung und Förderung der Gesundheit**; umfasst alle Maßnahmen, die Gesundheit und Wohlbefinden sichern; **Vermeidung/Bekämpfung von Infektionskrankheiten** (T1 S. 2). Name: Göttin *Hygieia*. **TR:** Hijyen, sağlığı koruma ve geliştirme bilimi; enfeksiyonları önleme dahil.

Teilbereich	Inhalt (T1 S. 3)
Persönliche Hygiene	Körperpflege, Sauberkeit
Psychohygiene	seelische Gesundheit
Umwelthygiene	Luft, Wasser, Boden
Sozialhygiene	Gesundheit und soziales Umfeld
Krankenhaushygiene	Infektionen in Kliniken verhüten/bekämpfen

Ziel pflegerischer Hygiene: Kontakt mit schädlichen Mikroorganismen vermeiden und Keimzahl so reduzieren, dass kein Schaden entsteht (T1 S. 4).

2. Infektion: Begriffe & Übertragungswege

Begriff	Erklärung	TR
Kolonisation	Erreger besiedeln Haut/Schleimhaut/Wunden/Sekrete, **lösen keine Symptome aus** (T2 S. 3)	kolonizasyon (taşıyıcılık)
Infektion	Erreger dringen ein, vermehren sich, **Abwehrreaktion**	enfeksiyon
endogen	Erreger **schon im Körper** (Darm-/Hautkeime), wechseln Standort (z. B. E. coli Darm → Blut) (T1 S. 5/7)	endojen
exogen	Erreger **von außen** (Menschen, Gegenstände, Tiere)	eksojen
direkt	Kontakt (Hände), Tröpfchen, aerogen (Tröpfchenkern ca. 5 µm, z. B. Tbc) (H S. 1)	doğrudan
indirekt	über **Zwischenträger**: Staub, Wasser, Gegenstände, Lebensmittel, Flächen, Kleidung, Akten, Personen, Vektoren (Insekten) (H S. 1)	dolaylı
nosokomial	im Krankenhaus/Pflegeheim erworben; häufig Katheterinfektionen (Harnwege, Venen), Pneumonie, Wundinfektionen (T1 S. 8)	hastane kökenli

Eintrittspforten (T1 S. 7, Bild 3): urogenital (Harntrakt) · intrauterin (Plazenta) · perkutan (Haut) · perkutan/permukös (Schleimhaut) · inhalativ (Atemwege). **Erreger:** Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten (T2 S. 2). **Exogene Risiko (H S. 2):** invasive Maßnahmen (z. B. Katheter), Länge ICU-Aufenthalt.

Größter Risikofaktor/Hauptübertragungsweg: die Hände (T1 S. 9; BGW S. 7).

3. Persönliche Hygiene der Pflegenden (T1 S. 9)

Maßnahme	Begründung
Körper/Kleidung sauber	Schmutz → Keime
nur Dienstkleidung, desinfizierend gereinigt oder **95 °C**	hohe Temperatur tötet Erreger

Maßnahme	Begründung
Hand-/Unterarmschmuck ablegen	nur dann gründliche Reinigung/Desinfektion möglich
Nägel kurz, sauber, **kein Lack/Kunstnägel**	BGW/TRBA 250 Nr. 4.1.7: kurz, rund, Fingerkuppe nicht überragen (BGW S. 8)
Hände waschen/desinfizieren vor Arbeit, nach Toilette	Hände = Hauptübertragungsweg
Wunden an Händen/Armen verbinden	Wunden können besiedelt sein
Husten/Niesen: Abstand, abwenden	Tröpfchen

BGW S. 8: auch Ringe/Eheringe, Armbanduhren, Piercings, Freundschaftsbänder.

4. Händehygiene (T1 S. 14–19; H S. 5–7; BGW S. 7–9)

Drei Schritte: Hände waschen – desinfizieren – pflegen.

- **Waschen nötig:** vor Dienstbeginn, bei sichtbarer Verschmutzung, nach Toilettengang, nach Niesen/Husten/Naseputzen (T1 S. 14).
- **FAZIT H S. 7:** *Unnötiges Händewaschen vermeiden, Händedesinfektion bevorzugen* (Haut schonen).
- **Ausnahme Clostridioides difficile (H S. 8, Pflegias S. 534):** Sporenbildner → übliche HD-Mittel wirkungslos → **Schutzkleidung + Desinfektion UND gründlich waschen** (mechanisch entfernen). Hinweisschild am Zimmer.

4.1 Die fünf Momente der Händedesinfektion (WHO) (T1 S. 17)

1. **Vor** Patientenkontakt · 2. **Vor aseptischen Tätigkeiten** (Injektion, Infusion, Wundversorgung) · 3. **Nach** Kontakt mit **infektiösem Material** (Blut, Sekrete, Ausscheidungen) · 4. **Nach** Patientenkontakt · 5. **Nach Kontakt mit der Patientenumgebung**. *Eselsbrücke (kendi önerim):* **V-A-I-N-U** → *Vor Patient · Aseptisch · Infektiös · Nach Patient · Umgebung.* BGW S. 7 ergänzt: bei Arbeitsbeginn, vor Umgang mit Lebensmitteln, nach Toilette, **auch wenn Handschuhe getragen wurden**.

4.2 Hygienische Händedesinfektion – richtig (BGW S. 8)

Schmuck ab · Hände **trocken** (kein Verdünnungseffekt) · **ausreichend Menge** in die Hohlhand · **alle Bereiche feucht halten** · **Einwirkzeit ≥ 30 Sekunden** (Herstellerangaben!) · auch nach Handschuhen · ggf. zwischen Arbeitsschritten. **6 Schritte** (T1 S. 15, I care): ① Handfläche auf Handfläche ② rechte Handfläche über linkem Handrücken und umgekehrt ③ Handflächen mit verschränkten Fingern ④ Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handfläche (verschränkt) ⑤ kreisendes Reiben der Daumen ⑥ kreisendes Reiben der Fingerkuppen in der Handfläche. **Benetzungslücken (H S. 6):** häufig **Daumen und Fingerkuppen**, Fingerzwischenräume → Standard einhalten.

Experiment (Übung): Farbe + Handschuhe + verbundene Augen → Skizze der Benetzungslücken; Nachbereitung: a) Händehygiene/-desinfektion definieren, b) wann HD, wann Waschen, c) Ablauf + besondere Hautbereiche, 2) Abgleich der Skizzen (Pflegias S. 533–538, 120 Min.).

4.3 Hautschutz (H S. 6–7; T1 S. 19; BGW S. 9)

Intakte Haut = Barriere. **Gefahren:** Tenside in Seifen trocknen aus; Duftstoffe reizen; **langes Handschuhtragen** → Haut quillt auf; HD-Mittel auf vorgeschädigter Haut → Brennen/Rötung. **Maßnahmen:** erbsengroße Handcreme (Handrücken → Verteilen); **im Dienst schnell einziehend, nach Dienst reichhaltig**; Rückfetter in HD-Mitteln ersetzen keine Hautpflege; bei Hautproblemen **Betriebsarzt**. Ursachen Hautreaktionen: Allergie, Waschen vor HD, nasse Hände bei HD, zu häufiges Waschen, mangelnde Pflege, langes Handschuhtragen (H S. 7).

5. Handschuhe & Schutzkleidung

- **Vor jedem Griff in die Handschuhbox → hygienische Händedesinfektion** (H S. 9).

- **Ausziehen:** vom Handgelenk abwärts (Haut nicht berühren), auf links drehen, ineinander ziehen, sofort entsorgen, **dann HD**. **Handschuhe ersetzen nie die HD** (Mikroperforationen, Kontamination beim Ausziehen).
- **Schutzkleidung (T2 S. 19; BGW S. 9):** schützt Pflegende **und** Patienten; **patientenbezogen**, zwischen Patienten wechseln; muss alle Stellen bedecken, die kontaminiert werden könnten; **Kontamination nicht immer sichtbar**; vom Arbeitgeber gestellt/gereinigt; **nicht zum Waschen nach Hause mitnehmen**.
- **Arbeitshygiene (T1 S. 20):** Hygienestandards, Instrumente/Handschuhe (z. B. Verbandwechsel), Berufs-/Schutz-/Bereichskleidung nach Hygieneplan, sachgerechte Entsorgung. *Wer sich selbst schützt, schützt auch andere.*

6. Keimreduktion: Reinigung – Desinfektion – Sterilisation (T1 S. 11–13)

Verfahren	Wirkung	TR
Reinigung	entfernt sichtbaren Schmutz und **bis zu 80 %** der Keime	temizlik
Desinfektion	tötet **die meisten** Krankheitserreger → keimarm, **nicht keimfrei** (Hände-, Haut-/Schleimhaut-, Flächen-, Instrumenten-/Gerätedesinfektion)	dezenfeksiyon
Sterilisation	vernichtet **alle** vermehrungsfähigen Mikroorganismen → **keimfrei**	sterilizasyon

Flächendesinfektion: Was? Einwirkzeit? Welche Keime (Bakterien/Viren/Parasiten)? Nicht jedes Mittel passt überall → **Hygieneplan/Desinfektionsplan** (Mittel, Konzentration, Einwirkzeit, wer, wann); Handschuhe, bei Konzentraten Schutzbrille; Gefahrstoffverordnung/Betriebsanweisung. Beispiel-Plan T1 S. 13 (SHG Sonnenberg): Flächen desinfizierend reinigen, **nicht nachtrocknen**, Norovirus: längere Einwirkzeit ⚠ (Zahlen aus OCR unsicher, Plan der Einrichtung gilt).

7. Entzündung (T2 S. 4–13; Haut Teil 2 S. 7)

5 klassische Zeichen: **Rötung (Rubor) · Schwellung (Tumor) · Überwärmung (Calor) · Schmerz (Dolor) · Funktionseinschränkung (Functio laesa)**. *Warum?* Gefäßweitstellung (mehr Blut → Rötung/Wärme), Durchlässigkeit → Flüssigkeit (Schwellung → Druck auf Nerven = Schmerz) → eingeschränkte Funktion. ⚠ Erklärung ist Allgemeinwissen (Aufgabe im PDF offen). Beispiel im PDF: Panaritium (Nagelbettentzündung, T2 S. 12). **Infektion vs. Entzündung:** Infektion = Erreger dringen ein; **Entzündung = Reaktion des Gewebes** (kann auch ohne Erreger, z. B. Verletzung).

8. Multiresistente Erreger (MRE) (T2 S. 16–17; BGW S. 10–11)

- **MRE** = gegen mehrere Antibiotika resistent; Ursache: unüberlegter Antibiotikaeinsatz.
- **MRSA** (Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*); VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken); **ESBL** (T2: „Enterokokken“ ⚠ → richtig: Enterobakterien mit Extended-Spectrum-β-Laktamasen, siehe 00 §4); **MRGN** (2/3/4 von 4 Antibiotikagruppen unwirksam, BGW S. 11).
- **MRSA-Träger:** Nasenvorhof, Rachen, Achseln, Leiste; viele symptomfrei; Hauptübertragung **Hände**; Risiko: Katheter, chronische Wunden, immungeschwächte (BGW S. 10).
- **Risikofaktoren (T2 S. 17):** schwer krank, immobil, Alter (sehr jung/hoch), Hautverletzungen (Dekubitus, Wunden), invasive Maßnahmen, häufige Klinik-/Heimaufenthalte, Kontakt zu MRE-Trägern, wiederholte Antibiotikatherapien.
- Patienten/Besucher zur HD anleiten senkt nosokomiale Infektionen (> 50 %, BGW S. 10).

9. Arbeitsschutz & Berufskrankheiten (BGW 2018)

Thema	Kernpunkte (BGW)
Nadelstichverletzung (NSV)	jede Stich-/Schnitt-/Kratzverletzung durch kontaminierte Instrumente, **egal ob blutend** (TRBA 250 Nr. 2.8); 50–75 % betreffen Pflegekräfte; Risiko nach NSV: **HBV ~30 %, HCV ~3 %, HIV ~0,3 %** (S. 4)
Ursachen	Stress, enge Räume, Instrumente nicht sofort entsorgt, überfüllte Abwurfbehälter, **Recapping** (S. 5)
Prävention	ruhiges Arbeiten, **Sicherheitsgeräte**, **sofortige Entsorgung** durch den Anwender in geeignete Behälter, nicht überfüllen (S. 6–7)

Thema	Kernpunkte (BGW)
Sofortmaßnahmen (Leitfaden S. 20)	Blutfluss fördern, intensive Desinfektion (Wunde) bzw. intensive Spülung mit Wasser/NaCl (Schleimhaut/Auge) → **sofort Arzt/Durchgangsarzt**, Risiko HBV/HCV/HIV klären, **HIV-PEP innerhalb 2 Std.**, HBV-Immunisierung, Meldung BGW/Unfallkasse, Nachsorge Betriebsarzt, **dokumentieren**
Fall Johanna (BGW S. 18, 23)	Reaktionen A–D (nur spülen/Pflaster; Quetschen durch Kollegin; Pflaster + Betriebsärztin; nur Hautdesinfektion) – **keine vollständig korrekt**; richtig: Blutfluss fördern/spülen/desinfizieren **und** Arzt/Meldung/Dokumentation. Hinweis: Der Leitfaden nennt „Blutfluss fördern“ als erste Sofortmaßnahme; eine Musterlösung steht im PDF (S. 19–20) nur als Leitfaden – Reaktionen B, C und D sind jeweils unvollständig (Desinfektion/Spülung, ärztliche Abklärung, Meldung fehlen teils)
Impfung	Hep-B-Impfung Teil der arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Angebot Pflicht (S. 5)
Tuberkulose	aerogen (Tröpfchen/Aerosol); **FFP2** bei ansteckenden Kranken; Angebotsvorsorge nach Kontakt (S. 12)
Skabies	Milben; Symptome nach 2–5 Wochen (Juckreiz nachts); schon vorher ansteckend; Handschuhe+Kittel; HD/Waschen **keine** sichere Prophylaxe; Meldung Gesundheitsamt ab ≥ 2 Fällen im Zusammenhang (§ 36 IfSG) (S. 13)
Rechtliche Orientierung	ArbSchG, MuSchG, JArbSchG, IfSG, DGUV Vorschrift 1, ArbMedVV, BioStoffV, TRBA 400/250/460/462/464/466 (S. 14)
Mut zum Ansprechen	Kolleg:innen auf Hygienemängel hinweisen (S. 14)

⚠ *Nicht Rechtsberatung.* Jugendliche/Schwangere: besondere Schutzvorschriften (S. 3). Aktuelle Regelungen: RKI, KRINKO, BGW, IfSG, Einrichtungsstandards (T2 S. 15).

10. Fachbegriffe (Auswahl)

Almanca	Türkçe	Anm.
die Hygiene	hijyen	
der Keim, -e / der Erreger, -	mikrop / etken	
die Händedesinfektion (HD)	el dezenfeksiyonu	
das Händewaschen	el yıkama	
die Einwirkzeit	etki süresi	
die Benetzungslücke, -n	ıslatılmamış alan	
die Schutzkleidung	koruyucu giysi	
die Standardhygiene	standart hijyen	LISA/Pneumonie: konsequent
der Hygieneplan	hijyen planı	
die Hygienefachkraft	hijyen uzmanı	Ansprechperson
die Nadelstichverletzung	iğne batması yaralanması	
die Postexpositionsprophylaxe (PEP)	maruziyet sonrası profilaksi	
nosokomial	hastane kaynaklı	
die Kolonisation	kolonizasyon	
multiresistent	çoklu dirençli	
die Sporen (Pl.)	sporlar	C. difficile
die Entzündung	iltihap	**≠ Infektion**
die Schmierinfektion/Kontaktübertragung	temasla bulaş	

Karşılaştırma (Bölüm C): ***Infektion ↔ Entzündung*** · *Kolonisation ↔ Infektion* · *Reinigung ↔ Desinfektion ↔ Sterilisation* · *Händewaschen ↔ Händedesinfektion* · *endogen ↔ exogen*.

11. Pflegepraxis / Prüfungswissen / Fehler

- **Wann HD, wann waschen?** HD = Standard (Patientenkontakt etc.); Waschen = sichtbar schmutzig, Toilette, Niesen, **C. diff** zusätzlich.

- „Beschreiben Sie den Ablauf der HD und nennen Sie 3 Benetzungslücken“ → Daumen, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume.
- **Fehler:** Handschuhe statt HD · nasse Hände desinfizieren · Schmuck/Uhr · Waschen **vor** HD · Handschuhbox mit ungewaschenen Händen · Schutzkittel mehrere Patienten.
- **Merksätze:** *Hände = Hauptübertragungsweg.* · *Handschuhe ersetzen keine HD.* · *Nur gepflegte Haut ist geschützte Haut.* · *Wer sich selbst schützt, schützt andere.*

Lernkontrolle: 1) Definiere nosokomiale Infektion. 2) Nenne die 5 Momente. 3) Unterschied Reinigung/Desinfektion/Sterilisation? 4) Warum nach Handschuhen HD? 5) Warum bei C. difficile zusätzlich waschen? 6) Was tust du nach NSV? → Ek 5, Ek 4.

04 — LF 3a: Zelle, Gewebe, Haut und Hautveränderungen

← 03 Hygiene · 05 Körpertemperatur → Kaynaklar: *Skript Haut Teil 1: Zelle und Gewebe* (4 S.) = „T1“ · *Skript Haut Teil 2: Haut und Hautveränderungen* (J. Schneider, 10 S.) = „T2“. PDF-Seiten.

1. Zelle (T1 S. 1–2)

DE: Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens (Stoffwechsel, Wachstum, Bewegung, Signalweiterleitung, Vermehrung, Vererbung). Bestandteile: **Zellmembran, Zytoplasma, Zellkern**. Keine Zellkerne: **Erythrozyten** und **Thrombozyten**. **TR:** Hücre yaşamın en küçük birimidir. Çekirdeği olmayan hücreler: alyuvarlar (eritrosit) ve trombositler.

Organelle	Aufgabe	TR
Zellmembran	Abgrenzung, Schutz, selektiver Stoffaustausch, Kommunikation	hücre zarı
Zellkern (Nukleus)	Steuerzentrale, DNS	çekirdek
Mitochondrien	Energie (ATP) – „Kraftwerke“: Glukose + O_2 → ATP + H_2O + Wärme + CO_2 = **innere Atmung**	mitokondri
Ribosomen	Proteinproduktion	ribozom
Lysosomen	Abbau/Verdauung von Abfall	lizozom
ER (rau/glatt)	Stofftransport; raues: Protein, glattes: Fett	endoplazmik retikulum
Golgi-Apparat	Verarbeiten/Sortieren/Transport von Proteinen	golgi
Zentrosomen	Zytoskelett, Zellteilung	sentrozom

Zellzyklus: Wachstum → Teilung → Differenzierung → **Apoptose** (programmierter Zelltod). **Mitose** (Körperzellen): 1 Mutterzelle → **2** identische Tochterzellen; Wachstum, Reparatur, **Wundheilung**. **Meiose** (Keimzellen): → **4** nicht identische; nur in Keimdrüsen (Eierstöcke/Hoden). **Merke:** *Mitose = Mehr (2, gleich) · Meiose = Mix (4, verschieden).* (kendi önerim)

2. Gewebe (T1 S. 3–4)

Gewebe = spezialisierte Zellen + **extrazelluläre Matrix**. Ordnung: Zelle → Gewebe → Organ → Organsystem → Organismus. 4 Grundgewebe: **Epithel · Bindegewebe (mit Fett- und Stützgewebe: Knorpel, Knochen) · Muskel · Nerv.** Haut = v. a. Epithel + Bindegewebe + Fettgewebe. | Gewebe | Kernpunkte | |---|---| | **Epithel** | Grenzflächen, bedeckt Organe; **keine Blutgefäße** (Ernährung per Diffusion); Barriere; Sekretion/Aufnahme; Sinnesfunktion | | **Bindegewebe** | Form/Halt, verbindet, füllt Zwischenräume; speichert Wasser/Fett; Abwehr, **Wundheilung**; Nährstofftransport |

3. Haut: Aufbau & Funktion (T2 S. 1–5)

Größtes Organ (ca. 1,5–2 m²). **Funktionen:** Schutz · Temperaturregulation · Reizwahrnehmung (Sinnesorgan) · Immunfunktion · Energie-/Wasserspeicher · **Vitamin-D-Produktion**; weitere: Kommunikation/Berührung, Emotion („Spiegel der Seele“), 1–2 % Gasaustausch, Identität/Selbstwert. **Hautarten: Leistenhaut** (≈ 4 %, Hand-/Fußflächen, Furchenmuster, Schweißdrüsen, unbehaart) · **Felderhaut** (≈ 96 %, dünner, behaart, Talg- und Schweißdrüsen).

Schicht	Aufbau/Zellen	Funktionen
Oberhaut (Epidermis)	verhornendes Plattenepithel, **gefäßlos**; Keratinozyten (Horn), **Melanozyten** (Pigment/UV), **Langerhans-Zellen** (Immun), **Merkelzellen** (Berührung)	Wasserbarriere, UV-Schutz, **Säureschutzmantel pH 5,5**, mechanischer Schutz
Lederhaut (Dermis)	Bindegewebe mit Kollagen/Elastin; Gefäße, Nerven/Rezeptoren (Druck, Berührung, Temperatur, Schmerz), Talg-/Schweißdrüsen, Haarwurzeln	Festigkeit, Elastizität, Versorgung der Epidermis, Wasserspeicher

Schicht	Aufbau/Zellen	Funktionen
Unterhaut (Subkutis)	Fettgewebe (Bau-/Depotfett), Gefäße, Nerven; **Vater-Pacini-Körperchen** (Vibration)	Isolierung, Polster/Verschiebeschicht, Energiespeicher

Temperaturregulation (T2 S. 3): Ziel 37 °C Kern; **Hypothalamus**. Kälte: Zittern, Haaraufrichtung, **Vasokonstriktion**, Fettisolation · Wärme: **Vasodilatation**, Schwitzen. → 05. **Schleimhäute (T2 S. 4):** Epithel+Bindegewebe, **keine Hornschicht** (empfindlicher), gut durchblutet; Schutz/Immun/Resorption/Schleim; **Pflege:** auf Trockenheit, Rötung, Beläge kontrollieren; Intimpflege nur mit Wasser/speziellen Produkten. **Hautanhangsgebilde:** Haare (Schutz, Temperatur, Sinn), Nägel (Keratin, Tastfunktion), Talgdrüsen (fetten), Schweißdrüsen (Temperatur), Duftdrüsen (hormonell, ab Pubertät). **Beobachten!** Nagelveränderungen: Tüpfel-/Grübchennägel (Psoriasis), **Uhrglasnägel** (chron. Sauerstoffmangel: Herz/Lunge); veränderte Nägel melden, nicht kosmetisch abdecken ohne Diagnose.

4. Hautbeobachtung in der Pflege (T2 S. 5–8) – prüfungsrelevant

Parameter	Befund	Bedeutung
Turgor (Handrücken anheben)	normal: sofort zurück · **vermindert**: bleibt Sekunden stehen · **erhöht**: gespannt, geschwollen, evtl. gerötet	Flüssigkeitsmangel (**Exsikkose**) bzw. Entzündung/Ödem
Blässe	blass	niedriger RR, **Anämie**, Durchblutungsstörung
Rötung	verstärkte Durchblutung	Anstrengung, Aufregung, **Entzündung**
Zyanose	Blaufärbung, zuerst **Lippen, Fingernägel**	**Sauerstoffmangel** (Herz/Lunge, Atemdepression durch Medikamente)
Ikterus	Gelb (Haut, Augen)	Bilirubin ↑ (Abbau Hämoglobin); Neugeborenen-Ikterus 3.–6. Tag, ~10 Tage; am 1. Tag/zu lang → Arzt
Zyanose bei dunkler Haut	Melanin überlagert → **grau**, maronenfarbene Nägel, blasse Areale um den Mund; **Zunge, Zahnfleisch, Mundschleimhaut, Bindehaut** prüfen	nicht übersehen!
Recap-Test (Rekapillarisierungszeit)	Fingernagel 5–10 s drücken, Farbe kehrt in **< 2–3 s** zurück	**> 2–3 s**: Kreislaufproblem, **Schock**, Austrocknung
5 Entzündungszeichen	Rubor, Tumor, Calor, Dolor, Functio laesa	→ 03 §7

> ⚠ Quelle sagt „Hauttugor/Zyanose-Ursache Asthma“ etc.; Medikamentenüberdosierung → Atemdepression: erst **PFK/Arzt informieren**.

5. Dekubitus (T2 S. 8)

Druckgeschwür durch **langanhaltenden Druck + Durchblutungsstörung**. Frühzeichen: **nicht wegdrückbare Rötung**; Verlauf: Blase → offene Wunde → tief ins Gewebe. Häufig: **Kreuzbein, Fersen, Hüfte**. **Fingertest: negativ** = Rötung verblasst auf Druck, kehrt ohne Druck zurück → Durchblutung intakt, **aber Risiko**; **positiv** = Rötung bleibt unter Druck → bereits geschädigt (**Kategorie I**). Zusammenhang: Immobilität → Dekubitus (Erwartungshorizont S. 3). Prophylaxe-Maßnahmen (Lagerung etc.) sind **nicht in Ihren PDFs** → Expertenstandard Dekubitusprophylaxe (DNQP) ⚠ selbst nachlesen.

6. Gutartig / bösartig; ABCDE-Regel (T2 S. 8)

Gutartig: Nävus (Muttermal), **Lentigo** (Altersfleck, UV), seborrhoische Keratose (Alterswarze), Fibrom (Stielwarze), Hämangiom. Bösartig (ärztlich abklären): **Basalzellkarzinom** (häufigster, selten Metastasen), **Plattenepithelkarzinom/Spinaliom** (Sonnenschäden, Metastasen möglich), **malignes Melanom** (aggressiv, frühe Metastasierung). **ABCDE: A**symmetrie · **B**egrenzung unscharf · **C**olor (mehrere Farben) · **D**urchmesser > 5 mm · **E**ntwicklung (Veränderung/Wachstum). Pflege: beobachten, **melden**, nicht behandeln.

7. Altersabhängige Besonderheiten (T2 S. 9–10)

Säuglingshaut: dünner, Schweiß-/Talgdrüsen unreif, Schwitzen erst ab 6–8 Monaten (⚠ Quellenangabe), unzureichender Säureschutzmantel (durchlässiger), wenig UV-Schutz, **Thermoregulation unreif → braunes Fett** zur Wärme. **Altershaut:** weniger **Kollagen, Hyaluronsäure, Elastin** (Kollagenproduktion nimmt ab ca. 30. LJ ab) → trockener, weniger elastisch, **verminderter Turgor**, empfindlicher. **Xerosis cutis** auch durch Medikamente (Kortison, Betablocker, Cholesterinsenker, Diuretika, Entzündungshemmer). ⚠ Skript S. 9 schreibt „Unterhaut (Dermis)“ → gemeint **Lederhaut**.

8. Fachbegriffe

Almanca	Türkçe
die Haut (-e)	cilt
die Oberhaut/Epidermis	epidermis
die Lederhaut/Dermis	dermis
die Unterhaut/Subkutis	deri altı
die Schleimhaut	mukoza
der Turgor	turgor (cilt gerginliği)
die Exsikkose	sıvı kaybı/dehidratasyon
die Zyanose	morarma
der Ikterus	sarılık
die Blässe	solukluk
die Rötung	kızarıklık
der Dekubitus	bası yarası
der Säureschutzmantel	asit koruyucu tabaka
das Hautanhangsgebilde	cilt eki
gutartig/bösartig (benigne/maligne)	iyi huylu / kötü huylu

Satzmuster (Dokumentation): „Haut an Fersen beidseits intakt, Rötung am Kreuzbein, **nicht wegdrückbar**, ca. 3 × 2 cm.“ (objektiv, messbar, keine Interpretation „sieht schlimm aus“.)

9. Prüfungswissen / Fehler / Merksätze / Lernkontrolle

- **Fehler:** Dermis = Unterhaut verwechseln · Zyanose bei dunkler Haut übersehen · Fingertest-Richtung vertauschen · Mitose/Meiose · Epithel hat Gefäße (falsch!).
- **Merksätze:** *Haut = Barriere, Sinnesorgan, Thermostat.* · *Nicht wegdrückbar = Alarm.* · *Zyanose: erst Lippen und Nägel.*
- **Lernkontrolle:** 1) Nenne 3 Hautschichten + je 1 Funktion. 2) Wie testest du Turgor? 3) Wann ist der Fingertest positiv? 4) Nenne ABCDE. 5) Warum kann Zyanose bei dunkler Haut übersehen werden? → Ek 5.

05 — Körpertemperatur, Fieber, Hypo-/Hyperthermie

← 04 Haut · 06 Mobilität & Sturz → Kaynak: Thieme **CNE.online** „Veränderung der Körpertemperatur“, K. Genz (DOI 10.1055/a-1458-9054), 36 S. (Abruf 20.10.2021). PDF-Seiten = Quellseiten („S.“). Ek: *Haut Teil 2* S. 3.

1. Physiologie (S. 2–4)

DE: Man unterscheidet **Körperkerntemperatur** (Kopf-, Brust-, Bauchinneres) und **Körperschalentemperatur** (Extremitäten, Haut, Unterhaut). Für den Stoffwechsel ist eine Kerntemperatur von ca. **37 °C** überlebenswichtig. **< 35 °C oder > 41 °C → lebensbedrohlich** (S. 2). Die Schale schwankt zwischen **28 und 37 °C**. Der **Hypothalamus** vergleicht **Istwert** (Thermorezeptoren Kern/Schale) mit dem **Sollwert** und steuert gegen. **TR:** Çekirdek ısı sabit ≈ 37 °C; kabuk ısısı çevreye göre değişir. Hipotalamus termostat gibi çalışır.

Zu kalt (Ist < Soll)	Zu warm (Ist > Soll)
↑ Stoffwechsel der Organe, **Muskelzittern**, ↓ Wärmeabgabe (**Vasokonstriktion**)	↑ Wärmeabgabe (**Vasodilatation**), **Schwitzen**

Bilanz: Wärmebildung + Wärmeaufnahme = Wärmeabgabe → Temperatur konstant. **Besondere Gruppen:** *Neugeborene*: kein Schwitzen/Zittern, Wärme durch **braunes Fett** → **Durstfieber** bei Flüssigkeitsmangel; *Ältere*: Störungen durch wenig Essen/Bewegung, Gefäßelastizität; im Alter **niedrigere Temperatur** (S. 14). **Hinweise ohne Thermometer (S. 4):** Rötung/Blässe, **Gänsehaut, Zittern, Schüttelfrost**, Schwitzen, ↓ Urin, reduzierter AZ, Inappetenz, ↑ Durst. **Handauflegen auf Stirn ersetzt nie die Messung** (S. 9). Kinder können trotz Fieber spielen.

2. Wann & wo messen? (S. 5–14)

Indikation: bei Verdacht; routinemäßig 1–2×/Tag (Hausstandard, Neuaufnahme); **engmaschig** bei Infektion/Abwehrschwäche, Wirkungskontrolle, nach OP/Zugängen, Komplikationen (Zytostatika), Zeichen von Temperaturveränderung, Störung der Thermoregulation/Bewusstsein. **Genauigkeit: rektal** am genauesten; andere Orte können **nach unten abweichen** → **immer gleiche Stelle**.

Messort	Vorteile	Nachteile/Gefahren
Gehörgang (aurikulär)	kurze Zeit, leicht, jede Lage, Kerntemperatur	Ohrenschmalz, Mittelohrentzündung, falsche Sonde, Preis
rektal	Kerntemperatur, sehr genau	**Intimsphäre**, geringe Akzeptanz, **Verletzung/Perforation** (Säuglinge!), Stuhl, träge Reaktion, bei Kopfverletzung ≠ Hirntemperatur
axillar	einfach, akzeptiert	nur **Schalen**temperatur, Schweiß/Umgebung, Arm verrutscht
inguinal	einfach	nur Schale, Bein verrutscht
sublingual	≈ Kern	Speichel/Getränke/Rauchen/schnelle Atmung, **Zerbeißen**, nur wach/orientiert, nicht bei Nasen-Rachen-Erkrankung
vaginal	Basaltemperatur (Eisprung)	Intimsphäre
Stirn	einfach, schnell	ungenau

Technik: *Ohr:* Gehörgang begradigen – **Kinder Ohr gerade nach hinten, Erwachsene schräg nach oben**; Schutzkappe nach jeder Messung verwerfen. *Rektal:* **ca. 4 cm** (Erw.), **2–3 cm** (Kinder), Seitenlage (Säugling Rückenlage), nicht allein lassen, Gleitgel. *Axillar/Leiste:* sauber, trocken, Spitze tief & umschlossen, Arm/Bein anpressen. *Sublingual:* neben Zungenbändchen, Mund geschlossen, **15 min vorher keine heißen/kalten Getränke**. *Stirn:* ca. 3 s ohne Hautkontakt über Augenbraue (Gerät-abhängig). **Praxis (S. 13–14):** Hersteller beachten · Schutzhülle/Handschuhe · Thermometer **nach jeder Benutzung desinfizieren** (frei von Rückständen) · **Intimsphäre** · vorher informieren · nicht direkt nach Anstrengung · **Messort frei von Salbe/Zäpfchenresten** · **dokumentieren: Zeit, Ort, Ergebnis,**

begleitende Therapie. **Thermometer-Arten (Tab. 2):** analog (Quecksilber **nicht mehr** verwendet), digital, Infrarot-Ohr, Stirn, Thermistor (Blasenkatheter/ZVK, Intensiv), Tele-/Plattenthermografie.

Normbereich & Einfluss (S. 14): Sollwert Kern **36–37,5 °C**; zirkadian ca. 0,6 °C; Zyklus (nach Ovulation ≈ +0,5 °C), Schwangerschaft ↑, Menopause ↓, Kleinkinder ↑, Ältere ↓, Anstrengung/Emotion ↑. **6 Regeln zur Fieberbeurteilung (S. 15):** Morgentemperatur bei Aufnahme/Verdacht · individuelle Grundtemperatur beachten · Einflussfaktoren · **gleiche Stelle + Technik** · Technik korrekt · Zeit/Ort/Ergebnis/Therapie dokumentieren.

3. Hypothermie (S. 15–17)

Definition: Kerntemperatur **< 35 °C**. Einteilung (Herzog): mild 32–36, mäßig 28–32, schwer 18–28, tief < 18 (⚠ „mild 32–36“ überschneidet die Definition < 35). **Ursachen:** Auskühlung (nasse Kleidung, Alkohol, hilflose ältere Person nach Sturz), Hypothyreose, Blut-/Flüssigkeitsverlust, Unterernährung, Kollaps, **Schock**, Hypothalamus-/Rückenmarkschäden, Sterbende. *Therapeutische Hypothermie* 32–34 °C (z. B. große OP, Hypoxie Neugeborener). **3 Stadien: I Erregung/Abwehr (35–32 °C)**: Kältezittern, Tachykardie, Hypertonie, wach-erregt · **II Erschöpfung (32–28)**: Muskelstarre, Bradykardie, Atemdepression, somnolent, Hypoglykämie · **III Lähmung (< 28)**: bewusstlos/Koma, Pupillen weit/lichtstarr, Kammerflimmern/Asystolie. **Wiedererwärmung:** Stadium I **passiv extern** (warmer Raum, Decken, Kältefolie); **< 32 °C aktiv extern** (warme Infusionen, Wärmematten) ggf. zentral; **ständige Überwachung** von Bewusstsein & Vitalzeichen. **Zu rasche Erwärmung bei Stadium II/III kontraindiziert** (Kreislaufversagen, Azidose); **II/III = Intensivüberwachung**. **Erfrierungen:** 1° Blässe/Gefühllos → nach Erwärmung Schwellung/Schmerz; 2° Blasen nach 12–24 h; 3° Nekrosen.

4. Hyperthermie (S. 17–21) vs. Fieber

Hyperthermie: Thermoregulation überfordert (Wärmezufuhr/-bildung ≫ Abgabe), **kein neuer Sollwert**; dauerhaft 42 °C → Tod. Ursachen: Krankheit/Verletzung, Exsikkose, fehlendes Schwitzen, Aktivität, heiße Umgebung, Stoffwechsel ↑, Medikamente/Anästhetika, unangemessene Kleidung. Symptome: Haut rot, heiß, anfangs trocken; Tachypnoe, Tachykardie, ggf. Bewusstseinsänderung, selten Krämpfe. | Form | Kern | Sofortmaßnahme (Tab. 3) | |---|---|---| | Hitzekollaps (-synkope) | Vasodilatation, „Versacken“, Schwindel, Hypotonie, Synkope | **Flachlagerung**, Flüssigkeit | | Hitzekrämpfe | NaCl-Verlust | orale Elektrolyte, ggf. Infusion, Überwachung | | Hitzeerschöpfung | Flüssigkeit+Elektrolytverlust, > 39 °C | kühle Umgebung, physik. Kühlung, OK-Hochlage oder Schocklage | | **Hitzschlag** | **lebensbedrohlich**, > 40,5 °C, trocken-heiß, Bewusstseinsstörung | kühl, Cold-Packs/Eiswasserbad, Vitalzeichen, Notfallmedizin | | **Maligne Hyperthermie** | Ca^{2+}-Defekt, bei Narkose | Narkose beenden, 100 % O_2, kühlen, **Dantrolen** (Arzt) | | Sonnenstich | Strahlung auf Kopf/Nacken | Schatten, OK/Kopf erhöht, Kopf kühlen | | **Durstfieber** | Säugling, Flüssigkeitsmangel, **kein echter Sollwert** | Flüssigkeit | Ältere/Herz-Kreislauf-Kranke: nach Hyperthermie kurz stationär überwachen (S. 21).

5. Fieber (S. 21–29)

Definition: durch den Hypothalamus **gesteuerte Sollwerterhöhung > 38,0 °C**. **Fieber ist ein Symptom, keine eigene Erkrankung.** | Grad (rektal, Tab. 4) | °C | |---|---| | afebril | 36,3–37,4 | | subfebril | 37,5–38,0 | | leichtes Fieber (febril) | 38,1–38,5 | | mäßig | 38,6–39,0 | | hoch | 39,1–39,9 | | sehr hoch/hyperpyretisch | > 40 | **Pathophysiologie (Abb. 6–7):** Pyrogene (exogen: Bakterien-/Viren-Toxine, Fremdeiweiß, Medikamente; endogen: Entzündungsbotenstoffe) → **Prostaglandin E** → Sollwert ↑ → Stoffwechsel/Grundumsatz ↑ (Abwehr, Erreger-Vermehrung gehemmt). **Fieber unterstützt das Immunsystem** (Antikörper ↑, Erreger ↓). >42,6 °C: Eiweißgerinnung. **Begleiterscheinungen:** Puls **+8–10 (–12)/min pro 1 °C** (⚠ S. 22: 8–12; S. 28: 8–10), O_2-Bedarf **≈ +10 %/°C**, AF ↑, Durst, ↓ Appetit, **Obstipation**, konzentrierter Urin, Unruhe, Kopf-/Gliederschmerz, trockene belegte Zunge, **Fieberdelir**. **Fieberarten:** infektiös · **Resorptionsfieber** (aseptisch, nach OP/Trauma ≈ nach 24 h, ≤ 38,5 °C) · zentral (Hypothalamus-Schaden) · toxisch · rheumatisch (nach Streptokokken) · Dreitagefieber (Kleinkind 39–40 °C) · **FUO** (≥ 3 Wochen > 38,3 °C ohne Ursache). **Fieberverläufe (Tab. 5):** kontinuierlich (≈ 39 °C, ≤ 1 °C Schwankung; Scharlach, Typhus, Viruspneumonie, Erysipel) · remittierend (Tag bis 1,5 °C, nie normal; Harnwegsinfekt, Tbc, Sepsis) · **intermittierend** (≥ 1,5 °C, fieberfreie Intervalle, Schüttelfrost; Sepsis, Pyelonephritis, Pleuritis) · rekurrierend (Schübe; Borreliose, Malaria, Cholezystitis) · undulierend (Wellen; Brucellose, Lymphome) · biphasisch/Dromedar (Masern, Polio, Hep A).

5.1 Drei Fieberstadien (S. 28–29)

Stadium	Körper	Haut/Symptome	Pflege
1 Fieberanstieg	Haut-Durchblutung ↓, Tonus ↑	**blass, marmoriert**, Kältegefühl, Gänsehaut, Zittern, Schüttelfrost	**wärmen** (Decken), keine Kühlung!
2 Fieberhöhe	Plateau	**heiß, trocken, gerötet**, glänzende Augen, Durst, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Unruhe/Angst, konzentrierter Urin	Flüssigkeit, Kühlung nach Anordnung/Befinden
3 Fieberabfall	Sollwert ↓ → Vasodilatation + Schwitzen	**Lysis** (langsam, Tage, warmer großperliger Schweiß) · **Krisis** (Stunden, kalter klebriger kleinperliger Schweiß, blass, Puls ↑ = Kollapsgefahr → **Notfall**)	Wäschewechsel, Flüssigkeit, nicht zu früh mobilisieren, **erste Mobilisation mit Pflegeperson**

Merke: *Anstieg = Frieren (wärmen) · Höhe = Hitze (kühlen) · Abfall = Schwitzen (trocknen, trinken).*

5.2 Fiebersenkende Maßnahmen (S. 29–33)

Entscheidung/Zeitpunkt/Art: Arzt (Schulte). **Langsam senken**; Grundlage = Befinden/Erkrankung/Vorerkrankungen. **Im Fieberanstieg sind kühlende Maßnahmen kontraindiziert** (erneuter Anstieg/Schüttelfrost).

- **Wadenwickel (S. 30):** Nässeschutz; 2 Tücher mit **lauwarmem Wasser (max. 10 °C kälter als Körpertemperatur)**, ausgewrungen, locker faltenfrei um Waden; **nach 5–10 min wechseln**; 2–3×; Wirkung: Wärmeableitung + Verdunstungskälte; **KI: kalte Füße/Hände, Durchblutungsstörungen**.
- **Kühlende Waschung (S. 30–31):** lauwarmes Wasser, bei subjektivem Hitzegefühl; **Extremitäten → Körpermitte**; nur zu waschende Partie aufdecken (Intimsphäre); an der Luft trocknen (Verdunstung); Zusätze (Pfefferminze/Zitrone); ätherische Öle mit Vorsicht.
- **Kühlmatten / lokale Kühlelemente (S. 32):** Gefahr zu schnellen Abfalls/Schüttelfrost; Kühlelement umwickeln, nur Minuten, **Erfrierungsgefahr**.
- **Antipyretika (Arzt):** wirken im Hypothalamus, meist auch analgetisch. Nebenwirkungen (Auswahl): Aspirin – Blutungsneigung, **Reye-Syndrom** bei Kindern/Jugendlichen; Metamizol – Überempfindlichkeit, Agranulozytose; Paracetamol – Allergie, Blutbildveränderung, Analgetika-Asthma. **Keine Dosierungen hier – nur nach Anordnung!**

5.3 Komplikationen (S. 33–36)

- **Schüttelfrost (4 Stadien):** Temperaturanstieg (Zittern, Zähneklappern, blass/zyanotisch) → Fieberhöhe (Durst, heiß/trocken) → **Entfieberung** (Schweiß, Lysis/Krisis) → **Erschöpfungsschlaf**. Maßnahmen: warme Decken, Raum wärmer, beruhigen, scharfe Gegenstände entfernen; **nicht allein lassen**; bei schwerem Schüttelfrost/Krampf **Arzt**; Pethidin (Arzt) → **Atemfrequenz kontrollieren**.
- **Fieberkrämpfe** (3–5 % der Kinder): meist selbstlimitiert; Fieber **langsam** senken; Eltern beruhigen.
- **Fieberdelir:** hochfiebernd plötzlich desorientiert/unruhig (Exsikkose, Elektrolyte) → **Arzt informieren**, Exsikkose prüfen (trockene Schleimhaut, stehende Hautfalte); **Sturzgefahr!**

6. Pflege-Fall: Herr Schneider mit Fieber (Übung)

Beobachtung: T 38,6 °C axillar, Puls 104, schwitzt stark, kaum getrunken. **Probleme:** Fieber/Flüssigkeitsmangel, Unruhe, Sturzrisiko. **Ziele:** Flüssigkeitszufuhr gesichert, Befinden verbessert, Kreislauf stabil. **Maßnahmen:** Stadium einschätzen (Höhe/Anstieg?), Trinkangebot/Protokoll, Wickel/Waschung **nach Anordnung/Absprache**, Schweiß-Wäsche wechseln, Mobilisation mit Begleitung, Messung an gleicher Stelle (Intervall nach Anordnung/Hausstandard), **Arzt informieren** bei Delir/Schüttelfrost/Verschlechterung. **Evaluation:** T, Puls, Befinden, Trinkmenge. *(Fiktive Werte, kein Therapieplan.)*

7. Fachbegriffe

Almanca	Türkçe
die Körperkerntemperatur / -schalentemperatur	çekirdek / kabuk ısısı
der Sollwert / der Istwert	hedef değer / mevcut değer
die Thermoregulation	ısı düzenlemesi
der Hypothalamus	hipotalamus
die Hypothermie / Hyperthermie	hipotermi / hipertermi
das Fieber, febril/afebril/subfebril	ateş
der Schüttelfrost	titreme-üşüme
die Lysis / die Krisis	yavaş / ani ateş düşüşü
der Wadenwickel	baldır kompresi
die Waschung	yıkama (silme)
das Antipyretikum	ateş düşürücü
das Pyrogen	pirojen
das Durstfieber	susuzluk ateşi
axillar / rektal / aurikulär / sublingual	koltuk altı / rektal / kulak / dil altı

8. Prüfungswissen / Fehler / Merksätze

Typisch: Fieberstadien + Maßnahmen zuordnen; Wadenwickel-Durchführung & KI; Unterschied Fieber ↔ Hyperthermie (Sollwert ja/nein); Messorte + Vor-/Nachteile; Hypothermie-Stadien. **Fehler:** im Anstieg kühlen · rektal = axillar gleichsetzen · Fieber „immer senken“ · Dosierung selbst wählen · Dokumentation ohne Messort. **Merksätze:** *Fieber = Symptom.* · *Gleiche Stelle, gleiche Technik.* · *Anstieg wärmen, Abfall beobachten.* · *Krisis = Notfall.* **Lernkontrolle:** 1) Warum frieren Patienten im Fieberanstieg? 2) Hyperthermie vs. Fieber? 3) Wadenwickel: Temperatur, Wechselzeit, Kontraindikationen? 4) Welche 3 Stadien hat Hypothermie? 5) Wann Arzt informieren? → Ek 5.

06 — LF 2: Mobilität, Bewegung im Alter und Sturzprophylaxe

← 05 Temperatur · 07 Thrombose & Pneumonie → Kaynaklar: *Erwartungshorizont „Bewegung im Alter“ (LF2.2)* (4 S.) = „EH“ · *Sturzprophylaxe PPP* (15 Folien) = „F“ · Fälle Frau Berger / Herr Schneider (Lernskript, `image.jpg` #2).

---

1. Mobilität – Begriffe (EH S. 1–2, 4)

Begriff	Definition (DE)	TR / Beispiel
Mobilität	Fähigkeit, sich selbstständig/selbstbestimmt zu bewegen, Aufenthaltsort/Körperposition zu verändern (Aufstehen, Hinsetzen, Gehen, Drehen, Umsetzen, Treppen, Hilfsmittel)	hareket edebilme
eingeschränkte Mobilität	Bewegung möglich, aber **vermindert** (langsamer, Schwierigkeiten beim Aufstehen, unsicherer Gang, Unterstützung)	kısıtlı hareketlilik
Immobilität	stark eingeschränkte/fehlende selbstständige Bewegung, erhebliche Abhängigkeit	hareketsizlik

Woran sieht man Mobilität? (EH S. 1) aufstehen/hinsetzen, Arme/Beine bewegen, Strecken zurücklegen, bücken/aufrichten, Treppensteigen, Fortbewegung mit Hilfsmittel.

2. Was verändert sich im Alter? (EH S. 1–2)

Bereich	Veränderung
Muskeln/Kraft	Muskelmasse/-kraft ↓ → schwieriger Aufstehen/Gehen
Knochen/Gelenke	geringere Belastbarkeit, Verschleiß, Schmerzen/Steifigkeit
Gleichgewicht	unsicheres Stehen/Gehen → **Sturzrisiko ↑**
Sehen/Hören	Orientierung/Sicherheit eingeschränkt
Ausdauer	schnellere Ermüdung

Wichtig (EH S. 2): Veränderungen **nicht pauschal als „normales Alter“ abtun**. Neue/zunehmende Bewegungseinschränkung → beobachten und **pflegerisch/ärztlich abklären** (beeinflussbar: Schmerzen, Erkrankung, Schwäche, Unsicherheit, **Medikamentennebenwirkungen**).

Frau Berger (81, EH S. 2): geht langsamer; mehrere Versuche beim Aufstehen; hält sich an Möbeln fest; bleibt häufiger im Sessel; verlässt Zimmer seltener. **Beobachtungskriterien Mobilität (EH S. 3):** Gangbild/Gehgeschwindigkeit · Gleichgewicht/Standfestigkeit · Aufstehen/Hinsetzen · Transfer · Hilfsmittel · Bewegungseinschränkungen · **Schmerzen** · Sturzereignisse/Angst zu stürzen · Unterstützungsbedarf · Sehen/Hören/Orientierung.

3. Folgen von Immobilität (EH S. 3)

Ebene	Folgen
Körper	Muskelabbau, Kraftverlust, ↑ Einschränkung, Ausdauer ↓, **Sturz-, Thrombose-, Dekubitus-, Kontrakturrisiko**, Obstipation, Schmerzen, Kreislaufprobleme
Gefühle/Psyche	Unsicherheit/Angst, Selbstständigkeit ↓, Frust, Rückzug/Isolation, Lebensqualität ↓
Alltag/Kontakte	weniger Aktivität/Teilhabe, Deprivationsrisiko, Abhängigkeit

Vermeidbar? Ja: frühe, individuell angepasste **Bewegungsförderung, sichere Mobilisation, Hilfsmittel, Transferunterstützung, Risikominimierung** (EH S. 3). → Verbindung: Thrombose/Pneumonie/Dekubitus/Kontraktur = **Folgen** von Immobilität (07, 04).

4. Prophylaxe & Prävention – Begriffe (EH S. 4)

Prophylaxe: Maßnahmen, die das Auftreten bestimmter gesundheitlicher Probleme/Komplikationen **vermindern**. **Prävention:** Maßnahmen zur **Vermeidung/Verminderung** von Gesundheitsproblemen und zur **Erhaltung/Förderung** von Gesundheit („Vorsorge"). *Pflege:* Risiken früh beobachten, planen, durchführen, Ressourcen fördern; **im Pflegeprozess planen, durchführen, evaluieren**; **Information/Beratung/Anleitung nachweislich dokumentieren** (auch Mikroschulung). **Vergleich:** Prophylaxe (konkreter Komplikation vorbeugen, z. B. Thromboseprophylaxe) ↔ Prävention (breiter, Gesundheitsförderung). In der Praxis oft synonym (EH S. 4).

5. Sturzprophylaxe (PPP „LF 2 Sturzprophylaxe")

Definition Sturz (F3; RKI/DocCheck): Ereignis, bei dem jemand **unbeabsichtigt auf dem Boden oder einer tieferen Ebene** aufkommt (auch sitzend/hockend). **Aus erhöhter Position = Absturz. TR:** Düşme: kişinin istemeden yere ya da daha alçak bir seviyeye gelmesi; yüksek yerden → "Absturz". **Zahlen (F4):** > **5 Mio.** Stürze älterer Menschen/Jahr in Deutschland, > **400 000** mit Knochenbruch. Folgen: Prellung, Verstauchung, **Hüftfraktur**, **Angst vor erneutem Sturz → weniger Bewegung → Kompetenzverlust**. **Schnellscreening (F5, pflege.de):** Im letzten Jahr gestürzt? Unsicher beim Gehen? Angst zu stürzen?

Ursachen (F6): Gleichgewichtsstörungen · Muskelschwäche (z. B. Mangelernährung) · eingeschränkte Bewegungsfreiheit · Fehlsichtigkeit/Augenerkrankungen · Schwindel-Erkrankungen · Angst · **ungeeignete Kleidung/Schuhe** · **Medikamente** (Schwindel) · **Inkontinenz** (Eilen zur Toilette). **Expertenstandard (F7–F8):** Folie nennt **DNQP 2013**; ⚠ aktuell ist die **2. Aktualisierung 2022** (DNQP-Auszug). Inhalt laut Folie: **kein festes Assessment-Instrument empfohlen**; Pflegefachkräfte identifizieren **Risikofaktoren**, **besonderes Augenmerk auf Anamnese**, **regelmäßige Evaluierung** (Risiko kann sich ändern: ↑ nach Sturz, ↓ durch Hilfsmittel). Beispiele Assessment: **Timed-Up-and-Go-Test**, **Wohnraumassessment** (I care 2015 S. 439). **Kernsatz (F9):** *Basis jeder Sturzprophylaxe: Keine Angst machen – was kann ich tun, um beweglich zu bleiben?*

Maßnahmen (F9, F11–F12): | Kategorie | Beispiele | |---|---| | Information/Beratung/Schulung | Betroffene informieren, Umgang mit Gehhilfen trainieren | | **Personenbezogen** | Gleichgewichtsübungen, Kraft-/Ausdauertraining, Bewegungstraining bei Gehstörungen | | **Medikamente** (Arzt kontrolliert) | Beruhigungs-, blutdrucksenkende Mittel überprüfen lassen | | **Umgebung** | ausreichend Licht (nachts Bewegungsmelder), **Stolperfallen** entfernen (Kabel), Schwellen/Stufen markieren, **Rollator/Rollstuhl: Platz + Bremsen immer schließen**, Haltegriffe/Handläufe, rutschfeste Matten/Teppiche fixieren | | Kleidung/Schuhe, Sehhilfe, Toilettengang | rutschfeste geschlossene Schuhe, Brille bereit, Toilettenzeiten anbieten (Inkontinenz) | ⚠ Die letzte Zeile ergänze ich aus den Ursachen-Folien (F6); eine eigene Maßnahmenliste dazu steht nicht in der PPP.

Notfall-Sturz – Vorgehen (F13, I care S. 438ff):

1. Betroffene **beruhigen**, **2. Pflegeperson rufen**.
2. Auf **sichtbare Verletzungen** achten.
3. Zur Bewegung anregen: **beide Hände reichen lassen, Beine aufstellen** lassen.
4. **Knochenbrüche ausgeschlossen** → vorsichtig aufhelfen, Aufstehen über **Vierfüßlerstand** (Kinästhetik).
5. **Puls & Blutdruck** kontrollieren (**nach Beruhigung**; Vergleichswert für später).
6. **Sturzprotokoll** ausfüllen (PFK).
7. **Angehörige/Betreuer & Hausarzt informieren**.
8. Akut/Verlauf: **Gehirnerschütterung**-Zeichen: Schwindel, Kopfschmerz, Erinnerungslücken, Übelkeit, Erbrechen.
9. **24 Std. (auch nachts!) Hirndruckzeichen**: Lichtstarre/Pupillen, **Druckpuls** (RR hoch, Puls niedrig).
10. Evtl. **Notarzt/Röntgenkontrolle**.

> ⚠ Reihenfolge nicht als Befehl für reale Notfälle; **Hausstandard/Arzt** entscheidet. Bei Bewusstlosigkeit/Atemstörung → Erste-Hilfe-Schema 08. Bei Verdacht auf Fraktur (Hüft, Wirbelsäule) **nicht aufstellen, Notarzt**. **Sturzereignisprotokoll (F14):** Angaben zur Person · Datum/Uhrzeit/Ort

· Sturzumgebung · Befinden nach dem Sturz · Aktivität vor dem Sturz · Folgemaßnahmen · psychische & physische Folgen. *Jede Einrichtung hat ein eigenes Protokoll.*

6. Fall Herr Schneider (Operatoren-Übung, `image.jpg` #2) – Feedback zu Ihren Antworten

Situation: 78 J., allein, nach Sturz zu Hause chirurgische Station; Schmerzen rechte Hüfte, steht schwer auf; wirkt unsicher/ängstlich („Angst, dass ich jetzt nicht mehr alleine zurechtkomme"); schwitzt stark, Kleidung verschmutzt, seit Morgen kaum getrunken; möchte zunächst **nicht beim Waschen unterstützt** werden (unangenehm). | Aufgabe | Ihre Antwort (Zusammenfassung) | Bewertung | Verbesserung | |---|---|---|---| | **1 NENNEN (AFB I)** | unsicher/ängstlich; schwitzt stark; Kleidung verschmutzt | ✔ richtig, kurz, 3 Punkte | „wirkt ängstlich" = Eindruck; zusätzlich ✔ „äußert Angst" (wörtliche Aussage) / „trinkt kaum" | | **2 BESCHREIBEN (AFB I)** | 78-jähriger … Hüftschmerzen … wirkt ängstlich … lehnt Hilfe ab | ✔ ganze Sätze, größtenteils sachlich | **Fachsprache**: „Schmerzen im rechten Hüftbereich" statt „Hüftschmerzen"; „geringe Flüssigkeitsaufnahme seit dem Morgen" statt „kaum getrunken"; „starkes Schwitzen (Hyperhidrose)" ⚠ Fachbegriff prüfen; **nicht bewerten** („verschmutzte Kleidung" ist beschreibend und ok; Wörter wie „ungepflegt" wären eine Wertung); fehlt: *lebt allein, Aufnahme nach Sturz, Schwierigkeiten beim Aufstehen, chirurgische Station*; Subjekt-Satzbau beachten | | **3 ERMITTELN (AFB II)** | Schmerzen/Mobilitätseinschränkung · Gefahr Flüssigkeitsmangel · Unterstützungsbedarf Körperpflege | ✔ gut | Zusätzlich möglich: **Sturzrisiko/Sturzprophylaxe**, **Angst/psychosoziale Unterstützung**, **Hautzustand/Hygiene (Schwitzen)**, **Entlassplanung (lebt allein)** | | **4 ERKLÄREN (AFB II)** | „Er hat Angst, weil er bisher alleine lebte und durch den Sturz plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen ist, was ihm unangenehm ist." | ✔ richtig, mit *weil* | tiefer: **Verlust von Kontrolle/Autonomie**, Schmerzen+eingeschränkte Mobilität, **Scham** bei Körperpflege (Intimsphäre), **Unsicherheit über Rückkehr nach Hause**; Hinweis „kann nicht mehr allein zurechtkommen" zitieren; Satz: „… weil er bisher alleine lebte und selbstständig war." | **Grammatikhinweise:** *weil*-Satz → Verb am Ende („weil er … angewiesen ist") ✔; Perfekt/Präteritum: „lebte" (Präteritum) im Bericht ok; *Kleidung* groß; „**trägt** verschmutzte Kleidung" ✔.

7. Fachbegriffe

Almanca	Türkçe
die Mobilität / Immobilität	hareketlilik / hareketsizlik
der Transfer (z. B. Bett→Stuhl)	transfer
das Gangbild	yürüyüş şekli
das Gleichgewicht	denge
der Rollator / die Gehhilfe	rolatör / yürüme yardımcısı
die Bremse	fren
der Sturz / der Absturz	düşme / yüksekten düşme
das Sturzrisiko / das Sturzprotokoll	düşme riski / protokolü
die Stolperfalle	takılma tehlikesi
die Prophylaxe / die Prävention	profilaksi / önleme
die Kontraktur	kontraktür (eklem sertleşmesi)
die Gehirnerschütterung	beyin sarsıntısı
die Hirndruckzeichen	kafa içi basınç belirtileri
der Vierfüßlerstand	emekleme pozisyonu
die Fraktur / die Prellung / die Verstauchung	kırık / ezik / burkulma

8. Prüfungswissen / Fehler / Merksätze

- **Typisch:** Folgen der Immobilität auf 3 Ebenen · Sturzursachen · Notfallablauf · Protokollinhalt · Begriffe Mobilität/Immobilität/Prophylaxe/Prävention · Pflegeprozess für Frau Berger.
- **Fehler:** „Alter = Immobilität" · Aufstehen lassen bei möglicher Fraktur · RR messen **bevor** beruhigt · nur Medikamente ändern (**Arzt!**) · Sturzprotokoll nicht ausgefüllt.

- **Merksätze:** *Nicht jede Veränderung ist normal. · Beruhigen – Hilfe – Verletzungen – Vitalzeichen – Protokoll – informieren. · 24 Stunden nach Sturz beobachten.*
- **Lernkontrolle:** 1) Unterschied eingeschränkte Mobilität/Immobilität? 2) 5 Sturzursachen? 3) Was tust du nach einem Sturz? 4) Was gehört ins Protokoll? 5) Warum Angst vor Stürzen riskant? → Ek 5.

07 — LF 2: Thromboseprophylaxe, Pneumonieprophylaxe, Kontraktur

> ← 06 Mobilität/Sturz · 08 Erste Hilfe → Kaynaklar: *Thromboseprophylaxe PPP* (A. Keberlein, 2.10.2026, 4 S.) = „T“ · *Auszug I care Thromboseprophylaxe* (bas. S. 417–422; PDF-S. 1–6) = „IC“ · *Pneumonieprophylaxe PPP* (16.10.2026, 22 S.) = „P“. **Dosya uyarısı:** „Auszug … Thromboseprophylaxe“ PDF-S. 1’in ilk yarısı **Pneumonieprophylaxe (LISA)** metnidir (bas. S. 416–417).

A. THROMBOSEPROPHYLAXE

1. Grundlagen

Prophylaxe (T S. 2): präventive Maßnahmen zur Verhütung/Vermeidung von Krankheiten/Komplikationen; **gehören zu den Kernaufgaben der Pflege**. **Thrombose (T S. 3, IC S. 1):** Gefäßinnenraum durch **Blutgerinnsel (Thrombus)** verengt/verschlossen; **Arterien und Venen** möglich. Fokus Kapitel: **venös, v. a. tiefe Beinvenenthrombose (TVT)**. **TR:** Tromboz = damarın pıhtıyla daralması/tıkanması; "TVT" = derin bacak toplardamar trombozu.

Virchow-Trias (IC S. 1–2): | Faktor | Begriff | Beispiele | |---|---|---| | Kreislauf | **verlangsamter Blutfluss** | Immobilität, Herzinsuffizienz, Exsikkose | | Wand | **Gefäßwandschäden** | Verletzungen/OP, Entzündungen, Rauchen, Hypertonie | | Blut | **erhöhte Gerinnungsneigung** | Thrombophilie, Tumor, Schwangerschaft, hormonelle Kontrazeption | *Merke:* **K-W-B** = *Kreislauf – Wand – Blut*. Je mehr Faktoren zusammentreffen, desto höher das Risiko.

Risikofaktoren (IC S. 2–3):

- **Expositionell** (zeitlich begrenzt/akut): operative Eingriffe, Traumata/akute Erkrankungen mit Mobilitätsverlust, **Immobilisation**.
- **Dispositionell** (angeboren/erworben, Basisrisiko): frühere TVT/Lungenembolie, Alter > 60, familiäre Häufung, chron. Herzinsuffizienz/Z. n. Infarkt, Adipositas (BMI > 30), Infekte, hormonelle Kontrazeption, Rauchen, Hypertonie, Schwangerschaft/Wochenbett, nephrotisches Syndrom, Varikosis.
- **Sehr hohes Risiko:** schon einmal Thrombose, Gerinnungsdefekt, **Krebs**.
- **Wichtig:** Kombinationen (Pille + Rauchen) ↑; Risiken **nicht einfach addieren** (Instrumente nicht ausreichend validiert).
- **Expositionelles Risiko (Tab. 17.4):** *niedrig*: kleine Eingriffe, Verletzung ohne/mit geringem Weichteilschaden · *mittel*: länger dauernde OP, arthroskopische Eingriffe untere Extremität, Hartverband-Immobilisation; Innere: Infekt ohne Bettlägerigkeit, ZVK/Port, akute Herzinsuffizienz NYHA III/IV, schwere COPD ohne Beatmung · *hoch*: große Eingriffe an Wirbelsäule/Becken/Hüfte/Knie, größere Eingriffe Körperhöhlen, Polytrauma, **Schlaganfall mit Beinparese**, Sepsis, Intensiv, maligne Erkrankung stationär.
- **Zahlen:** TVT 90–130/100 000 Einwohner/Jahr; nach Knie-/Hüftendoprothese oder hüftnahen Frakturen **40–60 %**; Rückenmarkverletzung 60–80 %; 20–50 % entwickeln ein **postthrombotisches Syndrom (PTS)** (Beinschwere, Schwellung, Schmerz, Hautulzera).
- **Pflege-Assessment – Fragen (IC S. 3):** frühere Thrombose? Lähmung/Ruhigstellung? Infekt/Rauchen? Bettruhe-Anordnung? Mobilitätseinschränkung? Gewicht (Kachexie/Adipositas)? Risikogruppe (Schwangere, Varikosis, Thrombophilie)? Lange (≥ 30 min) oder große OP?

ACHTUNG (IC S. 2): Thrombose im **Frühstadium oft nicht erkennbar**; dann löst sich das Gerinnsel am ehesten → **Lungenembolie** (lebensgefährlich) → 08 §Lungenembolie. **Symptome TVT (EH Zusammenfassung S. 21):** einseitige Beinschwellung, Schmerz, Wärme, Schweregefühl.

2. Maßnahmen (IC S. 3–6)

Stufen: | Risiko | Maßnahmen | |---|---| | **gering** | **Basismaßnahmen** (+ MTPS „Kann-Option“) | | **mittel/hoch** | Basismaßnahmen + **Antikoagulanzien** (ärztlich) + physikalisch **IPK** (intermittierende pneumatische Kompression) oder AV-Impulssystem; MTPS Kann-Option | **Basismaßnahmen: Frühmobilisation** · **aktive Eigen-/Bewegungsübungen** · **passive Bewegungsübungen** · **ausreichende Flüssigkeitszufuhr**.

- **Bewegungsübungen aktivieren die Muskel-Venen-Pumpe** → venöser Rückstrom. Geräte: Bettfahrrad, Fußstepper, Treten gegen 2 luftgefüllte Sekretbeutel am Bettende. **Eigenübungen:** Fußkreisen/-wippen, Beine auf-/abstellen, Krallen (Finger/Zehen), Schulterkreisen, schmerzschonendes Aufsetzen/Hinlegen (**En-bloc-Mobilisation**).
- **Passiv** bei bewusstlosen/stark eingeschränkten: Gelenke durchbewegen bei Körperpflege/Positionswechsel; **Vorsicht** bei Fraktur, Gelenkersatz, Hemiplegie (**Subluxation**) – **entferntere Gelenke** (Füße, Knie, Ellbogen, Hand, Finger) trotzdem bewegen (z. B. nach TEP Hüfte → distale Wade).
- **Merke – Beine nicht ausstreichen; Hochlegen ist keine Prophylaxe (nur Wohlbefinden)**; Ausstreichen kann vorhandene Thromben lösen (IC S. 4).
- **Trinken:** gemeinsam absprechen; bei oraler Zufuhr Bilanzierung schwieriger; Zweck erklären; bei Gedächtnisstörung Merkzettel „Ich muss etwas trinken!“. **MTPS (medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe) (IC S. 4–5):**
- Deutschland: Leitlinie (AWMF 2015) – **„Nichtempfehlung“** als alleinige Maßnahme; Ausnahme bei hoher Blutungsneigung (dann **IPK** empfohlen); internationale Leitlinien (USA/UK) empfehlen MTPS **zusätzlich** zur Medikation, besonders Chirurgie. Beweis für Unwirksamkeit steht aus.
- **Passform:** Größe an **beiden Beinen** messen, **morgens/nach Verbandabnahme** (weniger Ödem), **Fuß 90°**, Wadenmuskel entspannt, Maßband eng, **von unten nach oben**, erst Umfang, dann Länge; **nicht umschlagen/einschneiden**; bei sehr dicken Beinen/Deformität → Kompressionsverband.
- **Anlegen (Abb. 17.14):** Maße (Knöchel, Wade, Länge) → Größe wählen → Strumpf weiten → bis Ferse überstreifen → Fersenteil festhalten, nach außen stülpen → über Unterschenkel ziehen, **keine Falten**.
- **Wirkt nur im Liegen** (Druck auf liegende, eingeschränkt mobile Pat.); mobile Pat. brauchen **medizinischen Kompressionsstrumpf (MKS)**. **Vergleichstabelle (Tab. 17.5):** | | MKS | MTPS | Stützstrumpf | |---|---|---|---| | Für | Venen-/Lymphgefäßerkrankung | Klinik/Heim, **liegende** Pat. | **Gefäßgesunde** (Stehen/Sitzen, Flug, OP-Personal) | | Rezept | verschreibungsfähig | – | frei verkäuflich | | Druck | definiert, 4 Klassen (Kl. 4 ≥ 49 mmHg) | weniger als MKS | gering | | Größen | Serie/Maß, Sanitätshaus | Seriengrößen, **nur weiß**, Schenkelstrümpfe mit **Loch am Fußende (Inspektion)** | Konfektionsgröße | **Eigene Kompressionsstrümpfe** der Patienten (gut sitzend) tagsüber weiter benutzen, abends ggf. MTPS; **nicht in die Krankenhauswäsche** (dokumentieren). **Kompressionsverband: Mehrlagensysteme + elastische Binden**; MKS mit starkem Druck vor Kurzzugverbänden (DNQP 2015); Wechsel- vs. Dauerverband; Druck 20–30 mmHg; ältere: einfacher (18–21 mmHg), Klett-Bandagen; Kurzzugbinde verliert 25 % Druck nach 2 Std.; degressiv vs. progressiv (neu: hoher Druck über der Wade bei mobilen). **Kontraindikationen MTPS/Kompression (IC S. 6): kritische periphere arterielle Durchblutungsstörung (pAVK), schwere Neuropathie, ausgeprägte periphere Ödeme, lokale Defekte/Nekrosen/Verletzungen** → dann Basis-/physikalische Maßnahmen besonders wichtig. **IPK-Kontraindikationen:** dekompensierte Herzinsuffizienz, ausgedehnte Entzündung (Phlebitis, Erysipel), Traumen, Neuropathien, nicht einstellbarer Hypertonus; Diabetisches Fußsyndrom bei AV-Impuls vorsichtig. **Beobachten:** einseitige Schwellung, Schmerz, Überwärmung, Rötung, Spannungsgefühl → **sofort PFK/Arzt**, **nicht massieren/mobilisieren** bei Verdacht (Embolie!) ⚠ allgemeiner Sicherheitshinweis.

3. Kontraktur (IC S. 6)

Merkmale: **Gelenksteifigkeit**, Funktionsstörung, Gelenkverformung, ↑ Widerstand gegen passive Dehnung; aktive und passive Beweglichkeit eingeschränkt; stark limitiert, Hilfe nötig. Prophylaxe: Bewegung/Mobilisation, passive Übungen, Lagerung (Details nicht in PDF ⚠).

B. PNEUMONIEPROPHYLAXE

4. Pneumonie (P S. 2–19)

DE: Infektiöse Entzündung der Lunge; eine der häufigsten Infektionskrankheiten weltweit; in westlichen Ländern **häufigste infektionsbedingte Todesursache** (P S. 2). **Einteilung:** nach **Ort der Infektion**, **Erreger**, **Symptomatik**, **Ort der Entzündung**.

- **Ambulant** (außerhalb Gesundheitswesen) vs. **nosokomial** (Klinik + bis 24 Std. danach ⚠ P S. 4; in Fachliteratur meist ≥ 48 Std. nach Aufnahme – klären). *Warum wichtig?* andere Erreger/Resistenzen (MRSA), andere Antibiotika.
- **Erreger:** ambulant meist **Pneumokokken**, Chlamydien, Legionellen, Mykoplasmen, Viren (Influenza, Corona); geriatrische Pat.: Staphylokokken, **E. coli**, Klebsiellen; nosokomial: problematische Keime (**MRSA**); Immunschwäche: **opportunistische** Keime. **Typisch vs. atypisch (P S. 8):** | | typisch | atypisch | |---|---|---| | Beginn | plötzlich | schleichend | | Fieber | **bis 40 °C, Schüttelfrost** | leicht erhöht | | Husten | produktiv (gelb-bräunlich) | trocken | | Atemnot | von Beginn an ausgeprägt | langsam zunehmend | | Begleit | Begleitpleuritis | Grippesymptome | | AZ | stark beeinträchtigt | mäßig | **Ort der Entzündung (P S. 9–10):** *Lobär* (Segment/Lappen; Flächenschatten, Pneumobronchogramm, evtl. Erguss) · *Broncho* (Bronchiolen+Alveolen, herdförmig; konfluierende Fleckschatten) · *interstitiell* (Lungengerüst; hilifugale streifige Zeichnung, meist beidseits) · alveolär. **Komplikationen:** Pleuraerguss, respiratorische Insuffizienz, akutes Lungenversagen, Lungenabszess. **Diagnostik:** Auskultation (**feinblasige Rasselgeräusche**, ggf. Pleurareiben, gedämpfter Klopfschall), Röntgen-Thorax, Labor (**BSG, CRP, PCT**), **Sputum (Erregernachweis)**, bei Fieber **Blutkultur**. **Schweregrad CRB-65 (P S. 14): C**onfusion · **R**espiratory rate **≥ 30**/min · **B**lood pressure **< 90 / ≤ 60** mmHg · Alter **≥ 65** → je 1 Punkt; **ab 1 Punkt stationär** (⚠ Folie: „>65“; üblich ≥ 65; Quelle OCR „<90/<60“ → Standard: systolisch < 90 **oder** diastolisch ≤ 60). **Therapie (Arzt):** körperliche Schonung/ggf. Bettruhe, **Antibiotika** (zuerst Breitband, nach Erreger anpassen), Flüssigkeit (ggf. i. v.), Sekretolyse (Inhalation NaCl), Fiebersenkung, O_2 (Nasenbrille/Maske, ggf. Intubation). **Aspirationspneumonie (P S. 16–19):** *Sonderform, nicht infektiös* (primär chemisch/mechanisch). Risiko: Bewusstseinsstörung, nicht nüchtern bei Narkose, **Schluckstörungen**, **nasogastrale Sonden**, Schwangerschaft. Symptome **verzögert (2–12 Std.)**: Husten, Bronchospasmus/Schleim, **Dyspnoe, Zyanose**, später Fieber. Röntgen zunächst unauffällig; Therapie: Bronchoskopie, Breitband-Antibiotika, O_2, Bronchospasmolytika. **Risikogruppen (Frage P S. 12 – Lösungsvorschlag):** ältere, immobile/bettlägerige, Schluckstörungen, Bewusstseinsstörung, Immunschwäche, COPD/Herzinsuffizienz, Raucher, Beatmete, Schmerzen mit Schonatmung, Muskelrelaxanzien/Sedativa, Mangelernährung. **4 Hauptprobleme (Auftrag P S. 20, aus I care Kap. Pneumonieprophylaxe – nicht im Auszug):** Ihre Aufgabe nutzt das I-care-Kapitel; ⚠ Ich schlage vor (aus LISA abgeleitet): **verminderte Lungenbelüftung**, **Infektionen/Keime**, **Sekretstau**, **Aspiration**.

5. LISA-Prinzip (IC S. 1 + „Wissen to go“)

Buchstabe	Bedeutung	Maßnahmen
L	**L**ungenbelüftung verbessern	Mobilisation, atemunterstützende Positionierung (**Oberkörperhochlage** erleichtert Atemarbeit/Ventilation), atemvertiefende Maßnahmen
I	**I**nfektionen vermeiden	**Mundpflege**, hygienisches Arbeiten, **Standardhygiene konsequent**
S	**S**ekret verflüssigen, mobilisieren, entleeren	Flüssigkeit ↑ (**gefiltertes/stilles Wasser**, bei Immunsuppression **abgekochtes**), **Drainagelagerungen** (Seitenlage leichte Kopftieflage, Bauchlage – Kontraindikationen!), **Huffing**, **Inhalation** (Vernebler, Spacer, Pulverinhalator), Atemphysiotherapie, **Perkussion/Vibration** (zustandsabhängig), **Absaugen** (geschlossenes System; Katheter verwerfen; steriles Aqua dest., kein Leitungswasser bei Legionellenrisiko)
A	**A**spiration vermeiden	**orale Ernährung** so lange/so früh wie möglich, **aufrecht zum Essen**, bei **Dysphagie** abwägen, **Zeit lassen**

Weitere (P S. 21): Pneumokokken-Impfung (Ältere, immunsupprimierte, chron. kranke Kinder > 5 J., Langzeitpflege; ⚠ Alter laut Folie) · **atemerleichternde Maßnahmen** (**Lippenbremse**, Einreibung, **Kutschersitz**) · **Schmerzmanagement** (gegen Schonatmung) · **atemunterstützende Lagerung** (z. B. **VATI-Lagerung**) · Aspirationsprophylaxe. **Merke (IC):** Muskelrelaxanzien (Benzodiazepine, z. B. Musaril) **interdisziplinär** (Pflege–Medizin–Physio) besprechen: rechtfertigt Nutzen die ↑ Pneumoniegefahr?

Beobachtungskriterien (Auftrag, Vorschlag): Atemfrequenz/-tiefe/-muster, Atemgeräusche, Husten/Auswurf (Farbe, Menge), Hautfarbe (Zyanose), Temperatur, Puls, Bewusstsein/Unruhe, SpO_2 (falls vorhanden), Mobilität, Schluckfähigkeit, Mundzustand. **Praxis:** *Immobilität → flache Atmung → Sekretstau → Pneumonie.* Frühmobilisation hilft Thrombose **und** Pneumonie. **Kein medizinischer Ratschlag:** O_2, Inhalate, Absaugen, Lagerungen bei Risiken **nur nach Anordnung/Standard/Anleitung**.

C. Fachbegriffe

Almanca	Türkçe
die Thrombose / der Thrombus	tromboz / pıhtı
die Lungenembolie	akciğer embolisi
die Virchow-Trias	Virchow üçlüsü
expositionell / dispositionell	maruziyete bağlı / yatkınlığa bağlı
die Antikoagulanzien	antikoagülanlar (kan sulandırıcılar)
die Frühmobilisation	erken mobilizasyon
der Kompressionsstrumpf (MKS) / MTPS	kompresyon çorabı / trombofilaksi çorabı
die intermittierende pneumatische Kompression	aralıklı pnömatik kompresyon
die Muskel-Venen-Pumpe	kas-damar pompası
die Pneumonie / Lungenentzündung	zatürre
nosokomial / ambulant	hastane kaynaklı / toplum kökenli
die Aspiration	aspirasyon (solunum yoluna kaçma)
die Dysphagie	yutma bozukluğu
das Sekret / das Sputum	sekresyon / balgam
der Auswurf	balgam çıkarma
die Oberkörperhochlage	gövde yükseltme
die Lippenbremse	dudak freni
der Kutschersitz	arabacı oturuşu
das Huffing	huffing (zorlu nefes verme)
die Atemfrequenz	solunum sayısı

D. Prüfungswissen / Fehler / Merksätze

- **Typisch:** Virchow-Trias + je 2 Beispiele · Basismaßnahmen · MTPS Anlegen & KI · Beine **nicht ausstreichen** · LISA mit je 2 Maßnahmen · typisch/atypisch Pneumonie · Aspirationsprophylaxe · warum Immobilität → beide Komplikationen.
- **Fehler:** MTPS bei Gehenden als vollwertig · Strümpfe falsch gemessen (nur ein Bein) · „Hochlegen = Prophylaxe“ · LISA-Buchstaben verwechseln · Aspiration = infektiös.
- **Merksätze:** *K-W-B – Kreislauf, Wand, Blut.* · *Bewegen, trinken, Strümpfe passend.* · *LISA: Lunge belüften, Infektion verhüten, Sekret lösen, Aspiration vermeiden.*
- **Lernkontrolle:** 1) Nenne Virchow-Trias. 2) Expositionelle vs. dispositionelle Faktoren? 3) Kontraindikationen MTPS? 4) Was bedeutet LISA? 5) Warum reicht Hochlegen der Beine nicht? 6) Wie unterscheidest du typische/atypische Pneumonie? → Ek 5.

08 — Erste Hilfe, Basic Life Support (BLS), AED, Schock und akute Notfälle

← 07 Prophylaxen · 09 Pflegeprozess & Fälle → Kaynaklar: **ZF** = *Zusammenfassung Erste Hilfe B2* (27 S., lernorientiert; Seitenzahlen = **gedruckte** Seitenzahl im Dokument = PDF-Seite) · **F** = *Erste Hilfe* Folien, H. Becker, 28.9.2026 (254 PDF-Seiten). Folien-Nr. = PDF-Seite. ⚠ **Sicherheit:** Dieses Kapitel ist **Lernstoff**. Reanimation lernt man **praktisch** im zertifizierten Kurs; im Einsatz gelten Kurs, Hausstandard und Leitstelle. Widersprüche: 00 §4.

---

1. Warum Anatomie? (ZF S. 1)

Notfall erkennen heißt wissen, wie der Körper normal arbeitet: **Herz – Kreislauf – Atmung**. Lunge nimmt O_2 auf, Blut transportiert, Herz pumpt; **Gehirn** reagiert besonders empfindlich auf O_2-Mangel. **Merke (ZF):** *Sie müssen nicht zuerst eine Diagnose stellen – lebensbedrohliche Situation erkennen und schnell handeln.*

1.1 Herz (ZF S. 1–3; F 5–25)

- Lage: **Mediastinum**, zwischen Lungenflügeln; ⅔ links, ⅓ rechts; **faustgroß**; dahinter Speiseröhre, Wirbelsäule; unten **Zwerchfell**.
- 4 Hohlräume: **2 Vorhöfe (Atrien)**, **2 Kammern (Ventrikel)**, **Septum**; **Herzklappen** (Ventilfunktion; Segel-/Taschenklappen: Bikuspidal-/Mitral-, Trikuspidal-, Aorten-, Pulmonalklappe).
- Rechtes Herz: **sauerstoffarmes** Blut → Lunge; linkes Herz: **sauerstoffreiches** Blut → Körper (linke Kammer = kräftigstes Myokard).
- Wand: **Endokard** (innen), **Myokard** (Muskel), **Epi-/Perikard** (Herzbeutel, Flüssigkeit gegen Reibung).
- **Koronargefäße**: rechte & linke **Koronararterie** aus der Aorta → plötzlicher Verschluss = **Herzinfarkt**.
- **Reizleitung (ZF S. 3; F 22):** Sinusknoten → AV-Knoten → His-Bündel → Tawara-Schenkel (Kammerschenkel) → Purkinje-Fasern. Eigenfrequenzen (F 22, Abb.): **Sinus 60–100/min**, AV 40–45, His 40–45, Kammerschenkel 40–45, Purkinje 35–40. ⚠ ZF: „60–80“ (Widerspruch). Rhythmusstörungen im Kreislaufstillstand: **Kammerflimmern (VF)**, **Asystolie**.

1.2 Kreislauf (ZF S. 4–5)

Körperkreislauf (groß): linke Kammer → Aorta → Arterien → **Kapillaren** (Abgabe O_2/Nährstoffe, Aufnahme CO_2) → Venen → rechtes Herz. **Lungenkreislauf (klein):** rechte Kammer → Lungenarterie → Alveolarkapillaren (Gasaustausch) → Lungenvenen → linkes Herz. **Merke:** *Arterien: vom Herzen weg · Venen: zum Herzen hin* (unabhängig vom O_2-Gehalt!). **Blutdruck:** z. B. 120/80 mmHg; **systolisch** = Auswurf (Systole), **diastolisch** = Füllung (Diastole); **Windkesselfunktion** der Aorta. **Puls-Begriffe (F 122):** Tachykardie > 100/min (Neugeb. > 170, Kleinkind > 130) · Bradykardie < 60/min (Erw.) · **Asystolie** = kein elektrische+mechanische Herzaktion (F: „> 2 s“ ⚠).

1.3 Lunge & Atmung (ZF S. 5–7; F 40–56)

Rechts **3** Lappen (Ober-, Mittel-, Unter-), links **2** (Herz!). Weg: Mund/Nase → Rachen → Kehlkopf → **Trachea** → 2 Hauptbronchien → Bronchialbaum → **Alveolen** (Gasaustausch). Aufgaben: O_2 aufnehmen, CO_2 abgeben, **Säure-Basen-Haushalt**. | Begriff | Bedeutung | TR | |---|---|---| | **Ventilation** | Belüftung der Lunge | havalandırma | | **Diffusion** | Gasaustausch Alveole ↔ Blut | difüzyon | | **Perfusion** | Durchblutung der Lunge | perfüzyon | Nur wenn **alle drei** funktionieren → wirksamer Gasaustausch. **Inspiration** (Brustkorb weitet, Zwerchfell) · **Exspiration** (Muskeln entspannen, Rückstellkräfte).

---

2. Notfall und Erste Hilfe – Definition & Recht

Notfall (ZF S. 7; F 59–61): akute **lebensbedrohliche** Störung von Bewusstsein, Atmung, Herz-Kreislauf (Trauma, Erkrankung, Vergiftung); ohne sofortige Hilfe schwere bleibende Schäden/Tod. *Merkmale (F 80):* unerwartet, unterschiedlich, vitale Bedrohung, auf Hilfe angewiesen, Ausnahmesituation, schnelle Hilfe. *Sozialrechtlich (F 60):* akute Bedrohung, ärztliche Hilfe nicht rechtzeitig → Behandlung auch durch Nicht-Vertragsarzt. **Behandlungspflicht** = Ausnahme von Behandlungsfreiheit (F 62–63). **Erste Hilfe (ZF S. 7–8; F 65):** Maßnahmen von Laien/Ersthelfern, die Zeit bis zum **Rettungsdienst** überbrücken: Gefahr erkennen, Unfallstelle sichern, **Notruf**, Sofortmaßnahmen, Betreuung, Überwachung. *Ziel:* nicht vollständig behandeln, sondern **Gefahr erkennen, Vitalfunktionen erhalten, Hilfe organisieren**. **Rechtliches (ZF S. 8; F 66–79, 231–233):**

- **§ 323c StGB – Unterlassene Hilfeleistung:** Wer bei Unglücksfall/gemeiner Gefahr/Not nicht hilft, obwohl **erforderlich und zumutbar** (insbes. ohne **erhebliche eigene Gefahr** und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten) → **Freiheitsstrafe bis 1 Jahr oder Geldstrafe**; ebenso wer Helfende **behindert**. (Wortlaut F 69, dejure.org.) Beispiele F 71: Nichtschwimmer muss nicht in tiefes Wasser; Elternteil am Abgrund muss Kind nicht allein lassen.
- **Hilfe nach eigenen Kenntnissen/Fähigkeiten**; für **Gesundheitsberufe** ggf. höhere Anforderungen.
- **Garantenstellung (§ 13 StGB, Unterlassen):** besondere **Einstandspflicht** der Pflegefachperson gegenüber anvertrauten Pat. (F 78, 232).
- **Rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB):** gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr; **mildestes Mittel**; geschütztes Interesse **wesentlich überwiegt**. Beispiele F 76–77: Notfallmedikament **ohne Anordnung** bei akuter Atemnot (nur wenn einziger Weg) · verschlossene Tür aufbrechen. ⚠ **Das ist ein Ausnahmefall, kein Freibrief**; fallabhängig.
- **Haftung (F 67, 79):** Bei **gebotener Sorgfalt** i. d. R. keine strafrechtlichen/schadensersatzrechtlichen Folgen (auch bei Verschlechterung/zusätzlichen Schäden); mutmaßliche Einwilligung/GoA §§ 677 ff. BGB.
- ⚠ *Keine Rechtsberatung;* Wortlaut: https://dejure.org/gesetze/StGB/323c.html (Link aus der Folie).

---

3. Sicherheit, Notruf, Rettungskette

Eigensicherung hat Vorrang! (ZF S. 9; F 104). Gefahren: Verkehr, Feuer/Rauch, Strom, Chemikalien, **Infektionsstoffe**, gefährliche Gegenstände. Notfalls erst Feuerwehr/Polizei/RD alarmieren. **Ablauf (F 106):** absichern → Überblick → retten aus Gefahr → Notruf → Betroffene versorgen. Verkehr (F 107): Warnblinker, Warnweste, Warndreieck: **innerorts ca. 50 m, außerorts ca. 100 m, Autobahn 200–300 m**; Sicherheitsabstand ca. 15–20 m. **Notruf 112** (ZF S. 9–10; F 88): **W-Fragen: Wo? Wer ruft an? Was ist geschehen? Wie viele Betroffene? – Warten auf Rückfragen!** Leitstelle gibt Anweisungen (**Telefonreanimation**). **Vergiftung:** Giftnotruf (F 89: 06131 192 40 ⚠ OCR/Folie – Nummer des zuständigen Giftinformationszentrums prüfen): **Wer** (Alter/Gewicht)? **Womit/Welcher Stoff? Wie viel? Wann? Welche Symptome? Was schon getan? Rettungskette (F 99–102):** Sofortmaßnahmen+Notruf → weitere Erste Hilfe → Rettungsdienst → Krankenhaus; „bricht an der schwächsten Stelle“. **Fakten (F 81–82):** ≈ 700 000 plötzliche Herztode/Jahr in Europa; ≈ 40 % initial Kammerflimmern; Überleben bis 70 % bei früher CPR+Defi; **−10 %/Minute** ohne Maßnahmen.

---

4. Erste Einschätzung & Basischeck

BRABP/Basischeck (F 109): Bewusstsein – Atmung – (Puls) … Schema „Ansehen/Ansprechen/Anfassen“ (F 110, 120). **Bewusstsein (ZF S. 11; F 110–112):** laut ansprechen → an der **Schulter** rütteln → ggf. **Schmerzreiz** (Schulter kneifen). Bewusstlosigkeit: Schutzreflexe fehlen → **Atemwegsverlegung (Zunge), Aspiration**. Hirndruckzeichen (F 112): Übelkeit/Erbrechen, Kopfschmerz, Anisokorie, Unruhe, Beuge-/Strecksynergismen, abnorme Atmung (Biot). **Atemweg öffnen (ZF S. 11–12; F 113–116):** Hand auf Stirn, **Kopf überstrecken, Kinn anheben**; **Esmarch-Handgriff** (Pflege/Profis; F 114). Atmung: **Sehen – Hören – Fühlen, höchstens 10 Sekunden** (F 116). **Schnappatmung ≠ normale Atmung** (F 119). Mund-Rachen-Inspektion nur bei Verdacht auf Fremdkörper (F 113). **Puls (F 123):** keine obligate Maßnahme mehr für Laien; **als medizinisches Personal** durchführen, **≤ 10 s**; im Zweifel **sofort Herzdruckmassage**. **Präkardialer Faustschlag** nur bei sicher beobachtetem VF am Monitor innerhalb 10 s (F 124). **Stabile Seitenlage (ZF S. 12; F 117–118):** bewusstlos **mit normaler Atmung** → Atemwege freihalten → Notruf → **Atmung regelmäßig kontrollieren**, nicht allein lassen; bei Verschlechterung neu beurteilen → ggf. CPR. **Merke: Keine Reaktion + keine normale Atmung =**

Verdacht auf Kreislaufstillstand. „Phone first / phone fast“ (F 126): Erwachsene (nach Pubertät) **erst Notruf, dann CPR**; Kinder (vor Pubertät): erst Atemweg, 5 Zyklen/1 Min CPR, dann Notruf (⚠ Folie schematisch; GRC 2025: Laien prüfen Atmung **nach** Notruf, F 86).

---

5. Basic Life Support (BLS) und AED

5.1 Schema Erwachsene (F 121, 163; ZF S. 12–15)

Prüfen (bewusstlos) → Rufen (Hilfe/112, Lautsprecher) → Atemweg öffnen, Atmung ≤ 10 s → Drücken (CPR beginnen) → AED holen/anlegen, Anweisungen folgen → CPR fortsetzen bis RD/Team übernimmt. Allein: Patient nicht verlassen, wenn möglich Lautsprecher; AED holen lassen. | Parameter | Erwachsener (ZF S. 13; F 137, 163) | |---|---| | Unterlage/Position | **harte Unterlage**, Oberkörper frei; Helfer kniet seitlich | | **Druckpunkt** | **Mitte Brustkorb / unteres Sternumdrittel** (zwischen den Mamillen) | | Hände | Ballen einer Hand, andere darauf, Finger verschränkt; **Arme gestreckt, Schultern senkrecht** | | **Frequenz** | **100–120/min** (⚠ F 137: „100“, F 140/172: „80–100“) | | **Tiefe** | **5–6 cm** (≥ 5, ≤ 6 cm; „½ Thorax“ F 140) | | Entlastung | **vollständig**, ohne Handkontakt zu verlieren | | Verhältnis | **30 : 2** (unabhängig von Helferzahl) | | Unterbrechungen | **so kurz wie möglich** | | Helferwechsel | alle **2 Minuten** (Ermüdung: korrekte Kompressionen nach 5 min bis auf 18 %, F 138) | **Pathophysiologie (F 128):** Thoraxkompression → ↑ intrathorakaler Druck + direkte Herzkompression; RR_sys ≈ 80 mmHg; Fluss nur ohne Pausen. **Beatmung (ZF S. 13–14; F 143–147):** nach 30 Kompressionen **2 Beatmungen**, wenn ausgebildet und zugetraut: Mund-zu-Mund/Nase (kinn anheben, Kopf überstrecken, Nase/Mund verschließen) oder **Beatmungsbeutel (C-Griff, > 90 % O_2 mit Reservoir)**. **Kann/will man nicht beatmen → kontinuierliche Thoraxkompression** ist besser als nichts („Irgendeine Reanimation ist besser als keine!“; GRC: Beatmung für Laien nachrangig, F 147–151). **Beachte (F 168):** Studienfolie: Pflegepersonal überschätzt oft eigene CPR-Qualität → **regelmäßig üben**.

5.2 AED (ZF S. 14–15; F 152–161)

Definition: **Automatisierter externer Defibrillator** analysiert Rhythmus selbst, gibt ggf. Schock; für **Laien**, Sprach-/Bildanweisungen. **Defibrillation in 3–5 min nach Kollaps → Überleben 50–70 %**; ≈ 83 % VT/VF defibrillierbar; keine negativen rechtlichen Folgen für Laien. **Ablauf:** ① einschalten (Öffnen des Gerätes) ② **Elektroden** nach Piktogramm aufkleben (bei mehreren Helfern CPR **weiterlaufen lassen**) ③ Sprachanweisungen ④ **bei Analyse niemanden berühren** ⑤ Schock empfohlen? → **Abstand halten, niemand berührt, Schock auslösen** ⑥ **sofort CPR fortsetzen** ⑦ kein Schock empfohlen → ebenfalls **sofort CPR 30:2**. **Kinder:** AED ab **8 J.** wie Erwachsener; **1–8 J. bevorzugt Kinderelektroden/-modus** (F 161); (F 97: „ab 8 Jahren einsetzbar“). **Merke:** *AED ersetzt die Herzdruckmassage nicht. · Eine schlechte Reanimation ist besser als keine.*

5.3 BLS bei Kindern (F 121, 131–135, 141–142, 146)

- **Altersgrenzen (F 133):** Säugling < 12 Monate; Kind ab 1 Jahr.
- Ablauf (F 133–135): Reaktion (**nie schütteln**) → Hilfe/112 → Atemweg (Säugling **Neutralposition**, Kind leicht überstrecken) → bei fehlender Atmung **5 initiale Beatmungen** (Säugling Mund auf Mund **und** Nase) → **15 Thoraxkompressionen : 2 Beatmungen** (mit PBLS-Training; **ohne** Training Erwachsenen-Algorithmus **30:2** inkl. 5 Beatmungen, F 121) → Notruf/Team nach **1 Minute** CPR, falls allein.
- **Tiefe: ⅓ des Thoraxdurchmessers**; Frequenz **100–120/min**; unteres Brustbeindrittel (F 133). Folie 141 „Kinder 4 cm“, 142 „Kleinkind/Kind 5 cm“ ⚠.
- **Fremdkörper (F 146):** effektives Husten → ermutigen; ineffektiv + bei Bewusstsein: Säugling **5 Rückenschläge/5 Kompressionen**, Kind **5 Rückenschläge/5 abdominelle Kompressionen**; Bewusstlos: Atemweg, **5 Beatmungsversuche**, dann PBLS; Mund nicht blind auswischen; Nachsorge medizinisch. ⚠ **Kinderwerte sind schulabhängig → Praxiskurs/aktuelle GRC/ERC-Leitlinie.** (GRC/ERC 2025: PLS-Kapitel; Details nicht in Ihren PDFs.)

5.4 ALS & innerklinisch (ZF S. 15–16; F 171–193) – Überblick für Auszubildende

ALS = erweiterte Maßnahmen (Profis, innerklinisch): Atemwegssicherung (Intubation, **Larynxmaske/i-gel**), Beatmung, EKG/Rhythmusdiagnose, **Defibrillation** (biphasisch **120–360 J**; nach 2 Min. Rhythmuskontrolle; Selbstschutz: **„Ich defibrilliere – weg vom Bett, O_2 entfernen“**), Zugang (i. v./i.

o.), Medikamente (⚠ Dosisangaben auf F 179/187 nur zur Information: **Adrenalin 1 mg, Amiodaron 300 mg** nach dem 3. Schock – **nur ärztlich**), Behandlung **reversibler Ursachen** (4H/4T: Hypoxie, Hypovolämie, Hypo-/Hyperkaliämie/metabolisch, Hypo-/Hyperthermie; Spannungspneumothorax, Herzbeuteltamponade, Intoxikation, Thromboembolie). **Rhythmen:** *schockbar* **VF/pulslose VT** · *nicht schockbar* **PEA/Asystolie**; sonst: Artefakt, VT mit Puls. **Nach ROSC** (Spontankreislauf): ABCDE, Ziel SpO_2 94–98 % (F 190). **Innerklinische Reanimation (F 164, 189):** Hilfe rufen & beurteilen · keine Lebenszeichen → **Rufen, Drücken, Equipment**; Reanimationsteam, Defi/AED; Helferwechsel bei Rhythmuskontrolle; **Übergabe im SBAR-Format**. Sonst: **medizinischer Notfall** → Notfallteam, ABCDE. **Grenzen/Ethik (F 173, 191–192):** BLS hat Grenzen (VF → Asystolie); Prinzipien: Fürsorge, Schadensvermeidung, **Patientenautonomie**, Gerechtigkeit; **Abbruchkriterien**: keine eindeutigen Regeln, Einzelfall; **Patientenverfügung/„Nicht reanimieren"-Anordnung** beachten ⚠ (nicht ausgeführt in Folien). **Leitlinien 2025 – Neuerungen laut Folie 86 (nicht verifiziert):** Fokus schnelle Thoraxkompressionen, Laien prüfen Atmung nach Notruf mit Leitstellenhilfe; bei Profis nach 3 Schocks Vector-Change der Pads erwägen; Atropin-Einschränkung; Beatmung volumenkontrolliert 6–8 ml/kg, 10/min, $etCO_2 \geq 25$ mmHg; **Details und Quelle (Impressum 2021!) prüfen** → https://www.grc-org.de. **Auszubildende:** nur im **eigenen Kompetenzbereich**, nach **Hausstandard**, **mit der zuständigen PFK** (F 167).

5.5 ABCDE-Schema (F 165–167)

	Bedeutung	Prüfen
Airway	Atemwege	frei? Fremdkörper, Erbrochenes, Blut, Schnarchen, **Stridor**
Breathing	Atmung	normal? AF, Atemarbeit, Hautfarbe, SpO_2
Circulation	Kreislauf	Puls, Haut, RR, **starke Blutung stillen**
Disability	Neurologie	Bewusstsein (**AVPU**: wach – Ansprache – Schmerz – keine Reaktion), Pupillen, **BZ**, Intoxikation
Exposure/Environment	Untersuchung/Umgebung	möglichst vollständig, **würdevoll**, Wärmeerhalt, Anamnese

Problem erkannt → **sofort behandeln**, dann weiter, danach **erneut kontrollieren**. **Ausnahme:** nicht reagierend + keine normale Atmung → **nicht erst ABCDE**, sondern **Alarm + CPR**.

---

6. Schock (ZF S. 16–17; F 195–204)

Definition: Minderdurchblutung vitaler Organe → **Gewebehypoxie**, Missverhältnis O_2-Angebot/-Bedarf → Zelltod, **Multiorganversagen**; Circulus vitiosus („Schockspirale", Azidose). **Zeichen: Hypotonie, Tachykardie, Tachypnoe, Oligurie/verminderte Urinausscheidung, Bewusstseinsstörung, marmorierte/kalte Haut, Laktat ↑** (F 199). | Form | Ursache | Beispiele | |---|---|---| | **hypovolämisch** | Blut-/Flüssigkeitsverlust | Blutung, Exsikkose, Verbrennung | | **kardiogen** | Herz pumpt zu wenig | **Infarkt**, dekompensierte HI, Rhythmusstörung | | **obstruktiv** | mechanische Behinderung | **Lungenembolie**, Spannungspneu, Perikardtamponade | | **distributiv** | Gefäß-Verteilungsstörung | **Anaphylaxie, Sepsis**, ZNS-Trauma | **Schockindex (Allgöwer/Burri, F 200–202): SI = Herzfrequenz / systolischer RR.** Normal **0,5–0,7**; **≥ 1,0** Schock wahrscheinlich (Blutverlust > 30 % bei Hypovolämie); **> 1,5** schwerer Schock. Beispiel: Puls 120, RR 80 → **1,5**. Nur **Momentaufnahme/Orientierung** (Bewusstsein, kapillärer Refill beachten). **Therapie (F 203):** O_2, ggf. Intubation, Ursache beseitigen, symptomatische Notfalltherapie, Blutfluss/RR/O_2-Angebot wiederherstellen. **Pflege/Erste Hilfe:** Notruf, Blutungen stillen, flach/Schocklage nur bei Hypovolämie ohne Kontraindikation ⚠ (nicht in Folien; im Kurs lernen), warm halten, ansprechen, Vitalzeichen. → Verbindung: **Recap-Zeit > 2–3 s** (04 §4); **Krisis nach Fieber** (05).

---

7. Wichtige Notfälle

7.1 Asthma bronchiale (ZF S. 17–18; F 205–207)

Chronische Atemwegserkrankung, **anfallsartige Atemnot, Husten**. **Allergisch** (Pollen, Tierhaare, Hausstaubmilben, Schimmel, Staub, Nahrung) vs. **nicht allergisch** (Anstrengung, Kälte, Tabakrauch, Stress, Medikamente, Parfüm). **Schwerer Anfall:** Ruhe bewahren, **Notruf**, **angeordnete/vorhandene**

Notfallmedikation unterstützen, Inhalation/Atemtherapie. (Hinweis: Nach Anordnung; Dosen nicht hier.)

7.2 Herzinfarkt (ZF S. 18–19; F 208–216)

Plötzlicher Koronarverschluss → Myokard unterversorgt; Zeit = Herzmuskel. **Zeichen:** starke Brustschmerzen, Druck/**Engegefühl**, **Brennen**, Ausstrahlung (Arme, Rücken, Oberbauch, Hals, Kiefer, Schulter), Atemnot, Übelkeit/Erbrechen, **kalter Angstschweiß, blasse/fahle Haut, Todesangst**. **Frauen/Ältere:** atypisch – Atemnot, Schwitzen, **Rückenschmerz, Oberbauch, Übelkeit, ungewöhnliche Müdigkeit** (F 212). **Risiko:** Übergewicht (abdominell), Stress, Bewegungsmangel, fettreiche Ernährung, Blutfette/Cholesterin, **Hypertonie, Rauchen, Diabetes**. → **Notruf 112**, Oberkörper hoch ⚠, nicht allein lassen (Maßnahmen nach Kurs/Arzt).

7.3 Schlaganfall/Apoplex (ZF S. 19–20; F 217–226)

Synonyme: Hirnschlag, Hirninfarkt, Apoplex. **Ursachen:** Durchblutungsstörung **oder** Hirnblutung. **Warnzeichen: einseitige Gesichtslähmung (hängender Mundwinkel)**, **plötzliche Arm-/Beinlähmung (meist eine Seite)**, **Sprachstörung/Sprachverständnis**, Sehstörung/Doppelbilder/Blindheit (oft ein Auge), heftiger Schwindel/Gangunsicherheit, **Schluckstörung**, Bewusstseinsstörung, **plötzlicher ungewöhnlicher heftiger Kopfschmerz**. **Zeit ist Hirn** → sofort 112. Risiko: Alter > 70, Hypertonie, Rauchen, Fettstoffwechsel, Übergewicht, Alkohol, „Pille“, Diabetes, Herz, Gerinnung; F 224: ≈ 200 000 erstmalige Schlaganfälle/Jahr (⚠ OCR).

7.4 Lungenembolie (ZF S. 20–21; F 219–223)

Thrombus (meist **tiefe Beinvene**) → Lunge, verschließt Gefäße; Mortalität ≈ 10 %, meiste Todesfälle in den ersten Stunden. **Risiko: Immobilisation, OP**, Alter, Tumor, hormonell (Kontrazeptiva, Schwangerschaft, HRT), Gerinnungsstörungen. **Symptome: plötzliche Atemnot**, pleuritischer/retrosternaler Schmerz, Husten, Fieber, **Hämoptysen**, Synkope, Kreislaufprobleme; **einseitiger Beinschmerz/Schwellung/Wärme/Schweregefühl** (TVT). **Pflegebezug:** Thromboseprophylaxe (07).

7.5 Blutung und Wunden (ZF S. 21–22; F 227–229)

Blutung = Austritt aus dem Gefäßsystem → Blutverlust → **hypovolämischer Schock**. **Wundarten: mechanisch** (Schnitt, Platz), **thermisch** (Verbrennung, Erfrierung), **chemisch** (Säuren), **Strahlen**. **Blutstillung hat hohe Priorität**; bei erheblichen Verletzungen früh Hilfe. (Verbandtechniken: nicht in PDFs ⚠.) **Eigenschutz: Handschuhe** (Infektion, 03).

---

8. Handlungsablauf Station (ZF S. 22–25) – „Patient liegt am Boden“

1. **Sicherheit** (Umgebung) 2. **Überblick** 3. **Reaktion** (ansprechen/rütteln) → nicht reagierend → **sofort Unterstützung/Hilfe rufen** 4. **Atemweg öffnen, Atmung ≤ 10 s** 5a. **normal atmend** → stabile Seitenlage (soweit möglich), Hilfe, Atmung überwachen ✧ 5b. **nicht normal atmend** → **Kreislaufstillstand**: **Notruf/innerklinisches Notfallsystem**, **CPR 100–120/min, 5–6 cm**, **AED so früh wie möglich**, bis Team übernimmt ✧ 6. **Beobachten** 7. **Übergabe strukturiert** (was passiert, was beobachtet, was getan; **SBAR**). **Sturz im Haus:** → 06 §5 (nach Stürzen auch **Hirndruck/Fraktur**). **Merksätze (ZF S. 23–24):** 1 Eigenschutz geht vor · 2 Notfall kann jederzeit eintreten – ruhig, strukturiert · 3 Bewusstsein & Atmung sind zentral · 4 112 früh, auf Rückfragen warten · 5 Jede Minute zählt · 6 100–120/min, 5–6 cm, wenig Unterbrechung · 7 30:2 · 8 AED früh, Anweisungen folgen · 9 Bewusstlos+normale Atmung → stabile Seitenlage · 10 Keine Diagnose nötig – Gefahr erkennen und handeln. **Abschluss-Merksatz (ZF S. 27): ERKENNEN – HILFE RUFEN – HANDELN – ÜBERWACHEN.**

---

9. Fachbegriffe (Auswahl)

Almanca	Türkçe
der Notfall / der Notruf	acil durum / acil çağrı
die Erste Hilfe / der Ersthelfer	ilk yardım / ilk yardımcı
der Rettungsdienst / die Leitstelle	kurtarma servisi / kontrol merkezi
die Eigensicherung	kendini koruma
bewusstlos / ansprechbar	bilinçsiz / bilinci açık
die Atemkontrolle	solunum kontrolü
die Schnappatmung	agonal solunum
die stabile Seitenlage	koma pozisyonu
die Herzdruckmassage / Thoraxkompression	kalp masajı
die Beatmung	suni solunum
der Kreislaufstillstand	dolaşım durması
das Kammerflimmern	ventriküler fibrilasyon
die Asystolie	asistoli
der Defibrillator (AED)	defibrilatör
der Schock / der Schockindex	şok / şok indeksi
die Garantenstellung	garantör konumu
die unterlassene Hilfeleistung	yardım etmeme (suçu)
der Spontankreislauf (ROSC)	spontan dolaşımın dönüşü
die Übergabe (SBAR)	devir-teslim

Verwechslung (Bölüm C): BLS ↔ ALS (Basis ohne Hilfsmittel/AED ↔ erweitert Profis) · **Ventilation ↔ Perfusion ↔ Diffusion** · **Herzinfarkt ↔ Herzstillstand** (Infarkt = Durchblutungsproblem, Pat. kann bei Bewusstsein sein; Stillstand = keine Pumpleistung) · **Apoplex ↔ Synkope**.

10. Prüfungswissen / Fehler / Lernkontrolle

- **Typisch:** BLS-Algorithmus mit Zahlen · Atemkontrolle (SHF, ≤ 10 s) · Notruf-W-Fragen · AED-Ablauf · §323c/Garantenstellung/§34 erklären · Schockformen + Beispiele · FAST-ähnliche Schlaganfallzeichen · Herzinfarkt atypisch bei Frauen · SBAR.
- **Fehler:** Schnappatmung = normal · Puls minutenlang suchen · Kompressionen zu flach/langsam/Pausen · AED berühren während Analyse · CPR nach Schock unterbrechen · „erst ABCDE“ bei Reanimationspatient.
- **Lernkontrolle (ZF S. 26, 20 Fragen) → Lösungen: Ek 5 Klausur 3.**

09 — Pflegeprozess und klinisches Denken (Bölüm E) – Vorlage + ausgearbeiteter Plan

← 08 Erste Hilfe · 10 Dokumentation & Operatoren → Grundlage: *Lernskript LF1A* S. 4 (6 Phasen), *Arbeitsblatt* S. 6–8, Fälle Frau Berger/Herr Schneider, Fachkapitel 03–08. Weitere Fälle: Ek 6 Klinische Fälle. **Disclaimer:** Dies sind **Lernbeispiele**. Reale Pflegeplanung: Anamnese, Assessment, **Anordnung**, Hausstandard, PFK (§ 4 PflBG: Planung und Steuerung sind vorbehalten!). Auszubildende arbeiten **mit Anleitung**.

1. Die 6 Phasen – Fragen & Checkliste

Phase	Leitfrage	Checkliste
1 Informationssammlung	Was weiß ich? Was fehlt?	Anamnese (Diagnose, Vorgeschichte), **Beobachtung** (Haut, Atmung, Bewegung, Temperatur, Schmerz), **Gespräch**, ABEDL, Biografie, Angehörige, Hilfsmittel, Medikamente (Information, nicht ändern!)
2 Probleme & Ressourcen	Was schränkt ein? Was kann die Person?	Problem **+ Ursache + Symptom**; Ressourcen (Fähigkeit, Motivation, soziales Netz); **Risiken** (Sturz, Dekubitus, Thrombose, Pneumonie, Exsikkose, Infektion)
3 Pflegeziele	Was soll erreicht werden?	patientenorientiert, realistisch, **überprüfbar (Zeitpunkt)**; Fern-/Nahziele
4 Maßnahmen planen	Was, wie oft, wer, womit?	**konkret**, wirksam, ressourcenfördernd, Autonomie; Delegation klären
5 Durchführung	Wie umsetzen?	ankündigen, Mitwirkung, Intimsphäre, Sicherheit, **Hygiene**; Abweichungen melden
6 Evaluation	Wirkung?	Ziel erreicht/teilweise/nicht; Ursache; Anpassung; **dokumentieren**

Klinische Denk-Fragen (Bölüm E, 10 Fragen): 01 §4.

Mehrere Antworten möglich: Bei Priorisierung zählt: **1. Lebensgefahr (ABCDE/Notfall) → 2. akute Risiken (Sturz, Aspiration) → 3. Komfort/Autonomie/psychosozial.** Immer **Selbstbestimmung** und **Intimsphäre** mitdenken; Ablehnung ernst nehmen, Gründe erfragen, Alternativen, später erneut anbieten, dokumentieren, PFK informieren.

2. Ausgearbeitetes Beispiel: Herr Schneider (Lernfall aus Ihrem Übungsheft)

Fall (Kurz): 78 J., allein lebend, Sturz, Aufnahme chirurgische Station; Schmerzen rechte Hüfte, Aufstehen schwer; unsicher/ängstlich („Angst, nicht mehr allein zurechtzukommen“); **schwitzt stark**, Kleidung verschmutzt, **kaum getrunken**; lehnt Waschhilfe zunächst ab (unangenehm).

Phase 1 – Informationen

Vorhanden	Fehlt (nachfragen/nachsehen)
Sturz zu Hause, Schmerz rechts Hüfte, Mobilität ↓, lebt allein, Angst, Schwitzen, Trinkmenge ↓, Hygiene-Defizit, Ablehnung Waschen	Ursache des Sturzes (Schwindel? Medikamente? Sehen?), **Vitalzeichen** (Temperatur! Puls, RR), Schmerzstärke/Analgesie (Arzt), Orientierung/Kognition, Sehhilfe, Hautzustand, Ausscheidung, Ernährung, Angehörige, häusliche Versorgung, Wünsche

Wichtige Zeichen: Schwitzen + wenig Trinken → **Exsikkose/Fieber?** ; Immobilität → **Thrombose-, Pneumonie-, Dekubitusrisiko**; Alter+Sturz → **Sturzfolgen (Fraktur, Hirndruck)**.

Phase 2 – Probleme/Ressourcen

Problem (+Ursache)	Risiko	Ressource
Schmerzen + eingeschränkte Mobilität nach Sturz	Sturz, Thrombose, Dekubitus, Pneumonie	spricht offen über Angst, **Wunsch nach Selbstständigkeit**
Flüssigkeitsdefizit (geringe Trinkmenge, Schwitzen)	Exsikkose, Delir, Kreislauf	kann trinken (selbst?)
Selbstversorgungsdefizit Körperpflege (Scham)	Hautproblem, Infektion, Würdeverlust	kann äußern, was unangenehm ist
Angst vor Autonomieverlust	Rückzug, Depression	lebte selbstständig

Phase 3 – Ziele (Beispiele, überprüfbar)

1. Herr Schneider **äußert innerhalb von 24 h**, dass Schmerzen in Ruhe erträglich sind (Skala nach Hausstandard).
2. Herr Schneider **trinkt bis zum Abend ≥ [vereinbarte Menge nach Arzt/PFK]** (⚠ Menge nicht aus PDF).
3. Herr Schneider **entscheidet selbst, welche Körperteile er allein wäscht**; Körperpflege erfolgt mit Wahrung der Intimsphäre.
4. Herr Schneider **steht in den nächsten Tagen mit Unterstützung sicher auf**, **ohne weiteren Sturz**.
5. Herr Schneider **benennt Unterstützungsmöglichkeiten nach Entlassung** (Entlassmanagement).

Phase 4 – Maßnahmen (Auswahl, in Absprache)

- **Beobachten:** Vitalzeichen **inkl. Temperatur (gleiche Stelle!)**, Haut/Turgor, Schmerz, Trinkmenge/Urin, Orientierung (04, 05).
- **Mobilisation** mit Begleitung, Hilfsmittel, Bremsen, Schuhe, Weg frei (06); **Sturzrisiko** einschätzen, Anamnese; Prophylaxen nach Risiko (**Thrombose**: Frühmobilisation, Übungen, Trinken; **Pneumonie**: LISA) (07).
- **Trinkangebot**, Vorlieben, Erinnerung; **Trinkprotokoll** (Anordnung/Standard).
- **Körperpflege:** ankündigen, **Wahlmöglichkeit** („Möchten Sie … selbst waschen?“), Sichtschutz, Wäsche wechseln; **Hautbeobachtung** (Falten, Fersen, Kreuzbein).
- **Gespräch:** Angst ernst nehmen, Information (Ablauf, Ziel), Einbeziehen, Angehörige; ggf. Sozialdienst anfragen.
- **Arzt/PFK informieren** bei: Fieber, Delir/Unruhe, neuen Schmerzen, Atemnot, Bewusstseinsänderung, ein-seitiger Beinschwellung, Verschlechterung.

Phase 5 – Durchführung

Zeitpunkte, wer, wie Reaktion; Abweichungen („Pat. lehnt Waschen ab“) → melden/dokumentieren.

Phase 6 – Evaluation

Ziel	Prüfkriterium	Entscheid
Schmerz	Äußerung/Skalawert, Mobilisationsfähigkeit	angepasst? Arzt?
Trinken	Menge	erhöhen? Hindernisse?
Körperpflege/Autonomie	Beteiligung, Zufriedenheit	Angebot anpassen
Mobilität/Sturz	sicher aufstehen? Ereignisse?	Plan ändern

Dokumentation (Beispiel, objektiv): *„08:15 Uhr: Pat. äußert Schmerzen im rechten Hüftbereich (Skalawert 6), Schmerzmittel laut Anordnung durch PFK verabreicht [nur wenn tatsächlich geschehen]. 09:00 Uhr: Pat. lehnt Unterstützung beim Waschen ab, gibt an, die Situation sei ihm unangenehm; Angebot, Gesicht/Arme selbst zu waschen, wird angenommen. PFK informiert.“* → Prinzipien: 10.

3. Fall Frau Berger (Hüftschmerz, Brille fehlt) – Plan-Skizze

Siehe 01 §1 Tabelle + Pflegeprozess in Lernskript S. 4. **Ergänzung:** Brille organisieren (Tochter bitten, **Sehen = Sturzrisiko**), Schmerz vor Mobilisation einschätzen, Selbstbestimmung („nicht alles für mich“)

→ **aktivierende Pflege**, Entlassplanung (allein, Tochter).

4. Schreib-Rahmen für die Klausur (Pflegeplan in 6 Zeilen)

„**Information:** … **Problem/Ressource:** … **Ziel:** … (Zeitpunkt) **Maßnahmen:** … **Durchführung:** … **Evaluation:** … **Bei Verschlechterung muss die Pflegefachkraft/der Arzt informiert werden.**“

Lernkontrolle: Erstelle für Frau Berger (81) aus dem Erwartungshorizont (Rollator, mehrere Versuche beim Aufstehen, zieht sich zurück) einen Pflegeprozess in 6 Zeilen. → Musterlösung Ek 5 Klausur 4.

10 — Pflegedokumentation, Operatoren und Klausur-Schreiben (Bölüm J)

← 09 Pflegeprozess · 11 Grammatik → Kaynaklar: **Operatoren-Training** (Übungsheft „Operatoren und schriftliche Prüfungen“, S. 3; sizin fotoğrafınız `image.jpg` #1, Türkçe notlarınızla) · Fall Herr Schneider (`image.jpg` #2) · Thieme S. 13–15 (Temperatur-Dokumentation) · Sturzprotokoll (Sturz-PPP F 14) · Hautbeobachtung (04). Dokumentationsrecht/-pflicht-Details (z. B. Aufbewahrungsfristen, Berichtigungsregeln) sind **nicht** in Ihren PDFs → Hausstandard/Schule ⚠.

---

1. Operatoren (Handlungsanweisungen in Aufgaben)

Merke: Der **Operator** bestimmt, **was** und **wie tief** Sie schreiben. **AFB** = **Anforderungsbereich**: **I** Reproduktion, **II** Reorganisation und Transfer, **III** Reflexion und Problemlösung.

Operator	AFB	Anforderung (Übungsheft)	Türkçe (sizin notunuz)	Antwort-Tipp
NENNEN	I	Begriffe/Daten/Fakten **kurz, präzise**; Stichworte möglich	saymak/belirtmek	Liste, keine Erklärung
BESCHREIBEN	I	Sachverhalt **strukturiert, eigene Worte, ganze Sätze, Fachsprache, keine Wertung**	tanımlamak/betimlemek	objektiv, Reihenfolge
ZUORDNEN	I	Zusammenhänge/Begriffe/Abläufe **verbinden**	eşleştirmek/ilişkilendirmek	Tabelle/Pfeil
ZUSAMMENFASSEN	I	wichtigste Aussagen kurz, **eigene Worte**	özetlemek	3–5 Sätze
DEFINIEREN	I	Bedeutung eines Begriffs, **charakteristische Merkmale** nennen	tanımlamak	„X ist …, Merkmale: …“
ERMITTELN	II	durch **analytisches Arbeiten** feststellen/herausarbeiten/ableiten	tespit etmek/belirlemek	aus dem Text ableiten
ERKLÄREN	II	**Ursachen, Bedingungen/Folgen verständlich machen**; hilfreich: **„weil“**	açıklamak (Almancada *weil* kullan)	Ursache → Wirkung
VERGLEICHEN	II	**Gemeinsamkeiten und Unterschiede** herausstellen	karşılaştırmak	Tabelle + Fazit
ANWENDEN	II	Wissen **in neuer/veränderter Situation** einsetzen	uygulamak	auf Fall beziehen
BEGRÜNDEN	III	darstellen, **warum** etwas so ist; **fachliche Argumente**	gerekçelendirmek	These + Argument + Beispiel
DISKUTIEREN	III	Argumente **gegenüberstellen und abwägen**	tartışmak	Pro/Contra/Fazit
STELLUNG BEZIEHEN	III	**kritisch prüfen**, **begründetes Urteil**	görüş bildirmek	Urteil + Begründung
ENTWICKELN	III	**eigene Ideen** darstellen und begründen	geliştirmek/ortaya koymak	Lösung + Begründung
DEUTEN	III	**Perspektive einer anderen Person** einnehmen, Verhalten nachvollziehen	yorumlamak	„Aus Sicht von … könnte …“

Eselsbrücke (kendi önerim): I = *Wissen sagen* · II = *Wissen umbauen* · III = *Wissen bewerten/erfinden*.
Häufige Fehler: „Erklären“ nur aufzählen · „Beschreiben“ mit Bewertung („schlimm“) · „Begründen“ ohne *weil/da/denn* · bei „Nennen“ zu lang schreiben (Zeit) · Operator ignorieren.

Musterlösung Herr Schneider: 06 §6 (mit Feedback). **Verbesserte Fassung Aufgabe 2 (BESCHREIBEN):**

„Herr Schneider, 78 Jahre alt, lebt allein und wird nach einem Sturz zu Hause auf die chirurgische Station aufgenommen. Er gibt Schmerzen im rechten Hüftbereich an und steht nur mit Mühe auf. Bei der Aufnahme wirkt er unsicher; er äußert: ‚Ich habe Angst, dass ich jetzt nicht mehr alleine zurechtkomme.' Er schwitzt stark, seine Kleidung ist verschmutzt, und er hat seit dem Morgen nur wenig getrunken. Hilfe beim Waschen lehnt er zunächst ab, da ihm die Situation unangenehm ist." (Objektiv: Beobachtung + wörtliche Aussage; *„wirkt"* = Eindruck, *„äußert"* = Aussage; keine Bewertung.) **Verbesserte Fassung Aufgabe 4 (ERKLÄREN):** *„Herr Schneider hat möglicherweise Angst, seine Selbstständigkeit zu verlieren,* ***weil*** *er bisher allein lebte und seinen Alltag selbst organisierte. Durch den Sturz hat er Schmerzen und kann sich nur eingeschränkt bewegen,* ***sodass*** *er nun auf fremde Hilfe angewiesen ist. Zusätzlich ist ihm die Körperpflege durch andere unangenehm. Er fürchtet daher, nach der Entlassung nicht mehr allein zurechtzukommen."*

---

2. Grundprinzipien der Pflegedokumentation (Bölüm J)

Prinzip	Erklärung (DE)	TR
Beobachtung ≠ Interpretation	Beobachtung = was ich sehe/messe/höre; Interpretation = meine Deutung	gözlem ≠ yorum
Objektiv & konkret	Zahlen, Orte, Zeit, Häufigkeit, Größe	nesnel ve somut
Zeit, Befund, Maßnahme	*Wann? Was festgestellt? Was getan? Wirkung? Wer informiert?*	
Keine vagen Wörter	„etwas", „ziemlich", „normal", „schlecht", „unruhig" ohne Beschreibung	belirsiz ifadeler
Patientenaussagen	in **Anführungszeichen**/als Aussage („Pat. gibt an …")	hastanın sözleri
Nur Durchgeführtes	**nie** eine nicht erfolgte Maßnahme als erledigt eintragen	yapılmayanı yazma
Fehler/Lücken	nach **Einrichtungsregeln** korrigieren (nicht überschreiben/unleserlich machen) ⚠ Hausstandard	
Datenschutz	nur Nötiges, Vertraulichkeit (Schweigepflicht)	
Lesbar, fachsprachlich, kurz	übliche Abkürzungen nur laut Hausstandard	

Verben: *beobachten* (aufmerksam wahrnehmen, ohne zu urteilen) ↔ *beurteilen* (aus Beobachtung Schlüsse mit Fachwissen ziehen); *dokumentieren*, *melden*, *äußern*, *angeben*, *klagen über*.
Pflegeplanung (Planung der Pflege: Ziele/Maßnahmen) ↔ **Pflegedokumentation** (Nachweis: was wurde getan/beobachtet).

3. Falsch ↔ richtig (mit Begründung)

#	Schlecht	Besser	Warum (DE)	Warum (TR)
1	„Pat. war heute schlecht drauf."	„Pat. wirkt traurig, spricht kaum, lehnt Frühstück ab (isst 2 Bissen)."	konkret, beschreibend statt wertend	somut, yargı yok
2	„Pat. hat Fieber."	„12:30 Uhr: Körpertemperatur 38,6 °C axillar, Haut heiß und gerötet, Pat. schwitzt. Arzt informiert."	Messwert, Messort, Zeit, Reaktion	değer, ölçüm yeri, saat
3	„Pat. trinkt zu wenig."	„Trinkmenge bis 14 Uhr ca. 300 ml laut Trinkprotokoll; Pat. gibt an, keinen Durst zu haben."	messbar, Aussage	ölçülebilir
4	„Pat. wurde mobilisiert." (nicht geschehen)	„Mobilisation wegen Schwindels abgebrochen; Pat. sitzt an der Bettkante, RR gemessen: …"	**nur Wirkliches** dokumentieren	yapılmayanı yazma
5	„Pat. stürzte, ist aber okay."	„14:05 Uhr Sturz im Bad, Pat. sitzt auf dem Boden, gibt Schmerzen am rechten Handgelenk an; keine Kopfverletzung sichtbar; Puls 88, RR 130/80 nach Beruhigung; PFK/Arzt informiert; Sturzprotokoll ausgefüllt."	Sturzprotokoll-Inhalte (F 14)	

#	Schlecht	Besser	Warum (DE)	Warum (TR)
6	„Pat. ist aggressiv.“	„Pat. ruft laut: ‚Lassen Sie mich in Ruhe!‘ und schiebt die Hand der Pflegekraft weg.“	Verhalten + wörtliche Aussage	
7	„Haut gerötet am Po.“	„Kreuzbein: Rötung ca. 3 × 2 cm, auf Fingerdruck **nicht wegdrückbar**.“	Fingertest/Lokalisation	
8	„RR ok.“	„RR 128/76 mmHg, Puls 78/min, regelmäßig.“	Messwert statt Wertung	
9	„Pat. verweigert Pflege.“	„Pat. lehnt Hilfe beim Waschen ab mit der Begründung, es sei ihm unangenehm; PFK informiert; erneutes Angebot um 11 Uhr.“	Gründe + Konsequenz, Autonomie	

Beispiel Fehlerkorrektur: Zeitstempel/Wert falsch → **durchstreichen, lesbar bleiben**, Datum/Kürzel, richtig neu eintragen ⚠ (so üblich; **Hausstandard prüfen**).

4. Temperatur-/Sturz-/Haut-Eintrag – Vorlagen

- **Temperatur (Thieme S. 15):** *Zeit, Ort, Ergebnis, flankierende Therapie.* → „08:00 Uhr, axillar 37,4 °C; keine weiteren Maßnahmen.“
- **Sturzprotokoll (F 14):** Person · Datum/Uhrzeit/Ort · Umgebung · Befinden · Aktivität davor · Folgemaßnahmen · psychische/physische Folgen.
- **Haut:** Ort · Größe · Farbe · Temperatur · Turgor · Schmerz · Fingertest.

5. Wendungen für schriftliche Antworten (Bölüm J – mit Beispielen)

Funktion	Muster	Beispiel
Einleiten/Beachten	„Zunächst ist zu beachten, dass …“	*Zunächst ist zu beachten, dass Fieber ein Symptom und keine eigenständige Erkrankung ist.*
Zeichen	„Ein wichtiges Anzeichen dafür ist …“	*Ein wichtiges Anzeichen für eine Exsikkose ist ein verminderter Hautturgor.*
Zweck	„Die Pflegemaßnahme dient dazu, …“	*Die Frühmobilisation dient dazu, die Muskel-Venen-Pumpe zu aktivieren und einer Thrombose vorzubeugen.*
Evaluation	„Anschließend wird überprüft, ob …“	*Anschließend wird überprüft, ob Herr Schneider die vereinbarte Trinkmenge erreicht hat.*
Eskalation	„Bei einer Verschlechterung des Zustands muss …“	*Bei einer Verschlechterung des Zustands muss die zuständige Pflegefachkraft bzw. der Arzt informiert werden.*
Begründen	„Das liegt daran, dass …“, „Aus diesem Grund …“, „da …“	*Das liegt daran, dass der Hypothalamus den Sollwert verstellt.*
Vergleichen	„Im Gegensatz zu … / Beide … / Während …, …“	*Während die Hyperthermie ein Versagen der Wärmeabgabe ist, beruht Fieber auf einer Sollwerterhöhung.*
Zusammenfassen	„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass …“	
Definieren	„X ist …“, „Unter X versteht man …“	*Unter Prophylaxe versteht man …*
Beschreiben	„Es zeigt sich …“, „Auffällig ist …“	
Folgern	„Daraus ergibt sich …“, „Folglich …“	
Stellung	„Meiner Einschätzung nach … , weil …“	

Mehr: Ek 2 Sätze.

6. Prüfungswissen/Merksätze/Lernkontrolle

- **Merksätze:** *Sehen – messen – schreiben – nicht deuten.* · *Nicht dokumentiert = nicht gemacht (im Streitfall), aber nur Gemachtes dokumentieren.* ⚠ (Merkregel, rechtl. Details nicht in PDFs)

- **Übung:** Forme um: „Herr M. war den ganzen Tag unruhig und hat kaum was gegessen.“ → *„Herr M. läuft zwischen 10 und 12 Uhr wiederholt im Flur auf und ab, äußert ‚Ich weiß nicht, wo ich bin‘; Mittagessen: etwa ein Viertel gegessen.“* (fiktiv).
- **Lernkontrolle:** 1) Unterschied Beobachten/Beurteilen? 2) Warum Patientenaussagen als Aussage? 3) Was tun, wenn Maßnahme nicht durchgeführt wurde? 4) Formuliere einen Satz mit „Anschließend wird überprüft, ob …“. 5) Wo liegen AFB II und III? → Ek 5.

11 — Almanca gramer ve yazma becerisi (Bölüm I)

← 10 Dokumentation · 12 Berufskontext → Bu bölümün örnek cümleleri **PDF'lerdeki gerçek kalıplardan** türetildi (ör. „weil"-Sätze, Passiv in Maßnahmen, Imperativ in Anleitungen). Dilbilgisi açıklamaları genel Almanca bilgisidir (⚠ PDF dışı); seviyenizi (A2/B1/B2) bilmediğim için **varsaymadım** — hepsi kısa tutuldu.

1. Artikel & Fälle (Nominativ – Akkusativ – Dativ – Genitiv)

Fall	Frage	Pflege-Beispiel	Artikel m/f/n/Pl.
Nominativ (özne)	Wer/Was?	**Der Patient** schläft.	der/die/das/die
Akkusativ (nesne)	Wen/Was?	Ich messe **den Blutdruck**. Ich wasche **die Patientin**.	**den**/die/das/die
Dativ (dolaylı)	Wem?	Ich helfe **dem Patienten**. Ich erkläre **der Patientin** den Ablauf.	**dem/der/dem/den (+n)**
Genitiv	Wessen?	Der Zustand **des Patienten**	des(-s)/der/des/der

Dativ-Verben (merken): *helfen, danken, gehören, gefallen, zuhören, antworten* → „Ich helfe **ihr**." **Wechselpräpositionen** (*in, auf, an, über, unter, neben, zwischen, vor, hinter*): **wohin?** → Akk. (*Ich lege ihn **ins** Bett*), **wo?** → Dat. (*Er liegt **im** Bett*). **Fehler → Ursache:** „Ich helfe den Patienten" ✘ → *helfen* verlangt Dativ: „Ich helfe **dem** Patienten". „Ich messe dem Blutdruck" ✘ → *messen* + Akk.: „**den** Blutdruck". **Übung:** (1) Ich gebe ___ Patient___ (m) ___ Tablette. (2) Ich dokumentiere ___ Temperatur. (3) Er liegt ___ Bett (n). (4) Ich lege ihn ___ Bett. → (1) dem, die (2) die (3) im (4) ins.

2. Tempus

Zeit	Form	Wann in der Pflege	Beispiel
Präsens	*messe*	Anweisung, allgemeine Aussage, mündlich	„Ich messe jetzt Ihre Temperatur."
Perfekt	*habe gemessen / bin gestürzt*	mündlicher Bericht, Übergabe	„Frau B. **ist** gestürzt."
Präteritum	*maß, stürzte, war*	**schriftlicher Bericht**, Fallbeschreibung	„Herr S. **lebte** allein."

sein-Perfekt: Bewegung/Zustandsänderung: *gestürzt, aufgestanden, eingeschlafen, gegangen*. **haben-Perfekt:** die meisten anderen. **Regel:** Dokumentation ist oft **Präsens/Präteritum** oder **Nominalstil** („Temperatur 38,6 °C axillar."). Mischung vermeiden.

3. Modalverben

Verb	Bedeutung	Beispiel
können	Fähigkeit/Möglichkeit	Frau Berger **kann** mitwirken.
müssen	Pflicht	Bei Verschlechterung **muss** der Arzt informiert werden.
dürfen	Erlaubnis/Verbot	Ich **darf** keine Auskünfte geben.
sollen	Auftrag/Anweisung	Ich **soll** sie erst nach dem Frühstück mobilisieren.
wollen/möchten	Wunsch	Er **möchte** selbst waschen.

Satzstellung: Modalverb **Pos. 2**, Infinitiv **am Ende**: „Ich **muss** den Arzt **informieren**." Verneinung: *nicht dürfen* (verboten) ↔ *nicht müssen* (nicht nötig).

4. Passiv (Vorgangs- & Zustandspassiv)

Vorgangspassiv: *werden + Partizip II*; Täter unwichtig/Handlung wichtig → typisch in Berichten, Maßnahmen.

- Aktiv: *Die Pflegekraft misst die Temperatur.* → Passiv: *Die Temperatur **wird** (von der Pflegekraft) **gemessen**.*
- Mit Modalverb: *Der Arzt **muss** informiert **werden**.* · Perfekt: *Die Temperatur **wurde** gemessen* (Präteritum Passiv, häufig schriftlich); *ist gemessen worden*.
- Quellen-Beispiele: „Die Strümpfe **dürfen** weder umgeschlagen **werden** noch einschneiden.“ (I care) · „Das Thermometer **wird** desinfiziert.“ **Zustandspassiv:** *sein + Partizip II*: *Die Tür **ist** geschlossen.* (Resultat). **Fehler:** „Der Arzt wird informiert“ vs. „Der Arzt ist informiert“ → Handlung vs. Ergebnis.

5. Nebensätze und Konnektoren (Verb am Ende)

Konnektor	Funktion	Beispiel (Pflege)
weil / da	Grund	Er hat Angst, **weil** er allein lebt.
dass	Inhalt	Ich beobachte, **dass** die Haut gerötet ist.
wenn	Bedingung/Zeit	**Wenn** die Temperatur steigt, informiere ich den Arzt.
ob	indirekte Ja/Nein-Frage	Ich prüfe, **ob** das Ziel erreicht wurde.
damit / um … zu	Zweck	Ich öffne das Fenster, **damit** frische Luft hereinkommt. · **Um** Stürze **zu** vermeiden, räume ich Stolperfallen weg.
obwohl	Gegengrund	**Obwohl** er Schmerzen hat, will er aufstehen.
sodass	Folge	… , **sodass** er auf Hilfe angewiesen ist.
nachdem / bevor / während	Zeit	**Bevor** ich beginne, desinfiziere ich die Hände.
deshalb/daher/deswegen	Hauptsatz-Folge (Verb Pos. 2)	Er ist verlegen, **deshalb** lehnt er Hilfe ab.

Regel: Nebensatz: **Konnektor … Verb am Ende** (*Sie sagt, dass sie Schmerzen **hat***). Steht der Nebensatz **zuerst**, folgt **Verb direkt** im Hauptsatz: *Weil er Angst hat, **braucht** er Gespräche.* **Operator ERKLÄREN → „weil“** (Übungsheft): immer Nebensatz mit *weil* üben.

6. Konjunktiv II – höfliche Bitten & Angebote

Funktion	Muster	Beispiel
Bitte	**Könnten/Würden Sie …?**	**Könnten** Sie bitte den Arm entspannen?
Angebot	**Möchten Sie …? / Würden Sie lieber …?**	**Würden** Sie lieber selbst Ihr Gesicht waschen?
Rat	**Ich würde …**	Ich **würde** Ihnen raten, die Schuhe anzuziehen.
Wunsch	**Ich hätte gern …**	

Formen: *könnte, würde, hätte, wäre, dürfte*. Höflichkeit = **Sie-Form + Konj. II + bitte/gern**.

7. Imperativ – Anleitung/Anweisung

Form	Beispiel	
Sie	**Setzen Sie** sich bitte. **Atmen Sie** tief ein.	höflich, Pflege-Standard
du (Kinder/Vertraute)	Setz dich. Atme tief.	nur wenn angemessen
Infinitiv-Anweisung (schriftlich)	**Hände desinfizieren.**	Hygiene-Schilder

Fehler: „Sie setzen sich!“ (befehlend). Besser: „**Könnten Sie sich bitte hinsetzen?**“ oder „Setzen Sie sich bitte.“

8. Objektive Sprache (Berichte/Dokumentation)

Subjektiv/wertend	Objektiv
„sieht schlimm aus“	„Wunde ca. 3 cm lang, gerötet, nässend“
„Pat. ist faul“	„Pat. lehnt Mobilisation ab (‚Mir tut alles weh‘)“

Subjektiv/wertend	Objektiv
„Pat. übertreibt“	„Pat. gibt Schmerzen (NRS 8) an; Mimik angespannt“

Verben der Wahrnehmung: *wirken* (Eindruck) · *äußern/angeben/klagen* (Aussage) · *beobachten* · *feststellen* (Messwert) · *vermuten* (Hypothese, kennzeichnen!). **Hedges:** „Möglicherweise“, „vermutlich“, „Hinweise auf …“, „spricht für …“ (für Interpretationen, Klausur).

9. Wortbildung/Medizinische Wörter

Komposita: *Blutdruck* = Blut + Druck; *Pflegeprozess*; *Sturzprophylaxe*; Artikel = **letztes Wort** (*der Druck → der Blutdruck*). **Suffixe:** -ung (f.): *Beobachtung, Messung, Lagerung*; -heit/-keit (f.): *Krankheit, Müdigkeit*; -er (m.): *Pfleger*; -ion/-tät (f.): *Infektion, Mobilität*; -mus (m.): *Rhythmus*. **Plural:** -e (*Bett→Betten*), -en (*Frau→Frauen*), Umlaut (*Hand→Hände*), -s (*Thermometer→Thermometer*, kein Plural-s!). **Nominalisierung:** *messen → die Messung; beobachten → die Beobachtung; mobilisieren → die Mobilisation*.

10. Hata analizi – nasıl öğrenirsiniz?

Yöntem: Hata → neden → doğru kalıp → 1 yeni cümle (kendi cümleniz). | Hata | Neden | Doğrusu | |---|---|---| | Er hat Angst, weil er **lebte** alleine. | Nebensatz: Verb am Ende | Er hat Angst, weil er **allein lebt/gelebt hat**. | | Ich messe **dem** Blutdruck. | Akkusativ | Ich messe **den** Blutdruck. | | Der Patient **ist** gelegen. | *liegen* bildet das Perfekt in der Schriftsprache meist mit *haben* (süddt. auch *sein*) | Der Patient **hat** im Bett **gelegen**. | | Die Pflegekraft hat **informieren** den Arzt. | Perfekt = haben + Partizip II | … hat den Arzt **informiert**. | | Pat. hat **starke Schmerzen** (nur beobachtet) | Aussage vs. Beobachtung | Pat. **äußert** starke Schmerzen. | (Sizin yazdığınız Herr-Schneider cevabındaki küçük hatalar: 06 §6.)

11. Pflege-Alıştırmalar (cevaplar altta)

1. Setze Passiv: *Die Pflegekraft desinfiziert das Thermometer.* 2. Verbinde mit *weil*: *Er trinkt kaum. Er hat keinen Durst.* 3. Höflich: *Setz dich!* 4. Akk./Dat.: *Ich zeige ___ (die Patientin) ___ (der Ablauf).* 5. Objektiv: *Sie sieht blass und krank aus.* 6. Perfekt: *Frau B. (stürzen) im Bad.* 7. Konnektor: *Ich dokumentiere die Maßnahme. Ich habe sie durchgeführt. → nachdem*. **Lösungen:** 1) Das Thermometer wird desinfiziert. 2) Er trinkt kaum, weil er keinen Durst hat. 3) Könnten Sie sich bitte hinsetzen? 4) der Patientin den Ablauf. 5) Haut blass; Pat. wirkt erschöpft, äußert Müdigkeit. 6) ist gestürzt. 7) Nachdem ich die Maßnahme durchgeführt habe, dokumentiere ich sie.

12 — Berufskontext in Deutschland (Bölüm K) und Lernplan (Bölüm L)

← 11 Grammatik · Ek 1 Wörterbuch →

Teil K — Ausbildungs- und Berufskontext

Kaynak ayrımı: Aşağıdaki tablo **önce PDF'lerden** gelir. PDF'de olmayan konular açıkça ⚠ ile işaretlendi. **Hukuki tavsiye değildir**; eyalet/okul/kurum farklılık gösterebilir. İnternet kaynaklarına bu oturumda sınırlı erişim (gesetze-im-internet.de açılmadı).

Konu	Ne biliyoruz (kaynak)	Not / nereden kontrol
Pflegefachfrau / Pflegefachmann	Unvan korumalı, devlet izni gerekli (PflBG § 1; Lernskript S. 5)	Resmî metin: gesetze-im-internet.de/pflbg
Ausbildung	Tam zamanlı **3 yıl**; Pflegeschule'de teorik+pratik ders + **praktische Ausbildung** (§ 6)	Müfredat, saatler, eyalet: okul/eyalet bakanlığı ⚠
Ausbildungsziel	selbstständig, umfassend, prozessorientiert pflegen (§ 5)	
Vorbehaltene Tätigkeiten	Bedarf erheben, Prozess steuern, Qualität sichern (§ 4)	Auszubildende ≠ vorbehaltene Aufgaben allein ausführen ⚠ genel prensip
Kompetenzbereiche (PflAPrV)	PDF'de yalnızca **Handlungskompetenz (KMK)**: Fach-, Personale-, Sozialkompetenz + Methoden-, Lern-, kommunikative Kompetenz (I care S. 47–48)	PflAPrV Anlage 1–5'teki **5 Kompetenzbereiche** PDF'de **yok** ⚠ okuldan isteyin
Praxisanleitung / Reflexion	Praxisanleiter: ≥ 300 Std. + 24 Std./Jahr (I care, PflAPrV 2018); Praxisanleiterinnen Eva, Renate, Silke in Fällen	Seviye/Saatler: ⚠ güncel PflAPrV'den doğrulayın
Pflegeprozess	Fiechter/Meier 6 Phasen	09
Hygiene/Infektionsprävention	Hygieneplan, RKI/KRINKO/IfSG, Hygienefachkraft	03
Datenschutz/Schweigepflicht	PDF'de kavramsal geçer (Intimsphäre, Mahremiyet)	⚠ ayrı öğrenin
Patientenrechte/Selbstbestimmung	Autonomie (Lernskript S. 2); Ablehnungsrecht pratikte	⚠ BGB § 630a ff., Patientenrechtegesetz PDF'de yok
Delegation/Verantwortung	Garantenstellung (Erste Hilfe F 78/232); Auszubildende nur im Kompetenzbereich (F 167)	⚠ Delegationsregeln PDF'de yok
Arbeitsschutz	BGW: ArbSchG, BioStoffV, TRBA 250, ArbMedVV, DGUV Vorschrift 1, MuSchG, JArbSchG	03 §9
Interprofessionelle Zusammenarbeit	SBAR, Arzt/PFK informieren, Therapeuten (Physio)	02b D7
Fort-/Weiterbildung	I care S. 47	

Sınavda güvenli ifade: „Nach meinem Kenntnisstand … (Quelle: Lernskript/Pflegeberufegesetz). Landes- und Einrichtungsstandards können abweichen."

Teil L — Esnek çalışma planı

Bilinmeyenler (sormam gereken): sınav tarihi, günlük çalışma süreniz, Almanca seviyeniz (A2/B1/B2…), sınav formatı (yazılı/sözlü/OSCE?), hangi konular önce sınavda. **Şimdilik varsaymadım**; aşağıdaki plan **modüler**dir.

1. Konu önceliği (belgelerden)

Öncelik	Konu	Neden
A	Pflegeprozess/ABEDL/PflBG · Operatoren · Hygiene (HD, 5 Momente) · Erste Hilfe BLS	her sınavda, pratik güvenlik
B	Haut/Dekubitus · Temperatur/Fieber · Sturz · Thrombose/Pneumonie	Prophylaxen-Fälle
C	Kommunikation-Modelle · Berührung/Nähe-Distanz	Fallanalyse
D	Zelle/Gewebe · BGW-Detaillar · Anatomie-Detaillar	arka plan

2. Günlük süre seçenekleri

Süre	Dağılım
30 dk	5 dk Wörter (Flashcards) · 10 dk aktives Hatırlama (konu kapat, yaz) · 10 dk soru · 5 dk eski konu
60 dk	10 Wörter · 20 Konu (Almanca+Türkçe) · 15 Soru · 10 Tekrar · 5 Zayıf-liste
90 dk	60’a +20 Schreibübung (Operator, Dokumentation) +10 Sprechen (D-Dialog sesli)

Günlük hedef: 1 ana konu + 10–15 Wörter + 5–10 soru + 1 tekrar.

3. Aralıklı tekrar (1–3–7–14)

Yeni konu günü	1. tekrar	2.	3.	4.
Gün 0	Gün 1	Gün 3	Gün 7	Gün 14

Her tekrarda: **kapalı kitap** özet yaz → boşlukları işaretle → flashcard → 3 soru. Yanlışlar → Ek 7 Takip tablosu “Zayıf konular”.

4. Örnek 4 haftalık iskelet (sınav tarihi bilinmiyorsa genel)

Hafta	Odak	Haftalık değerlendirme
1	Pflegeverständnis (01) · Operatoren (10) · Hygiene (03)	Klausur 1 + Hygiene-Quiz
2	Haut (04) · Temperatur (05) · Dokumentation (10)	Klausur 2
3	Mobilität/Sturz (06) · Thrombose/Pneumonie (07) · Pflegeprozess (09)	Klausur 4 + Fälle
4	Erste Hilfe (08) · Kommunikation (02) · Karma tekrar	Klausur 3 + mündlich simülasyon

Sınav öncesi yoğun tekrar (son 7 gün): Gün 7–5 zayıf konular · 4–3 deneme sınavı (zamanlı) · 2 flashcard+Operatoren · 1 hafif tekrar, uyku.

5. Haftalık kontrol listesi

☐ 5 yeni konu terimi ☐ 1 Dialog sesli ☐ 1 yazılı Operatoren görevi ☐ 20 flashcard ☐ Zayıf liste güncel ☐ Öğretmene 1 sorulacak çelişki (00 §4).

Ek 1 — Mesleki Almanca–Türkçe hemşirelik sözlüğü

← Ana rehber · **Sütunlar:** Almanca (artikel, çoğul) · Türkçe · Almanca açıklama · Örnek cümle · Kaynak (bölüm). ⚠ **Ilaç/Yara bakımı** kategorilerinde PDF'lerde az içerik var; oradaki terimler yalnızca belgede geçenlerdir (Antipyretika, Antikoagulanzien…). Çoğullar genel dil bilgisi (⚠ kontrol edin). Kısaltma: m=der, f=die, n=das.

1. Anatomi ve fizyoloji

Almanca	Türkçe	Açıklama (DE)	Beispiel	Kap.
das Herz, -en	kalp	muskuläres Hohlorgan, pumpt das Blut	Das Herz pumpt Blut in den Körper.	08
der Vorhof, ¨-e (Atrium)	kulakçık	obere Herzhöhle	Der rechte Vorhof erhält venöses Blut.	08
die Herzkammer, -n (Ventrikel)	karıncık	untere Herzhöhle	Die linke Kammer ist besonders kräftig.	08
die Herzklappe, -n	kalp kapağı	Ventil im Herzen	Herzklappen steuern die Blutrichtung.	08
das Endokard / Myokard / Perikard	endokart / miyokart / perikart	Herzinnenhaut / Muskel / Herzbeutel	Das Myokard leistet die Pumparbeit.	08
der Sinusknoten, ¨	sinüs düğümü	Taktgeber des Herzens	Der Impuls beginnt im Sinusknoten.	08
die Koronararterie, -n	koroner arter	Herzkranzgefäß	Ein Verschluss führt zum Infarkt.	08
die Aorta	aort	Hauptschlagader	Die linke Kammer pumpt Blut in die Aorta.	08
die Arterie, -n / die Vene, -n	atardamar / toplardamar	führt vom / zum Herzen	Arterien führen Blut vom Herzen weg.	08
die Kapillare, -n	kılcal damar	kleinstes Gefäß, Stoffaustausch	In den Kapillaren erfolgt der Austausch.	08
der Körperkreislauf / Lungenkreislauf	büyük / küçük dolaşım			08
der Blutdruck (RR)	kan basıncı	Druck des Blutes in den Gefäßen	Ich messe den Blutdruck.	08
systolisch / diastolisch	sistolik / diyastolik	Auswurf- / Füllungsphase	Der systolische Wert beträgt 120.	08
die Lunge, -n	akciğer	Atmungsorgan	Die rechte Lunge hat drei Lappen.	08
die Luftröhre (Trachea)	soluk borusu			08
die Alveole, -n / das Lungenbläschen	akciğer alveolü	Ort des Gasaustauschs	In den Alveolen wird O_2 aufgenommen.	08
die Ventilation / Diffusion / Perfusion	havalandırma / difüzyon / perfüzyon			08
die Inspiration / Exspiration	soluk alma / verme	Ein- / Ausatmung		08
das Zwerchfell	diyafram	Atemmuskel		08
die Zelle, -n	hücre	kleinste Einheit des Lebens	Die Zelle hat einen Zellkern.	04
der Zellkern	hücre çekirdeği	enthält DNS		04
das Mitochondrium (Pl. -ien)	mitokondri	Kraftwerk der Zelle (ATP)		04
das Gewebe, -	doku	Zellen mit gemeinsamer Funktion	Epithelgewebe bedeckt Organe.	04
das Epithel / das Bindegewebe	epitel / bağ dokusu			04

Almanca	Türkçe	Açıklama (DE)	Beispiel	Kap.
die Haut (¨-e)	cilt	größtes Organ	Die Haut schützt vor Erregern.	04
die Oberhaut (Epidermis)	epidermis	äußerste Hautschicht		04
die Lederhaut (Dermis)	dermis	mittlere Schicht		04
die Unterhaut (Subkutis)	deri altı	Fettgewebe		04
die Schleimhaut, ¨-e	mukoza	feuchte Auskleidung		04
der Hypothalamus	hipotalamus	Temperaturzentrum	Der Hypothalamus regelt die Temperatur.	05
das Gelenk, -e / der Muskel, -n / der Knochen, -	eklem / kas / kemik			06
das Gleichgewicht	denge			06

2. Hastalıklar ve belirtiler

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
die Thrombose, -n / der Thrombus	tromboz / pıhtı	Blutgerinnsel im Gefäß	Ein Thrombus verschließt die Vene.	07
die Lungenembolie, -n	akciğer embolisi	Gefäßverschluss in der Lunge	Plötzliche Atemnot kann auf eine Embolie hinweisen.	07/08
die Pneumonie, -n	zatürre	Lungenentzündung	Die Pneumonie wurde im Krankenhaus erworben.	07
die Aspiration	aspirasyon	Eindringen in die Atemwege		07
die Dysphagie	yutma güçlüğü	Schluckstörung		07
die Infektion, -en	enfeksiyon	Erreger dringen ein		03
die Entzündung, -en	iltihap	Gewebereaktion (5 Zeichen)		03
die Rötung / Schwellung / Überwärmung / Schmerz / Funktionseinschränkung	kızarıklık/şişlik/sıcaklık artışı/ağrı/fonksiyon kaybı	Rubor, Tumor, Calor, Dolor, Functio laesa		03
das Fieber	ateş	Sollwerterhöhung > 38 °C	Er hat 38,6 °C Fieber.	05
der Schüttelfrost	titreme	unwillkürliches Zittern		05
die Hypothermie / Hyperthermie	hipotermi / hipertermi			05
die Exsikkose	dehidratasyon	Austrocknung	Verminderter Turgor weist auf Exsikkose hin.	04/05
der Dekubitus	bası yarası	Druckgeschwür	Der Dekubitus entsteht am Kreuzbein.	04
die Zyanose	morarma	Blaufärbung (O_2-Mangel)		04
der Ikterus	sarılık	Gelbfärbung		04
die Kontraktur, -en	kontraktür	Gelenksteifigkeit		07
der Schock	şok	Minderdurchblutung der Organe		08
der Herzinfarkt, -e	kalp krizi	Koronararterienverschluss		08
der Schlaganfall / der Apoplex	inme	Durchblutungsstörung/Blutung im Gehirn		08
das Asthma bronchiale	astım	anfallsartige Atemnot		08
der Kreislaufstillstand	dolaşım durması			08

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
das Kammerflimmern / die Asystolie	ventriküler fibrilasyon / asistoli			08
die Gehirnerschütterung	beyin sarsıntısı			06
die Fraktur, -en	kırık			06
der Schwindel	baş dönmesi			06
die Übelkeit / das Erbrechen	bulantı / kusma			08
die Atemnot (Dyspnoe)	nefes darlığı			07/08
der Husten / der Auswurf	öksürük / balgam			07
die Inkontinenz	idrar/dışkı tutamama			06
die Obstipation	kabızlık			05/06
das Delir	deliryum	akute Verwirrtheit	Fieberdelir	05

3. İlaçlar ve uygulama (belgelerde sınırlı)

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
das Medikament, -e	ilaç		Bestimmte Medikamente verursachen Schwindel.	06
die Nebenwirkung, -en	yan etki	unerwünschte Wirkung		05
die Anordnung, -en	(doktor) talimatı	ärztliche Vorgabe	Nach Anordnung geben wir Medikamente.	02b
das Antipyretikum (Pl. -ka)	ateş düşürücü	fiebersenkendes Mittel		05
das Antibiotikum (Pl. -ka)	antibiyotik			07
die Antikoagulanzien (Pl.)	kan sulandırıcılar	hemmen die Blutgerinnung		07
das Analgetikum / das Schmerzmittel	ağrı kesici			02b
die Inhalation	inhalasyon			07
der Spacer / der Vernebler	spacer / nebülizatör			07
die Dosierung	dozaj	**nur ärztlich**		–
die Verabreichung	uygulama			–

4. Bakım ve hijyen

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
die Pflege / die Pflegefachperson	bakım / hemşire			01
der Pflegeempfänger	bakım alan			01
die Körperpflege	kişisel bakım			02b
die Intimpflege / die Intimsphäre	mahrem bölge bakımı / mahremiyet			02
die Mundpflege	ağız bakımı			07
die Waschung / der Wickel	yıkama / kompres			05
die Händedesinfektion (HD)	el dezenfeksiyonu			03
das Händewaschen	el yıkama			03
die Einwirkzeit	etki süresi			03
die Standardhygiene	standart hijyen			03
die Schutzkleidung	koruyucu giysi			03
der Handschuh, -e	eldiven			03
die Reinigung / Desinfektion / Sterilisation	temizlik / dezenfeksiyon / sterilizasyon			03
der Keim, -e / der Erreger, -	mikrop / etken			03
nosokomial	hastane kaynaklı			03
die Kolonisation	kolonizasyon			03

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
multiresistent (MRE, MRSA)	çoklu dirençli			03
der Hygieneplan	hijyen planı			03
die Nadelstichverletzung	iğne batması			03
der Kompressionsstrumpf	kompresyon çorabı			07
die Lagerung	pozisyon verme			07
die Mobilisation / die Frühmobilisation	mobilizasyon / erken mob.			06/07
die Prophylaxe, -n	profilaksi			06

5. Yaşamsal bulgular

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
die Vitalzeichen (Pl.)	yaşamsal bulgular	Puls, RR, Temperatur, Atmung	Ich kontrolliere die Vitalzeichen.	08
der Blutdruck	kan basıncı			08
der Puls / die Herzfrequenz	nabız / kalp hızı		Der Puls ist regelmäßig.	08
die Atemfrequenz	solunum sayısı	Atemzüge pro Minute	Ich kontrolliere die Atemfrequenz.	07
die Körpertemperatur	vücut ısısı			05
die Sauerstoffsättigung (SpO_2)	oksijen satürasyonu			08
die Tachykardie / Bradykardie	taşikardi / bradikardi			08
die Tachypnoe	hızlı solunum			08
die Hypotonie / Hypertonie	hipotansiyon / hipertansiyon			08
der Blutzucker (BZ)	kan şekeri			08
das Bewusstsein	bilinç			08
die Pupillenreaktion	pupil reaksiyonu			08
der Schockindex	şok indeksi	HF/RR sys		08

6. Yara bakımı / cilt (belgelerde sınırlı)

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
die Wunde, -n	yara		08
die Schnitt- / Platzwunde	kesik / yırtık yara	mechanische Wunde	08
die Verbrennung / Erfrierung	yanık / soğuk ısırığı	thermische Wunde	05/08
die Blutung / die Blutstillung	kanama / kanama durdurma		08
der Verbandwechsel	pansuman değişimi		03
die Wundinfektion	yara enfeksiyonu		03
nicht wegdrückbare Rötung	geçmeyen kızarıklık	Dekubitus Kat. I	04
das Panaritium	tırnak yatağı iltihabı		03

7. Beslenme ve sıvı dengesi

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
die Flüssigkeitszufuhr	sıvı alımı		Die Flüssigkeitszufuhr erhöhen.	07
die Trinkmenge / das Trinkprotokoll	içilen miktar / protokolü			07
die Ein- und Ausfuhr / die Bilanzierung	alınan-çıkan / bilanço			07
der Durst / das Durstgefühl	susuzluk			05

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
der Turgor	cilt gerginliği			04
die Mangelernährung	yetersiz beslenme			06
die orale / enterale / parenterale Ernährung	oral / enteral / parenteral			07
die Ernährungssonde	beslenme sondası			07
die Inappetenz	iştahsızlık			05
der Urin (konzentriert)	idrar (konsantre)			05

8. Hareket ve mobilizasyon

Almanca	Türkçe	Beispiel	Kap.
die Mobilität / die Immobilität	hareketlilik / hareketsizlik		06
aufstehen / hinsetzen / sich hinlegen	kalkmak / oturmak / yatmak	Ich helfe Ihnen beim Aufstehen.	06
der Transfer	transfer		06
das Gangbild	yürüyüş		06
der Rollator, der Rollstuhl	rolatör, tekerlekli sandalye		06
die Gehhilfe	yürüme yardımcısı		06
der Sturz / das Sturzrisiko	düşme / düşme riski		06
die Bettkante	yatak kenarı		02b
die Bremse (feststellen)	fren (kilitlemek)		06
rutschfest	kaymaz		06
der Vierfüßlerstand	emekleme pozisyonu		06

9. Acil durumlar

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
der Notruf (112)	acil çağrı		08
die Wiederbelebung / Reanimation (CPR)	resüsitasyon		08
die Herzdruckmassage	kalp masajı	100–120/min, 5–6 cm	08
die Beatmung	suni solunum		08
der Defibrillator / AED	defibrilatör		08
die stabile Seitenlage	koma pozisyonu		08
die Schnappatmung	agonal solunum		08
die Rettungskette	kurtarma zinciri		08
die Eigensicherung	kendini koruma		08
bewusstlos	bilinçsiz		08
der Rettungsdienst, die Leitstelle	kurtarma servisi, kontrol merkezi		08
der Kreislaufstillstand	dolaşım durması		08
das Reanimationsteam	resüsitasyon ekibi		08

10. Gözlem ve dokümantasyon

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
beobachten	gözlemek	aufmerksam wahrnehmen	10
beurteilen	değerlendirmek	Schlüsse ziehen	10
dokumentieren	belgelemek		10
die Pflegedokumentation	bakım dokümantasyonu		10
die Pflegeplanung	bakım planlaması		09
der Befund	bulgu		10
auffällig / unauffällig	dikkat çekici / normal		10

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
angeben / äußern / klagen über	belirtmek / ifade etmek / şikâyet etmek		10
das Sturzprotokoll	düşme protokolü		06
die Übergabe	devir-teslim		02b
SBAR	durum-geçmiş-değerlendirme-öneri		02b
die Evaluation	değerlendirme		01

11. İletişim ve hasta yakınları

Almanca	Türkçe	Kap.
sich vorstellen	kendini tanıtmak	02b
begrüßen / verabschieden	karşılamak / vedalaşmak	02
zuhören / nachfragen	dinlemek / tekrar sormak	02
die Ich-Botschaft	ben-dili	02
verständlich erklären	anlaşılır açıklamak	02b
der Angehörige / die Angehörigen	hasta yakını / yakınlar	02b
die Wertschätzung	değer verme	02
die Empathie / einfühlsam	empati / duyarlı	02
die Angst / die Sorge	korku / endişe	02
das Schweigen	sessizlik	02

12. Etik, mahremiyet, hasta hakları

Almanca	Türkçe	Kap.
die Selbstbestimmung / Autonomie	özerklik	01
die Würde	onur	02
die Intimsphäre	mahremiyet	02
die Schweigepflicht	sır saklama yükümlülüğü	02b
der Datenschutz	veri koruma	02b
die Einwilligung	onay	08
ablehnen	reddetmek	02b
die Patientenverfügung ⚠	hasta talimatı	08
die Wertschätzung / die Respekt	saygı	02

13. Hukuki sorumluluklar

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
die unterlassene Hilfeleistung	yardım etmeme	§ 323c StGB	08
die Garantenstellung	garantör konumu	besondere Einstandspflicht	08
der rechtfertigende Notstand	meşru zorunluluk hali	§ 34 StGB	08
die Behandlungspflicht	tedavi yükümlülüğü		08
die vorbehaltenen Aufgaben	saklı görevler	§ 4 PflBG	01
das Pflegeberufegesetz (PflBG)	Hemşirelik Meslekleri Yasası		01
das Infektionsschutzgesetz (IfSG)	Enfeksiyondan Korunma Yasası		03
die Arbeitsschutz / Berufsgenossenschaft	iş güvenliği / meslek sigortası kurumu		03
die Sorgfaltspflicht	özen yükümlülüğü		08
die Haftung	sorumluluk		08

14. Ekip ve doktorla iletişim

Almanca	Türkçe	Kap.
der Arzt / die Ärztin	doktor	02b
die Praxisanleiterin / die Praxisanleitung	uygulama eğitmeni	02b
die zuständige Pflegefachkraft	sorumlu hemşire	02b
die Hygienefachkraft	hijyen uzmanı	03
der Betriebsarzt	işyeri hekimi	03
die Physiotherapie	fizyoterapi	07
der Sozialdienst	sosyal hizmetler	09
das Team / die Zusammenarbeit	ekip / iş birliği	02
informieren / melden / benachrichtigen	bilgilendirmek / bildirmek	02b
die Rücksprache halten	danışmak	02b

15. Karıştırılan kelime çiftleri (Bölüm C)

Çift	Fark	Örnek
Symptom ↔ Diagnose	Symptom = Beschwerde/Zeichen (Fieber, Husten); Diagnose = Name der Krankheit, **ärztlich** (Pneumonie)	„Fieber ist ein Symptom, keine Diagnose.“
Pflegeplanung ↔ Pflegedokumentation	Planung = Ziele/Maßnahmen vorab; Dokumentation = Nachweis von Beobachtung/Durchführung	
Beobachten ↔ Beurteilen	Wahrnehmen ↔ Schlussfolgern	
Infektion ↔ Entzündung	Erreger eindringen ↔ Gewebereaktion (kann ohne Erreger)	
Schmerzen haben ↔ Schmerzen äußern	empfinden ↔ mitteilen/zeigen	
Prophylaxe ↔ Prävention	konkrete Komplikation verhindern ↔ allgemein Gesundheit erhalten/fördern	
Kolonisation ↔ Infektion	ohne ↔ mit Symptomen	
Fieber ↔ Hyperthermie	Sollwert hoch ↔ Regulation überfordert	
Desinfektion ↔ Sterilisation	keimarm ↔ keimfrei	
Thrombose ↔ Embolie	Gerinnsel am Ort ↔ verschleppt	
Ventilation ↔ Perfusion	Belüftung ↔ Durchblutung	
Mobilität ↔ Mobilisation	Fähigkeit ↔ Maßnahme	
Ressource ↔ Problem	Fähigkeit ↔ Beeinträchtigung	
Sturz ↔ Absturz	Boden/tiefere Ebene ↔ aus erhöhter Position	
BLS ↔ ALS	Basis ↔ erweitert	
Lysis ↔ Krisis	langsam ↔ abrupt (Notfall)	
Hautarten Leisten- ↔ Felderhaut	Hände/Füße ↔ Rest	
Mitose ↔ Meiose	2 gleiche ↔ 4 verschiedene	
Arterie ↔ Vene	weg vom ↔ zum Herzen	

Ek 2 — Sınavda kullanılabilecek Almanca cümle kalıpları

> ← Ana rehber · Kullanım: Kalıbı seçin → boşluğu konuyla doldurun. **Kural:** Operatör ile kalıbı eşleştirin (10).

1. Tanımlama (DEFINIEREN / BESCHREIBEN)

- **X ist …** / **Unter X versteht man …** — *Unter Prophylaxe versteht man Maßnahmen, die Komplikationen vorbeugen.*
- **X bezeichnet …** — *Mobilität bezeichnet die Fähigkeit, sich selbstständig zu bewegen.*
- **Charakteristisch für X ist …** — *Charakteristisch für Fieber ist die Sollwerterhöhung im Hypothalamus.*
- **X besteht aus …** — *Die Haut besteht aus Ober-, Leder- und Unterhaut.*
- **Es zeigt sich …/Auffällig ist …** — *Auffällig ist eine nicht wegdrückbare Rötung am Kreuzbein.*

2. Erklären / Begründen

- **… weil … / da …** — *Er hat Angst, weil er bisher allein gelebt hat.*
- **Das liegt daran, dass …** — *Das liegt daran, dass die Muskel-Venen-Pumpe bei Immobilität nicht aktiviert wird.*
- **Aus diesem Grund / Deshalb / Daher …** — *Aus diesem Grund ist Frühmobilisation wichtig.*
- **Dies führt dazu, dass …** — *Dies führt dazu, dass das Blut langsamer fließt.*
- **… sodass …** — *… sodass er auf Hilfe angewiesen ist.*
- **Dafür spricht, dass … / Ein Argument dafür ist …**

3. Vergleichen

- **Im Gegensatz zu … / Während …, …** — *Während Fieber auf einer Sollwerterhöhung beruht, ist Hyperthermie ein Versagen der Wärmeabgabe.*
- **Beide … / Gemeinsam ist …** — *Gemeinsam ist beiden, dass die Temperatur erhöht ist.*
- **Der Unterschied besteht darin, dass …**
- **Ähnlich wie … / Anders als …**

4. Beschreiben von Zeichen/Beobachtungen

- **Ein wichtiges Anzeichen dafür ist …** — *Ein wichtiges Anzeichen für eine Exsikkose ist eine stehende Hautfalte.*
- **Typische Symptome sind …** — *Typische Symptome einer Lungenembolie sind plötzliche Atemnot und Brustschmerz.*
- **… weist auf … hin** — *Ein verminderter Turgor weist auf Flüssigkeitsmangel hin.*
- **… spricht für …** — *Rötung, Schwellung und Überwärmung sprechen für eine Entzündung.*

5. Maßnahmen

- **Die Pflegemaßnahme dient dazu, … (zu …)** — *Die Frühmobilisation dient dazu, einer Thrombose vorzubeugen.*
- **Um … zu …, wird/werden …** — *Um Stürze zu vermeiden, werden Stolperfallen entfernt.*
- **Zunächst ist zu beachten, dass …** — *Zunächst ist zu beachten, dass der Patient informiert und einverstanden sein muss.*
- **Zuerst … anschließend … zuletzt …**
- **Dabei ist darauf zu achten, dass …** — *Dabei ist darauf zu achten, dass die Intimsphäre gewahrt bleibt.*
- **Mithilfe von … kann … erreicht werden**

6. Evaluation / Kontrolle

- **Anschließend wird überprüft, ob …** — *Anschließend wird überprüft, ob das Ziel erreicht wurde.*
- **Die Maßnahme ist wirksam, wenn …**
- **Falls das Ziel nicht erreicht wird, wird die Planung angepasst.**

7. Eskalation / Sicherheit

- **Bei einer Verschlechterung des Zustands muss …** — *… muss die Pflegefachkraft bzw. der Arzt umgehend informiert werden.*
- **Bei … ist sofort der Notruf 112 abzusetzen.**
- **Die Maßnahme darf nur nach ärztlicher Anordnung / nach Rücksprache mit der PFK erfolgen.**
- **Dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der Auszubildenden.**

8. Folgern / Zusammenfassen / Urteilen (AFB III)

- **Daraus ergibt sich …** / **Folglich …**
- **Zusammenfassend lässt sich sagen, dass …**
- **Meiner Einschätzung nach … , weil …** / **Ich komme zu dem Schluss, dass …**
- **Einerseits …, andererseits …** (Pro/Contra) · **Abschließend …**
- **Aus Sicht des Patienten könnte … bedeuten, dass …** (DEUTEN)

9. Hastayla iletişim kalıpları

Amaç	Cümle
Tanışma	Guten Tag, ich bin … und für Sie zuständig.
İzin	Darf ich hereinkommen? / Ist es in Ordnung, wenn …?
Açıklama	Ich werde jetzt … Das dauert etwa …
Seçenek	Möchten Sie das lieber selbst machen?
Anlama kontrolü	Haben Sie das verstanden? Möchten Sie noch etwas fragen?
Empati	Das verstehe ich. / Das muss unangenehm sein.
Ağrı	Wo genau haben Sie Schmerzen? Wie stark auf einer Skala von 0 bis 10?
Sınır	Das darf ich nicht entscheiden; ich frage die zuständige Pflegefachkraft.
Hata/Risk	Mir ist aufgefallen, dass … Ich möchte das melden.
Acil	Hilfe! Der Patient reagiert nicht und atmet nicht normal!

10. Doktor / Ekip (SBAR)

S: *Ich rufe an wegen Herrn …, Zimmer … Seine Temperatur ist auf … gestiegen.* · **B:** *Er ist … Jahre alt, Z. n. …* · **A:** *Ich schätze die Situation so ein, dass …* · **R:** *Ich bitte um … / Soll ich …?*

11. Geçiş sözcükleri

zunächst · außerdem · darüber hinaus · allerdings · dennoch · jedoch · deshalb · folglich · schließlich · abschließend · beispielsweise · insbesondere · gegebenenfalls (ggf.) · in der Regel · vor allem

Ek 3 — En önemli konuların kısa tekrar notları

> ← Ana rehber · Tek sayfa tekrar kartı: her konuyu **kapalı kitap** hatırlayabilmelisiniz.

1. Pflegeverständnis (LF1A) → 01

- Prof. Pflege = fachlich begründet, **geplant**, Verantwortung, Beziehung · Selbstpflege/informelle Hilfe/prof. Pflege.
- Bedürfnis · Problem · **Ressource** · **Autonomie**.
- Kompetenzen: Fach, Methoden (+Kommunikation, Lernen), Sozial, Selbst/Personal.
- **13 ABEDL** (Krohwinkel): Kommunizieren, Bewegen, Vitale Funktionen, Pflegen, Essen/Trinken, Ausscheiden, Kleiden, Ruhen/Schlafen, Beschäftigen/Lernen, Sexualität, Sichere Umgebung, Soziale Bereiche, Existenzielle Erfahrungen.
- **Pflegeprozess 6**: Info – Probleme/Ressourcen – Ziele – Maßnahmen – Durchführung – Evaluation (Kreislauf).
- **PflBG**: § 1 Bezeichnung · § 4 vorbehalten (Bedarf erheben/planen; Prozess steuern; Qualität sichern) · § 5 Ziel · § 6 3 Jahre.

2. Kommunikation → 02

- Laswell: Nachricht–Sender–Empfänger. **Schulz von Thun**: Sach, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell (4 Ohren). **Watzlawick** 5 Axiome. verbal/nonverbal/paraverbal; kongruent/inkongruent.
- Feedback: Respekt, Verhalten statt Person, **Ich-Botschaft**, konkret, Wünsche.
- Begrüßung = Vertrauen; infantilisierende Sprache vermeiden; **Initialberührung**; Hall-Zonen; Nähe–Distanz; Beziehung: Akzeptanz, Echtheit, Empathie, Annehmen.

3. Hygiene → 03

- Hände = Hauptübertragungsweg · Waschen–Desinfizieren–Pflegen · **WHO 5 Momente** · **≥ 30 s**, Hände trocken, Schmuck ab · Handschuhe ersetzen HD nicht · C. diff: auch waschen.
- endogen/exogen · direkt/indirekt · nosokomial · Kolonisation/Infektion · MRSA/VRE/ESBL/MRGN.
- Reinigung (≤ 80 %) · Desinfektion (keimarm) · Sterilisation (keimfrei).
- NSV: Blut fließen lassen/spülen/desinfizieren → Arzt → PEP ≤ 2 h → Meldung → dokumentieren. Risiko HBV 30 %, HCV 3 %, HIV 0,3 %.

4. Haut → 04

- 3 Schichten · Funktionen · Säureschutzmantel pH 5,5 · **Turgor** · Zyanose (Lippen/Nägel; dunkle Haut: grau, Schleimhäute) · Recap < 2–3 s · **5 Entzündungszeichen** · Dekubitus (**Fingertest**) · ABCDE-Regel.
- Mitose 2 gleich / Meiose 4 verschieden · 4 Grundgewebe · Epithel gefäßlos.

5. Temperatur → 05

- Kern 37 °C; Hypothalamus Sollwert · Messorte (rektal genau; axillar nur Schale) · gleiche Stelle.
- Fieber = Sollwert > 38,0; Symptom. **3 Phasen**: Anstieg (wärmen) / Höhe / Abfall (Lysis/**Krisis**). Wadenwickel: lauwarm, max. 10 °C kälter, 5–10 min wechseln, KI kalte Füße. **Nie kühlen im Anstieg.**
- Hypothermie < 35 °C (3 Stadien) · Hyperthermie ≠ Fieber · Hitzschlag Notfall.

6. Mobilität & Sturz → 06

- Mobilität/eingeschränkt/Immobilität · Veränderungen im Alter nicht „normal“ · Folgen: Sturz, Thrombose, Dekubitus, Kontraktur, Obstipation, Isolation.
- Sturz-Ursachen: Gleichgewicht, Muskelschwäche, Sehen, Schwindel, Angst, Schuhe, Medikamente, Inkontinenz.

- Nach Sturz: beruhigen–Hilfe–Verletzungen–(Fraktur?)–Vitalzeichen–**Protokoll**–informieren; 24 h Hirndruck beobachten.

7. Prophylaxen → 07

- **Virchow**: Kreislauf, Wand, Blut. Basis: Frühmobilisation, Bewegungsübungen, Trinken. **Beine nicht ausstreichen.** MTPS wirken im Liegen; Passform; KI pAVK, Neuropathie, Ödem, Defekte.
- **LISA** (Lunge, Infektion, Sekret, Aspiration) · typische/atypische Pneumonie · CRB-65 · Aspirationspneumonie nicht infektiös.

8. Erste Hilfe → 08

- Eigensicherung → Reaktion → Atemweg → Atmung ≤ 10 s (SHF) → Hilfe/112 → **30:2, 100–120/min, 5–6 cm** → AED → bis RD.
- Bewusstlos+Atmung = stabile Seitenlage. Notruf W-Fragen. §323c, Garantenstellung, §34.
- Schock 4 Formen; Schockindex HF/RR (≥ 1). Infarkt, Apoplex, LE, Asthma, Blutung. ABCDE. SBAR.

9. Operatoren & Dokumentation → 10

- AFB I: nennen, beschreiben, zuordnen, zusammenfassen, definieren · II: ermitteln, erklären (weil), vergleichen, anwenden · III: begründen, diskutieren, Stellung beziehen, entwickeln, deuten.
- Doku: Beobachtung ≠ Interpretation; Zeit/Befund/Maßnahme; Aussagen zitieren; nur Durchgeführtes.

Ek 4 — Flashcard seti (119 kart)

← Ana rehber · **Anki/Quizlet:** `Ek4_Flashcards.csv` (UTF-8, Sütunlar: Konu;Soru;Cevap;Türkçe;Kaynak). Kaynak sütunu = rehber bölümü (01–10).

Kullanım: Soruyu okuyun, **sesli** Almanca cevaplayın, sonra kontrol edin. Yanlışlar → Ek 7. Aralıklı tekrar: 1–3–7–14 gün.

Pflege

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Was unterscheidet professionelle Pflege von Alltagshilfe?	Fachwissen, systematisches Vorgehen, Verantwortung, Beziehungsgestaltung; fachlich begründet und geplant.	Mesleki bakım: bilgi, sistematik, sorumluluk, ilişki.	01
2	Definiere Ressource.	Fähigkeit, Stärke, Möglichkeit oder Unterstützung, die ein Mensch nutzen kann.	Kaynak: kişinin sahip olduğu yetenek/güç/destek.	01
3	Definiere Bedürfnis.	Etwas, das ein Mensch für körperliches, psychisches oder soziales Wohlbefinden braucht.	İhtiyaç.	01
4	Definiere Selbstbestimmung (Autonomie).	Ein Mensch entscheidet frei und eigenverantwortlich, wie er leben und handeln will.	Özerklik.	01
5	Nenne die 4 Kompetenzbereiche (Lernskript).	Fach-, Methoden-, Sozial-, Selbstkompetenz.	Dört yeterlilik alanı.	01
6	Nenne die 6 Phasen des Pflegeprozesses.	Informationssammlung – Probleme/Ressourcen – Ziele – Maßnahmen planen – Durchführung – Evaluation.	Bakım süreci 6 aşama.	01
7	Warum ist die Evaluation wichtig?	Wirkung prüfen und Planung anpassen; der Pflegeprozess ist ein Kreislauf.	Değerlendirme olmadan plan uyarlanmaz.	01
8	Nenne die 3 vorbehaltenen Aufgaben (§ 4 PflBG).	Pflegebedarf erheben + Pflege planen; Pflegeprozess organisieren/steuern; Qualität analysieren/sichern/weiterentwickeln.	Saklı görevler.	01
9	Wie lange dauert die Ausbildung (§ 6 PflBG)?	Vollzeit 3 Jahre (Pflegeschule + praktische Ausbildung).	3 yıl.	01
10	ABEDL 1–4?	Kommunizieren; Sich bewegen; Vitale Funktionen; Sich pflegen.	ABEDL 1-4	01
11	ABEDL 5–8?	Essen/trinken; Ausscheiden; Sich kleiden; Ruhen/schlafen/entspannen.	ABEDL 5-8	01
12	ABEDL 9–13?	Beschäftigen/lernen; Sexualität; sichere Umgebung; soziale Bereiche; existenzielle Erfahrungen.	ABEDL 9-13	01
13	Wer entwickelte die 13 ABEDL?	Monika Krohwinkel.	Krohwinkel.	01

Kommunikation

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Nenne die 4 Seiten einer Nachricht.	Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungshinweis, Appell.	Dört yön (Schulz v. Thun).	02
2	Nenne die 4 Ohren.	Sachverhalts-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs-, Appellohr.	Dört kulak.	02
3	Was besagt Axiom 1 (Watzlawick)?	Man kann nicht nicht kommunizieren.	İletişimsiz olunmaz.	02

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
4	Digital vs. analog?	Digital = Sachinformation; analog = Gestik, Mimik, Tonfall (Beziehung).	Dijital/analog.	02
5	Symmetrisch vs. komplementär?	Gleichrangig (Augenhöhe) vs. hierarchisch.	Simetrik/tamamlayıcı.	02
6	Kongruente Nachricht?	Verbale und nonverbale Botschaft stimmen überein.	Uyumlu mesaj.	02
7	Nenne 3 Feedbackregeln.	Respekt; Verhalten statt Person; Ich-Botschaften; konkrete Situation; Wünsche.	Geri bildirim kuralları.	02
8	Was ist infantilisierende Sprache?	Kindliche/abwertende Sprache gegenüber Erwachsenen (z. B. „Popo“).	Çocuklaştırıcı dil.	02
9	Was ist eine Initialberührung?	Bewusster Beginn einer Pflegehandlung durch Berührung (z. B. Hand auf Schulter) – gibt Orientierung.	Başlangıç dokunuşu.	02
10	Was bedeuten Akzeptanz/Echtheit/Empathie?	Grundlagen professioneller Beziehung: annehmen ohne Wertung, kongruent, einfühlsam.	Profesyonel ilişki unsurları.	02
11	Formelle vs. informelle Kommunikation?	Formell: geplant, regelgeleitet, offiziell; informell: zwanglos.	Resmi/resmi olmayan.	02

Hygiene

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Wodurch werden die meisten Erreger übertragen?	Durch die Hände.	Eller.	03
2	Nenne die 3 Schritte der Händehygiene.	Waschen – desinfizieren – pflegen.	3 adım.	03
3	Nenne die 5 Momente der HD (WHO).	Vor Patientenkontakt; vor aseptischen Tätigkeiten; nach Kontakt mit infektiösem Material; nach Patientenkontakt; nach Kontakt mit Patientenumgebung.	WHO 5 an.	03
4	Mindest-Einwirkzeit HD (BGW)?	Mindestens 30 Sekunden (Herstellerangaben).	≥ 30 sn.	03
5	Welche Bereiche werden bei HD oft vergessen?	Daumen, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume.	Başparmak, parmak uçları.	03
6	Warum HD nach Handschuhen?	Mikroperforationen und Kontamination beim Ausziehen; Handschuhe ersetzen HD nicht.	Eldiven HD’nin yerini tutmaz.	03
7	Wann waschen statt nur desinfizieren?	Sichtbar schmutzig, nach Toilette, Niesen/Husten; bei C. difficile zusätzlich.	Yıkama zamanları.	03
8	Reinigung vs. Desinfektion vs. Sterilisation?	Schmutz/bis 80 % Keime; die meisten Erreger (keimarm); alle vermehrungsfähigen (keimfrei).	Temizlik/dezenfeksiyon/sterilizasyon.	03
9	Was ist eine nosokomiale Infektion?	Im Krankenhaus/Pflegeheim erworbene Infektion.	Hastane kaynaklı enfeksiyon.	03
10	Endogen vs. exogen?	Erreger aus dem Körper selbst vs. von außen.	Endojen/eksojen.	03
11	Kolonisation vs. Infektion?	Besiedlung ohne Symptome vs. Eindringen, Vermehrung, Abwehrreaktion.	Kolonizasyon/enfeksiyon.	03
12	Was ist MRSA?	Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (multiresistenter Erreger).	MRSA.	03
13	Risiko nach NSV: HBV/HCV/HIV?	ca. 30 % / 3 % / 0,3 %.	Bulaş riski.	03
14	Sofortmaßnahmen nach NSV?	Blutfluss fördern/spülen/desinfizieren → Arzt; HIV-PEP innerhalb 2 Std.; Meldung;	NSV sonrası.	03

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
		Dokumentation.		
15	Warum Schmuck ablegen?	Nur ohne Schmuck ist wirksame Reinigung/Desinfektion möglich.	Takı çıkar.	03
16	Was ist ein Hygieneplan?	Vorgabe: Mittel, Einwirkzeit, wer/wann.	Hijyen planı.	03

Haut

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Nenne die 3 Hautschichten.	Oberhaut (Epidermis), Lederhaut (Dermis), Unterhaut (Subkutis).	3 tabaka.	04
2	Funktion Oberhaut?	Barriere, Wasserschutz, UV-Schutz (Melanozyten), Säureschutzmantel pH 5,5.	Epidermis.	04
3	pH-Wert Säureschutzmantel?	5,5.	pH 5,5.	04
4	Was ist Turgor?	Spannungszustand der Haut (Flüssigkeitsgehalt).	Cilt gerginliği.	04
5	Verminderter Turgor bedeutet?	Stehende Hautfalte → Flüssigkeitsmangel (Exsikkose).	Dehidratasyon.	04
6	Wo zeigt sich Zyanose zuerst?	Lippen und Fingernägel.	Dudak/tırnak.	04
7	Zyanose bei dunkler Haut?	Grau/maronenfarben, blasse Areale; Zunge, Zahnfleisch, Bindehaut, Nagelbett prüfen.	Koyu ciltte.	04
8	Recap-Test: Normalwert?	Farbe kehrt in < 2–3 Sek. zurück.	Kapiller dolum.	04
9	Nenne die 5 Entzündungszeichen (lat.).	Rubor, Tumor, Calor, Dolor, Functio laesa.	5 iltihap belirtisi.	04
10	Fingertest negativ/positiv?	Negativ: Rötung verblasst unter Druck; positiv: bleibt (Dekubitus Kat. I).	Parmak testi.	04
11	Häufige Dekubitus-Stellen?	Kreuzbein, Fersen, Hüfte.	Bası bölgeleri.	04
12	ABCDE-Regel (Haut)?	Asymmetrie, Begrenzung, Color, Durchmesser > 5 mm, Entwicklung.	ABCDE kuralı.	04
13	Mitose vs. Meiose?	Mitose: 2 identische Körperzellen; Meiose: 4 verschiedene Keimzellen.	Mitoz/mayoz.	04
14	Hat Epithel Blutgefäße?	Nein, Ernährung per Diffusion.	Hayır.	04
15	Wo wird Vitamin D gebildet?	In der Haut.	Deride.	04

Temperatur

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Normale Kerntemperatur?	ca. 37 °C (Sollwert 36–37,5 °C).	≈ 37 °C.	05
2	Wer steuert die Thermoregulation?	Der Hypothalamus.	Hipotalamus.	05
3	Genaueste Messung?	Rektal (Kerntemperatur).	Rektal.	05
4	Axillar misst?	Nur die Körperschalentemperatur.	Kabuk ısısı.	05
5	Fieber ab?	> 38,0 °C (Sollwerterhöhung).	Ateş > 38.	05
6	Fieber vs. Hyperthermie?	Fieber: neuer Sollwert; Hyperthermie: Regulation überfordert.	Fark.	05
7	Drei Fieberstadien?	Anstieg – Höhe – Abfall.	3 evre.	05
8	Fieberanstieg: Haut & Pflege?	Blass, kalt, Zittern → wärmen; keine Kühlung.	Isıt.	05
9	Lysis vs. Krisis?	Langsamer vs. rascher Fieberabfall; Krisis = Kreislaufgefahr/Notfall.	Lizis/kriz.	05
10	Wadenwickel: Wassertemperatur?	Lauwarm, max. 10 °C kälter als Körpertemperatur.	Ilık.	05
11	Wadenwickel: Wechsel & Kontraindikation?	Nach 5–10 min wechseln; kalte Füße/Hände, Durchblutungsstörung.	5-10 dk.	05
12	Hypothermie ist?	Kerntemperatur < 35 °C.	< 35 °C.	05

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
13	Puls pro 1 °C Fieber?	ca. +8–10 (–12)/min.	+8-10 nabız.	05
14	Was ist Durstfieber?	Säuglinge, Flüssigkeitsmangel, keine Sollwerterhöhung (Hyperthermie).	Susuzluk ateşi.	05
15	Warum gleiche Messstelle?	Vergleichbarkeit der Werte.	Karşılaştırılabilirlik.	05
16	Was dokumentierst du bei Temperatur?	Zeit, Ort, Ergebnis, flankierende Therapie.	Belgele.	05

Mobilität

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Mobilität – Definition?	Fähigkeit, sich selbstständig zu bewegen und Position/Ort zu verändern.	Hareketlilik.	06
2	Immobilität?	Stark eingeschränkte/fehlende selbstständige Bewegung.	Hareketsizlik.	06
3	Folgen von Immobilität (Körper)?	Muskelabbau, Sturz-, Thrombose-, Dekubitus-, Kontrakturrisiko, Obstipation.	Sonuçlar.	06
4	Prophylaxe vs. Prävention?	Prophylaxe: Komplikation vermeiden; Prävention: vermeiden + Gesundheit erhalten/fördern.	Fark.	06

Sturz

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Definition Sturz?	Unbeabsichtigtes Aufkommen auf dem Boden/tieferer Ebene.	Düşme.	06
2	Absturz?	Sturz aus erhöhter Position.	Yüksekten düşme.	06
3	Nenne 5 Sturzursachen.	Gleichgewicht, Muskelschwäche, Sehstörung, Schwindel, Angst, Schuhe, Medikamente, Inkontinenz.	Nedenler.	06
4	Schnellscreening (3 Fragen)?	Im letzten Jahr gestürzt? Unsicher beim Gehen? Angst zu stürzen?	3 soru.	06
5	Was nach Sturz zuerst?	Beruhigen, 2. Pflegeperson rufen, Verletzungen beachten.	İlk adım.	06
6	Hirndruckzeichen (24 h)?	Lichtstarre/Pupillen, Druckpuls (RR hoch, Puls niedrig).	Kafa içi basınç.	06
7	Inhalt Sturzprotokoll?	Person, Datum/Ort, Umgebung, Befinden, Aktivität davor, Maßnahmen, Folgen.	Protokol.	06

Thrombose

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Virchow-Trias?	Verlangsamter Blutfluss, Gefäßwandschäden, erhöhte Gerinnungsneigung.	Virchow.	07
2	Expositionell vs. dispositionell?	Akut/zeitlich begrenzt (OP, Trauma, Immobilisation) vs. angeboren/erworben Basisrisiko.	Fark.	07
3	Basismaßnahmen?	Frühmobilisation, Bewegungsübungen (aktiv/passiv), ausreichend Flüssigkeit.	Temel önlemler.	07
4	Beine hochlegen/ausstreichen?	Hochlegen keine Prophylaxe; Ausstreichen nicht (kann Thromben lösen).	Yapma.	07
5	MTPS: wann wirksam?	Nur bei liegenden Patienten.	Yatan hastada.	07
6	Kontraindikationen MTPS?	pAVK, schwere Neuropathie, ausgeprägte Ödeme, lokale Defekte/Nekrosen.	KI.	07
7	Folge einer losgelösten Thrombose?	Lungenembolie.	Akciğer embolisi.	07

Pneumonie

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	LISA?	Lungenbelüftung, Infektionen vermeiden, Sekret mobilisieren, Aspiration vermeiden.	LISA.	07
2	Typische Pneumonie?	Plötzlicher Beginn, hohes Fieber/Schüttelfrost, produktiver Husten, starke Atemnot.	Tipik.	07
3	Atypische Pneumonie?	Schleichend, leichtes Fieber, trockener Husten, Grippesymptome.	Atipik.	07
4	CRB-65?	Confusion, Respiratory rate ≥ 30, Blutdruck niedrig, Alter ≥ 65; ab 1 Punkt stationär.	CRB-65.	07
5	Aspirationspneumonie: infektiös?	Nein (Sonderform, nicht primär infektiös); Symptome 2–12 Std. verzögert.	Enfeksiyöz değil.	07
6	Atemerleichternde Maßnahmen?	Lippenbremse, Kutschersitz, Oberkörperhochlage, VATI-Lagerung.	Nefes rahatlatıcı.	07

Erste Hilfe

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Atemkontrolle: wie lange, wie?	Höchstens 10 Sek., Sehen–Hören–Fühlen.	≤ 10 sn.	08
2	Keine Reaktion + keine normale Atmung?	Verdacht auf Kreislaufstillstand → Notruf + CPR.	Dolaşım durması.	08
3	Schnappatmung?	Keine normale Atmung; kann bei Kreislaufstillstand auftreten.	Agonal solunum.	08
4	Herzdruckmassage Erwachsene: Zahlen?	30:2, 100–120/min, 5–6 cm, volle Entlastung, Wechsel alle 2 Min.	CPR rakamları.	08
5	Druckpunkt?	Mitte Brustkorb / unteres Sternumdrittel.	Basınç noktası.	08
6	Notruf: W-Fragen?	Wo? Wer? Was? Wie viele? Warten auf Rückfragen.	5 W.	08
7	AED-Ablauf?	Einschalten, Elektroden, Anweisungen, niemand berühren, Schock, sofort CPR.	AED.	08
8	Stabile Seitenlage wann?	Bewusstlos, aber normale Atmung.	Koma pozisyonu.	08
9	§ 323c StGB?	Unterlassene Hilfeleistung: Pflicht zu helfen, wenn erforderlich und zumutbar.	Yardım etmeme.	08
10	Garantenstellung?	Besondere Einstandspflicht gegenüber anvertrauten Patienten.	Garantör.	08
11	§ 34 StGB?	Rechtfertigender Notstand: mildestes Mittel, höheres Rechtsgut überwiegt.	Meşru zorunluluk.	08
12	4 Schockformen?	Hypovolämisch, kardiogen, obstruktiv, distributiv.	4 şok.	08
13	Schockindex?	Herzfrequenz / systolischer RR; ≥ 1 Schock wahrscheinlich; 0,5–0,7 normal.	Şok indeksi.	08
14	Infarkt-Zeichen?	Brustschmerz/Engegefühl mit Ausstrahlung, Atemnot, kalter Schweiß, Übelkeit; Frauen atypisch.	Kalp krizi.	08
15	Schlaganfall-Zeichen?	Einseitige Gesichts-/Armlähmung, Sprachstörung, Sehstörung, Schwindel, starker Kopfschmerz.	İnme.	08
16	Lungenembolie-Zeichen?	Plötzliche Atemnot, Brustschmerz, Husten, Synkope; ggf. einseitige Beinschwellung.	LE.	08
17	ABCDE?	Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure/Environment.	ABCDE.	08
18	Ventilation/Diffusion/Perfusion?	Belüftung / Gasaustausch / Durchblutung.	Fark.	08
19	SBAR?	Situation, Background, Assessment, Recommendation.	SBAR.	08

Operatoren

#	Frage (DE)	Antwort (DE)	Türkçe/Not	Kap.
1	Was verlangt ERKLÄREN?	Ursachen/Bedingungen/Folgen verständlich machen („weil“).	Açıklamak.	10
2	Was verlangt BESCHREIBEN?	Strukturiert, ganze Sätze, Fachsprache, keine Wertung.	Betimlemek.	10
3	Was verlangt BEGRÜNDEN?	Warum etwas so ist; fachliche Argumente.	Gerekçelendirmek.	10
4	AFB I/II/III?	Reproduktion / Reorganisation und Transfer / Reflexion und Problemlösung.	AFB.	10
5	Was ist Beobachten vs. Beurteilen?	Wahrnehmen ohne Urteil vs. Schlussfolgern mit Fachwissen.	Gözlem/değerlendirme.	10

Ek 5 — Deneme sınavları (soru kitapçığı — cevapsız)

← Ana rehber · **Cevap anahtarı ayrı dosyada:** Ek5b_Antwortschluessel.md — önce kendiniz çözün! **Nasıl kullanılır:** Zamanlayın (≈ 45–60 dk/Klausur). Önce Almanca yazın, sonra anahtarla karşılaştırın; yanlışları Ek 7 tablosuna girin. **Soru türleri:** MC = çoktan seçmeli · RF = doğru/yanlış · LT = boşluk · ZO = eşleştirme · KA = kısa cevap · BG = terim açıklama · FA = vaka analizi · PP = bakım planı · SD = yazılı ifade/dokümantasyon · MD = sözlü simülasyon. Her soru için: AFB (I/II/III) ve kaynak bölüm belirtilmiştir.

Klausur 1 — Pflegeverständnis, Pflegeprozess, Operatoren, Dokumentation

(Kaynak: 01, 09, 10)

1. (MC, AFB I) Welche Information über Frau Berger (78, nach Sturz) ist eine **Ressource**? A) Schmerzen im rechten Hüftbereich B) Ihre Brille liegt zu Hause C) Ihre Tochter besucht sie regelmäßig D) Sie lebt allein

2. (MC, AFB I) Was verlangt der Operator **ERKLÄREN**? A) Begriffe stichwortartig nennen B) Ursachen/Bedingungen verständlich machen (hilfreich: „weil“) C) Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausstellen D) ein begründetes Urteil abgeben

3. (RF, AFB I) „Die Durchführung einer bereits geplanten Pflegemaßnahme gehört automatisch zu den vorbehaltenen Aufgaben nach § 4 PflBG.“ Richtig oder falsch? Begründe in einem Satz.

4. (RF, AFB I) „Die ABEDL ersetzen das persönliche Gespräch mit dem Pflegeempfänger.“ Richtig/falsch?

5. (LT, AFB I) Der Pflegeprozess besteht aus ___ Phasen. Die erste Phase heißt ___, die letzte ___. Weil Pflege angepasst werden muss, wird er als ___ verstanden.

6. (ZO, AFB I) Ordne zu: 1 Brille fehlt · 2 Schmerzen beim Aufstehen · 3 Tochter in der Nähe · 4 „Ich möchte selbst waschen“ → a) ABEDL 12 (Soziale Bereiche) b) ABEDL 11/1 (Sicherheit/Kommunikation-Sehen) c) ABEDL 2 (Sich bewegen) d) Autonomie/Selbstbestimmung

7. (KA, AFB I) Nenne vier der 13 ABEDL.

8. (BG, AFB I) Definiere „Ressource“ und gib ein Beispiel aus der Pflege.

9. (KA, AFB II) Erkläre, warum Pflege nicht bedeutet, „einem Menschen möglichst viel abzunehmen“.

10. (KA, AFB I) Nenne die drei vorbehaltenen Aufgaben nach § 4 PflBG.

11. (FA, AFB II) *Impuls: „Pflegekräfte führen nur ärztliche Anordnungen aus.“* **Begründe**, ob die Aussage stimmt.

12. (SD, AFB II) Überarbeite die folgenden Einträge (objektiv, konkret): a) „Pat. ist heute schlecht drauf.“ b) „Pat. hat Fieber.“ c) „Pat. wurde mobilisiert.“ (die Mobilisation wurde wegen Schwindels abgebrochen).

13. (PP, AFB II) Erstelle für **Frau Berger (81)** (geht langsamer, braucht mehrere Versuche beim Aufstehen, bleibt häufiger im Sessel) einen Pflegeprozess in **6 Zeilen** (Information – Problem/Ressource – Ziel – Maßnahmen – Durchführung – Evaluation).

14. (FA, AFB III) Stelle Stellung zur Aussage: „Bei Zeitdruck ist es besser, die Körperpflege komplett zu übernehmen.“ Begründe mit Autonomie und Ressourcen.

15. (MD, AFB II) *Mündliche Simulation (3 min):* Stelle dich Frau Berger vor, frage nach ihren Wünschen bei der Mobilisation und erkläre, was du tun wirst. (Bewertung: Konj. II, Ankündigung, Frage nach Selbstständigkeit.)

Klausur 2 — Kommunikation, Berührung, Nähe–Distanz

(Kaynak: 02, 02b)

1. (MC, AFB I) Wie viele Elemente gehören nach Laswell immer zur Kommunikation? A) 2 B) 3 (Nachricht, Sender, Empfänger) C) 4 D) 5

2. (MC, AFB I) Welcher Satz entspricht dem **Appell**? A) „Es ist 12 Uhr.“ B) „Ich habe Angst.“ C) „Bitte seien Sie vorsichtig mit mir.“ D) „Sie sind noch jung.“

3. (RF, AFB I) „Wer schweigt, kommuniziert nicht.“ Richtig/falsch? (Axiom)

4. (LT, AFB I) Digitale Kommunikation transportiert die ___, analoge (Gestik, Mimik, Tonfall) die ___ebene.

5. (ZO, AFB I) Ordne zu: 1 symmetrisch · 2 komplementär · 3 kongruent · 4 inkongruent → a) hierarchisch b) verbal = nonverbal c) gleichrangig d) verbal ≠ nonverbal

6. (KA, AFB I) Nenne drei Feedbackregeln.

7. (BG, AFB I) Definiere „infantilisierende Sprache“ und gib ein Beispiel + bessere Formulierung.

8. (KA, AFB II) Erkläre mit dem Vier-Ohren-Modell, wie die Frage „Wie alt sind Sie überhaupt?“ gemeint/gehört werden kann.

9. (FA, AFB II) *Fall Simon/Renate:* Die Pflegerin misst Blutdruck und BZ, ohne ein Wort zu sprechen. **Beschreibe** die Situation, **beurteile** (gut/schlecht) und **ziehe eine Konsequenz**.

10. (KA, AFB II) Erkläre, warum die Begrüßung für die Pflegebeziehung wichtig ist.

11. (KA, AFB I) Nenne vier Formen nonverbaler Kommunikation.

12. (KA, AFB II) Erkläre die Begriffe Initialberührung und achtsame Körperpflege.

13. (FA, AFB III) Diskutiere, wie Pflegende Nähe und Distanz ausbalancieren können (mindestens zwei Argumente je Seite).

14. (SD, AFB II) Formuliere eine **Ich-Botschaft** an eine Kollegin, die Medikamente schon gegeben hat, ohne dich zu informieren.

15. (MD, AFB II) *Mündlich:* Ein Patient redet minutenlang weiter, obwohl du gehen musst. Beende das Gespräch höflich.

Klausur 3 — Erste Hilfe / BLS / Notfälle

(Kaynak: 08 · ⚠ Rakamlar öğretmeninizin/kursun güncel standardına göre kontrol edilmelidir)

1. (MC, AFB I) Eine Patientin reagiert nicht und atmet nicht normal. Was tust du **zuerst nach Eigensicherung/Ansprechen**? A) Puls 2 Minuten tasten B) Hilfe/Notruf und mit Herzdruckmassage beginnen C) Stabile Seitenlage D) Sauerstoff messen

2. (MC, AFB I) Wie lange soll die Atemkontrolle höchstens dauern? A) 3 s B) 10 s C) 30 s D) 1 min

3. (MC, AFB I) Welche Zahlen gelten für die Herzdruckmassage beim Erwachsenen (Zusammenfassung)? A) 15:2, 60/min B) 30:2, 100–120/min, 5–6 cm C) 30:2, 60/min, 2 cm D) 5:1, 80/min

4. (RF, AFB I) „Ein AED ersetzt die Herzdruckmassage.“ Richtig/falsch?

5. (RF, AFB I) „Bei bewusstloser Person mit normaler Atmung wird die stabile Seitenlage angewendet.“

6. (LT, AFB I) Die W-Fragen beim Notruf: ___ ist das Ereignis? ___ ruft an? ___ ist geschehen? ___ Betroffene? Danach auf ___ der Leitstelle warten.

7. (ZO, AFB I) Ordne zu: 1 hypovolämisch · 2 kardiogen · 3 obstruktiv · 4 distributiv → a) Lungenembolie b) Blutverlust c) Sepsis/Anaphylaxie d) Herzinfarkt

8. (BG, AFB I) Erkläre Ventilation, Diffusion, Perfusion.

9. (KA, AFB I) Nenne die Schritte der AED-Anwendung.

10. (KA, AFB II) Erkläre, warum Thoraxkompressionen möglichst wenig unterbrochen werden sollen und warum alle 2 Minuten gewechselt wird.

11. (KA, AFB II) Beschreibe § 323c StGB, Garantenstellung und rechtfertigenden Notstand (§ 34) in je 1–2 Sätzen.

12. (KA, AFB II) Ermittle aus den Symptomen die Verdachtsdiagnose: a) einseitig hängender Mundwinkel, Sprachstörung b) plötzliche Atemnot + einseitige Beinschwellung c) Brustschmerz, kalter Schweiß, Ausstrahlung in den Arm.

13. (SD, AFB II) Berechne den Schockindex: Puls 120/min, RR 80/50 mmHg. **Beurteile** das Ergebnis.

14. (FA, AFB II) *Fall:* Du betrittst ein Patientenzimmer, ein Patient liegt neben dem Bett am Boden und reagiert nicht. **Beschreibe** dein Vorgehen für (A) normale Atmung, (B) keine normale Atmung.

15. (FA, AFB III) Begründe, warum Auszubildende bei Notfällen im eigenen Kompetenzbereich handeln und die zuständige Pflegefachkraft einbeziehen sollen.

16. (MD, AFB II) *Mündlich:* Gib eine strukturierte **SBAR-Übergabe** an das eintreffende Reanimationsteam (Fall frei gewählt).

Klausur 4 — Mobilität, Sturz, Thrombose/Pneumonie, Pflegeprozess

(Kaynak: 06, 07, 09)

1. (MC, AFB I) Die Virchow-Trias besteht aus: A) Schmerz, Rötung, Wärme B) verlangsamter Blutfluss, Gefäßwandschäden, erhöhte Gerinnungsneigung C) Luft, Wasser, Boden D) Ventilation, Diffusion, Perfusion

2. (MC, AFB I) Welche Maßnahme gehört **nicht** zur Thromboseprophylaxe? A) Frühmobilisation B) Trinken C) Beine kräftig ausstreichen D) Bewegungsübungen

3. (MC, AFB I) MTPS wirken: A) bei Gehenden optimal B) nur bei liegenden Patienten C) nie D) nur nachts

4. (RF, AFB I) „Die Pneumonie nach Aspiration ist primär infektiös."

5. (RF, AFB I) „Veränderungen der Beweglichkeit im Alter sind immer normal und müssen nicht abgeklärt werden."

6. (LT, AFB I) LISA steht für **L___ I___ S___ A___**.

7. (ZO, AFB I) Ordne zu: 1 Mobilität · 2 eingeschränkte Mobilität · 3 Immobilität → a) stark eingeschränkt/fehlend b) selbstständig möglich c) möglich, aber vermindert

8. (KA, AFB I) Nenne fünf Sturzursachen.

9. (KA, AFB I) Nenne fünf Beobachtungskriterien für die Mobilität von Frau Berger.

10. (KA, AFB II) Erkläre, wie Immobilität zu Thrombose, Pneumonie und Dekubitus führen kann.

11. (KA, AFB I) Nenne vier Kontraindikationen für MTPS/Kompressionsverbände.

12. (BG, AFB II) Vergleiche typische und atypische Pneumonie (3 Kriterien).

13. (FA, AFB II) *Sturz im Zimmer:* **Beschreibe** das Vorgehen nach dem Sturz und die Inhalte des Sturzprotokolls.

14. (PP, AFB II) Erstelle einen Pflegeplan (6 Phasen, kurz) für Herrn Schneider: Schmerzen nach Sturz, kaum getrunken, lehnt Waschen ab.

15. (FA, AFB III) Begründe, warum Information/Beratung zur Prophylaxe dokumentiert werden müssen.

16. (SD, AFB II) Formuliere einen objektiven Dokumentationseintrag (3–4 Sätze) zu einem Sturz (fiktive Daten).

Klausur 5 — Hygiene, Haut, Körpertemperatur

(Kaynak: 03, 04, 05)

1. (MC, AFB I) Der Hauptübertragungsweg von Erregern sind: A) Luft B) Hände C) Wasser D) Insekten

2. (MC, AFB I) Mindest-Einwirkzeit bei hygienischer Händedesinfektion (BGW): A) 5 s B) 15 s C) 30 s D) 3 min

3. (MC, AFB I) Welche Hautschicht enthält **keine** Blutgefäße? A) Epidermis B) Dermis C) Subkutis D) alle

4. (MC, AFB II) Ein Patient im **Fieberanstieg** zittert und friert. Was ist richtig? A) kalte Wadenwickel B) zudecken/wärmen C) Fenster öffnen D) kalte Dusche

5. (RF, AFB I) „Handschuhe ersetzen die Händedesinfektion."

6. (RF, AFB I) „Axillar gemessene Temperatur entspricht der Kerntemperatur."

7. (LT, AFB I) Die 5 Entzündungszeichen: Rubor, ___, Calor, ___, Functio laesa.

8. (ZO, AFB I) Ordne zu: 1 Reinigung · 2 Desinfektion · 3 Sterilisation → a) alle Keime vernichtet b) die meisten Erreger abgetötet c) entfernt Schmutz und bis zu 80 % Keime

9. (KA, AFB I) Nenne die 5 Momente der Händedesinfektion.

10. (KA, AFB II) Erkläre, warum bei Clostridioides difficile zusätzlich zur Desinfektion gewaschen wird.

11. (KA, AFB I) Nenne Normwerte/Befunde: Turgor normal vs. vermindert; Recap-Zeit.

12. (KA, AFB II) Erkläre, weshalb eine Zyanose bei dunkler Hautfarbe übersehen werden kann und wo man zusätzlich schaut.

13. (BG, AFB II) Vergleiche Fieber und Hyperthermie.

14. (KA, AFB II) Beschreibe die Durchführung eines Wadenwickels und nenne Kontraindikationen.

15. (FA, AFB II) *Fall Herr Schneider:* T 38,6 °C axillar, Haut heiß, schwitzt, kaum getrunken. **Ermittle** drei Pflegeprobleme und nenne, wann du den Arzt informierst.

16. (FA, AFB III) Beurteile, ob bei Fieber immer fiebersenkende Maßnahmen durchgeführt werden sollen (Argumente aus dem Text).

17. (FA, AFB II) Nach einer Nadelstichverletzung: **Beschreibe** die ersten Schritte.

18. (MD, AFB II) *Mündlich:* Erkläre einer Patientin vor der Temperaturmessung im Ohr, was du tust.

Ek 5b — Cevap anahtarı ve ayrıntılı açıklamalar

← Sorular · Ana rehber **Not:** Serbest cevaplarda (KA/FA/PP/SD/MD) tek doğru formül yoktur; **örnek cevap** + **puan kriterleri** verilmiştir. Kaynak = rehber bölümü (ve gerekirse PDF). ⚠ = rakamlar kursta doğrulanmalı.

Klausur 1

1. C — Ressource = Fähigkeit/Unterstützung; Tochter = soziale Ressource (Lernskript S. 2). A = Problem/Beobachtung; B = Unterstützungsbedarf (Sehen); D = Risiko/Information. *Cevap kalıbı:* „Eine Ressource ist …, zum Beispiel …“

2. B — Übungsheft: ERKLÄREN = Ursachen, Bedingungen/Folgen verständlich machen, „weil“. A = Nennen; C = Vergleichen; D = Stellung beziehen. 10

3. Falsch — Lernskript S. 5: Durchführung einer geplanten Maßnahme ist nicht automatisch vorbehalten; vorbehalten sind Bedarfserhebung/Planung, Steuerung, Qualitätssicherung. *Kalıp:* „Dies ist falsch, da nur die Planung, Steuerung und Qualitätssicherung vorbehalten sind.“

4. Falsch — ABEDL sind Strukturhilfe, ersetzen das Gespräch nicht (Lernskript S. 3).

5. *6 Phasen; Informationssammlung; Evaluation (Wirkung beurteilen); Kreislauf.*

6. 1→b · 2→c · 3→a · 4→d. (Mehrfachzuordnung ABEDL möglich: „Brille fehlt“ auch ABEDL 11; „Schmerzen“ auch 3.)

7. z. B. Kommunizieren können; Sich bewegen können; Essen und trinken können; Ausscheiden können. (Jede 4 richtige = volle Punkte.)

8. *Ressource ist eine Fähigkeit, Stärke, Möglichkeit oder Unterstützung, die ein Mensch besitzt und nutzen kann. Beispiel: Frau Berger kann selbst essen und trinken.* (Definition 1 P + Beispiel 1 P)

9. *Pflege bedeutet nicht, möglichst viel abzunehmen,* ***weil*** *professionelle Pflege Gesundheit, Wohlbefinden und Selbstständigkeit erhalten und fördern soll. Nimmt man alles ab, gehen Fähigkeiten verloren (Muskelabbau, Abhängigkeit) und die Selbstbestimmung wird verletzt. Pflege nutzt daher Ressourcen.* (Lernskript S. 1) Kriterien: Ursache-Wirkung mit „weil“, Autonomie/Ressourcen.

10. (1) individuellen Pflegebedarf erheben/feststellen und Pflege planen; (2) Pflegeprozess organisieren, gestalten, steuern; (3) Qualität der Pflege analysieren, evaluieren, sichern, weiterentwickeln. (§ 4 PflBG, Lernskript S. 5; ⚠ Wortlaut prüfen)

11. *Die Aussage stimmt nicht. Pflegefachpersonen tragen die Verantwortung für den Pflegeprozess (§ 4 PflBG): Sie erheben den Bedarf, planen, steuern und evaluieren. Ärztliche Anordnungen führen sie zusätzlich in Zusammenarbeit durch (interprofessionell), sind aber nicht nur Ausführende.* Kriterien: § 4, Eigenverantwortung, Zusammenarbeit.

12. a) „Pat. wirkt traurig, spricht kaum und hat nur zwei Bissen vom Frühstück gegessen.“ b) „Körpertemperatur 38,6 °C axillar um 12:30 Uhr; Haut heiß und gerötet; Pat. schwitzt; Arzt informiert.“ c) „Mobilisation wegen Schwindels abgebrochen; Pat. sitzt an der Bettkante; Blutdruck … gemessen; PFK informiert.“ Kriterien: Messwert, Zeit, kein Urteil, **nichts Nicht-Geschehenes**. 10 §3

13. Muster: 1) **Information:** 81 J., geht langsamer, mehrere Aufstehversuche, hält sich an Möbeln fest, bleibt im Sessel, verlässt Zimmer seltener. 2) **Problem/Ressource:** eingeschränkte Mobilität mit Sturz-/Immobilitätsrisiko; ging früher selbstständig mit Rollator, kann mitwirken. 3) **Ziel:** Frau Berger steht innerhalb einer Woche mit Rollator sicher auf und geht ein-/zweimal täglich zum Speiseraum. 4) **Maßnahmen:** Ursachen abklären (Schmerz, Medikamente, Sehen), Beobachtung Gangbild/Gleichgewicht, Bewegungsangebote, Sturzrisiko erfassen, Umgebung sichern, Rollator/Schuhe prüfen, Gespräch über Zimmerverlassen, Information/Anleitung. 5) **Durchführung:** gemeinsam, Zeitpunkte dokumentieren. 6) **Evaluation:** Ziel erreicht? Zahl der Versuche, Sicherheit, Sturzereignisse;

Plan anpassen. *Zusatz:* „Bei Verschlechterung muss die zuständige PFK/der Arzt informiert werden.“ (Erwartungshorizont S. 2–3; Lernskript S. 4)

14. Muster: *Meiner Einschätzung nach ist es nicht besser, die Körperpflege komplett zu übernehmen, weil Pflege Ressourcen und Autonomie erhalten soll. Wenn die Pflegekraft alles übernimmt, verlernt die Person Fähigkeiten und fühlt sich bevormundet; zudem kann sie ihre Wünsche nicht einbringen. Andererseits spart es Zeit und kann bei akuter Erschöpfung/Schmerz sinnvoll sein. Ein Kompromiss: Teilübernahme, die Person wäscht, was sie kann (z. B. Gesicht), und es wird an die Situation angepasst. Daher: Selbstständigkeit fördern, Zeit planen.* AFB III: Pro/Contra + Urteil.

15. *Muster:* „Guten Morgen, Frau Berger, mein Name ist …, ich bin Auszubildende und heute für Sie da. Darf ich hereinkommen? Ich möchte Sie gleich beim Aufstehen unterstützen. Möchten Sie das lieber ganz selbst versuchen, und ich stehe daneben, oder soll ich Ihnen helfen? Ich erkläre Ihnen jeden Schritt vorher.“ Kriterien: Vorstellung, Konj. II, Ankündigung, Wahlmöglichkeit.

Klausur 2

1. B — Nachricht, Sender, Empfänger (Einstieg S. 7). A/C/D falsch.

2. C — Appell = „Ich möchte, dass du das tust“ (S. 10). A Sachinhalt, B Selbstoffenbarung, D Beziehungshinweis.

3. Falsch — Man kann nicht nicht kommunizieren; Schweigen sendet eine Botschaft (Sequenz 3 S. 11).

4. *Sachinformation (Inhaltsebene); Beziehungsebene.* (S. 13)

5. 1→c · 2→a · 3→b · 4→d.

6. Respekt; Verhalten kritisieren, nicht Person; Ich-Botschaften; konkrete Situation (kein „immer/nie“); Wünsche formulieren. (S. 14)

7. *Infantilisierende Sprache ist kindliche/abwertende Sprache gegenüber Erwachsenen.* Beispiel „Und jetzt noch den Popo!“ → „Ich wasche jetzt Ihren Intimbereich. Möchten Sie das selbst übernehmen?“ (Sequenz 3 S. 17; Fallbeispiel S. 1)

8. Sach: Alter; Selbstoffenbarung: Unsicherheit/Schmerz/Angst; Beziehung: Zweifel an Kompetenz; Appell: „Seien Sie vorsichtig/sagen Sie mir, wer Sie sind“. Nur ein Ohr hört die Sachinformation (Sequenz 4 S. 4–5). Kriterien: 4 Ohren + Bezug zum Fall.

9. *Beschreibung:* PFK betritt Zimmer, grüßt knapp, legt Blutdruckmanschette an, entnimmt Blut aus dem Finger, kontrolliert Füße, spricht nicht; Bewohnerin sieht fern, reagiert nicht. *Beurteilung:* gut: zielgerichtet, Routine/Bewohnerin selbstständig; schlecht: keine Vorstellung/Erklärung/Einwilligung, keine Beziehung, Bewohnerin wird übergangen, Schweigen nicht hinterfragt. *Konsequenz:* anklopfen, vorstellen, erklären, fragen, Fernseher leiser, Blickkontakt, mögliche Ursachen abklären (Hören, Depression, Sprache), Beobachtung weitergeben. (Fallbeispiel S. 1; Sequenz 2)

10. Begrüßung entscheidet über Vertrauen/Misstrauen der Pflegebeziehung; Pflegende gestalten die Beziehung (Mantz 2014, Sequenz 2 S. 4).

11. Mimik, Gestik, Blickkontakt, Körperhaltung, äußeres Erscheinungsbild, räumlicher Abstand, Körperkontakt (je 4).

12. Initialberührung: bewusster Beginn der Pflegehandlung durch Berührung (z. B. Hand auf Schulter), gibt Orientierung/Sicherheit. Achtsame Körperpflege: Art der Berührung (sanft/fest, flächig statt Pinzettengriff) an Situation/Bedarf anpassen. (AI 04 S. 8)

13. Muster: *Pro Nähe:* Vertrauen, Sicherheit, Wohlbefinden, Voraussetzung helfender Beziehung. *Pro Distanz:* Selbstschutz, professionelle Beurteilung, psychisches Gleichgewicht. *Contra zu viel Nähe:* Überforderung, Grenzverletzung; *zu viel Distanz:* Kälte, Misstrauen. *Fazit:* Balance durch Empathie, Beachtung nonverbaler Zeichen, Gesprächsangebote ohne Zwang, Selbstreflexion/Unterstützung (AI 04 S. 9, AI 05 S. 3).

14. „Ich habe mich gewundert/mir Sorgen gemacht, als ich gesehen habe, dass die Medikamente schon gegeben wurden, weil ich nicht wusste, ob es abgesprochen war. Ich wünsche mir, dass wir uns kurz absprechen.“ (Ich-Botschaft + konkret + Wunsch)

15. „Ich merke, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Leider muss ich jetzt zu einem anderen Patienten. Darf ich heute Nachmittag wiederkommen? Wir sprechen dann in Ruhe weiter.“ (Sequenz 2 S. 9)

Klausur 3

1. B — Keine Reaktion + keine normale Atmung → Hilfe/Notruf + CPR (ZF S. 12–13). A falsch (Puls nicht obligat, ≤ 10 s). C nur bei normaler Atmung. D keine Priorität.

2. B — höchstens 10 s (ZF S. 12; F 116).

3. B — 30:2, 100–120/min, 5–6 cm (ZF S. 13; ⚠ Folien 137/140: 100 bzw. 80–100/min).

4. Falsch — „AED ersetzt die HDM nicht“ (ZF S. 15).

5. Richtig (ZF S. 12).

6. Wo; Wer; Was; Wie viele; Rückfragen (ZF S. 9–10).

7. 1→b · 2→d · 3→a · 4→c (ZF S. 17; F 204).

8. Ventilation = Belüftung; Diffusion = Gasaustausch Alveole↔Blut; Perfusion = Durchblutung der Alveolen (ZF S. 6).

9. Einschalten → Elektroden aufkleben → Anweisungen befolgen → bei Analyse nicht berühren → Schock empfohlen: Abstand, Schock auslösen → sofort CPR; kein Schock → CPR (ZF S. 14–15).

10. Fluss nur aufrechtzuerhalten, wenn Pausen kurz sind (RR ca. 80 mmHg, F 128); Ermüdung: Qualität sinkt innerhalb 5 min von > 90 % auf 18 % (F 138) → Wechsel alle 2 Min (F 139).

11. § 323c: Pflicht zu helfen, wenn erforderlich und zumutbar, keine erhebliche eigene Gefahr; sonst Strafe. Garantenstellung: besondere Einstandspflicht für anvertraute Pat. (§ 13 StGB). § 34: rechtfertigender Notstand – bei gegenwärtiger Gefahr darf man Rechtsgüter beeinträchtigen, wenn mildestes Mittel und das geschützte Interesse wesentlich überwiegt. ⚠ keine Rechtsberatung.

12. a) Schlaganfall b) Lungenembolie (mit TVT) c) Herzinfarkt.

13. SI = 120/80 = **1,5** → schwerer Schock mit akuter Lebensgefahr wahrscheinlich (≥ 1 = Schock wahrscheinlich; Normal 0,5–0,7); nur Orientierung → Notruf, Vitalzeichen, Blutung stillen (F 200–202).

14. *A (normal):* Umgebung sichern, ansprechen/anfassen, Hilfe rufen, Atemweg öffnen, stabile Seitenlage soweit möglich, Notruf/Pflegeteam, Atmung kontrollieren, Vitalzeichen/Sturzfolgen beachten, nicht allein lassen. *B (nicht normal):* Kreislaufstillstand annehmen, Notruf/Reanimationsteam, CPR 30:2 (100–120/min, 5–6 cm), AED holen/anlegen, bis Team übernimmt, SBAR-Übergabe. (ZF S. 24–25)

15. Muster: *weil Kompetenzgrenzen, Hausstandard und Patientensicherheit entscheidend sind; PFK trägt Verantwortung, Teamarbeit senkt Fehler; Auszubildende erwerben Kompetenz schrittweise.* (F 167)

16. SBAR: „**S:** Frau X, 78, wurde um 10:05 Uhr bewusstlos am Boden gefunden, atmet nicht normal; CPR seit 10:06. **B:** Z. n. Hüft-OP, bekannte Herzinsuffizienz. **A:** Kreislaufstillstand, AED hat 1 Schock abgegeben. **R:** Bitte Übernahme, Atemwegssicherung, Zugang.“ (fiktiv)

Klausur 4

1. B — Virchow-Trias (IC S. 1). A=Entzündungszeichen, C=Hygiene-Bereiche, D=Lunge.

2. C — Beine nicht ausstreichen (IC S. 4).

3. B — MTPS nur im Liegen (IC S. 5). Mobile → MKS.

4. Falsch — Aspirationspneumonie = Sonderform, nicht infektiös (P S. 16).

5. Falsch — nicht pauschal als normal abtun, abklären (EH S. 2).

6. Lungenbelüftung verbessern; Infektionen vermeiden; Sekret verflüssigen/mobilisieren/entleeren; Aspiration vermeiden.

7. 1→b · 2→c · 3→a.

8. Gleichgewichtsstörungen; Muskelschwäche; Seh-/Augenerkrankung; Schwindel; Angst; ungeeignete Schuhe/Kleidung; Medikamente; Inkontinenz; eingeschränkte Bewegungsfreiheit (F 6).

9. Gangbild/-geschwindigkeit; Gleichgewicht; Aufstehen/Hinsetzen; Transfer; Hilfsmittel; Schmerzen; Sturzereignisse/Angst; Unterstützungsbedarf; Sehen/Hören (EH S. 3).

10. *Immobilität → langsamer Blutfluss/Muskel-Venen-Pumpe aktiv ↓ → Thrombose; flache Atmung/Sekretstau → Pneumonie; Druck auf Haut ohne Entlastung → Dekubitus. Weitere Folgen: Muskelabbau, Kontraktur.* Kriterien: je ein Mechanismus.

11. pAVK/kritische arterielle Durchblutungsstörung; schwere Neuropathie; ausgeprägte periphere Ödeme; lokale Defekte/Nekrosen/Verletzungen (IC S. 6).

12. Beginn: plötzlich vs. schleichend; Fieber: hoch/Schüttelfrost vs. leicht; Husten: produktiv gelblich-braun vs. trocken; (Atemnot früh vs. langsam; Allgemeinbefinden stark vs. mäßig) (P S. 8).

13. Beruhigen, 2. Pflegeperson rufen; Verletzungen beachten; Fraktur ausschließen, dann vorsichtig aufhelfen (Vierfüßlerstand); Puls/RR nach Beruhigung; Sturzprotokoll; PFK/Arzt/Angehörige informieren; Gehirnerschütterungs- und 24-h-Hirndruckzeichen beobachten; ggf. Notarzt. Protokoll: Person, Datum/Uhrzeit/Ort, Umgebung, Befinden, Aktivität davor, Maßnahmen, Folgen (F 13–14).

14. Muster: *Info:* 78 J., Sturz, Schmerz re. Hüfte, steht schwer auf, kaum getrunken, schwitzt, lehnt Waschen ab. *Problem/Ressource:* Schmerz/Mobilitätsdefizit, Flüssigkeitsdefizit, Selbstversorgungsdefizit mit Scham; Ressource: äußert Bedürfnisse, möchte selbstständig sein. *Ziel:* schmerzarm mobilisiert, Trinkmenge gesichert, Pflege unter Wahrung der Intimsphäre. *Maßnahmen:* Schmerz erfassen/melden, Trinkangebot, Mobilisation mit Begleitung, Körperpflege mit Wahlmöglichkeit, Sturz-/Thrombose-/Pneumonie-Prophylaxe nach Risiko. *Durchführung:* gemeinsam, dokumentiert. *Evaluation:* Schmerz, Trinkmenge, Zufriedenheit, Sicherheit; anpassen. Verschlechterung → PFK/Arzt.

15. Weil Prophylaxe im Pflegeprozess geplant, durchgeführt und evaluiert werden muss und Informations-/Beratungs-/Anleitungsgespräche **nachweislich** erfolgen sollen (EH S. 4) → Nachvollziehbarkeit, Qualität, Verantwortung.

16. „14:05 Uhr: Pat. sitzt im Bad auf dem Boden, gibt Schmerzen am rechten Handgelenk an. Keine sichtbare Kopfverletzung. Puls 88/min, RR 130/80 mmHg nach Beruhigung. PFK und Arzt informiert, Sturzprotokoll ausgefüllt, Tochter benachrichtigt.“ (fiktiv)

Klausur 5

1. B (T1 S. 9; BGW S. 7). **2. C** (BGW S. 8). **3. A** — Epidermis ist gefäßlos (T2 S. 2); B/C enthalten Gefäße. **4. B** — Im Fieberanstieg wärmen, kühlende Maßnahmen kontraindiziert (Thieme S. 28, 30). A/C/D lösen Schüttelfrost/Kältereiz aus. **5. Falsch** (H S. 9). **6. Falsch** — nur Schalentemperatur (Thieme S. 7–8). **7.** Tumor, Dolor. **8.** 1→c · 2→b · 3→a (T1 S. 11). **9.** vor Patientenkontakt; vor aseptischen Tätigkeiten; nach Kontakt mit infektiösem Material; nach Patientenkontakt; nach Kontakt mit Patientenumgebung (T1 S. 17). **10.** C. difficile bildet Sporen; übliche HD-Mittel wirken nicht → Hände zusätzlich gründlich waschen, um Keime mechanisch zu entfernen; + Schutzkleidung (H S. 8). **11.** Normal: Haut gleitet sofort zurück; vermindert: stehende Hautfalte einige Sekunden → Exsikkose; Recap < 2–3 s (T2 S. 6–7). **12.** Melanin überlagert die Blauverfärbung; zeigt sich grau/maronenfarben; zusätzlich Zunge, Zahnfleisch, Mundschleimhaut, Bindehaut, Nagelbett prüfen (T2 S. 7). **13.** Fieber: Sollwerterhöhung im Hypothalamus durch Pyrogene; Hyperthermie: Regulation überfordert (Wärmebildung/-zufuhr ≫ Abgabe), Sollwert unverändert; Therapie unterschiedlich (Fieber: Stadien beachten; Hyperthermie: Kühlung/Flüssigkeit) (Thieme S. 17–21). **14.** Nässeschutz; 2 Tücher in lauwarmes Wasser (max. 10 °C kälter), auswringen,

locker faltenfrei um die Waden; nach 5–10 min wechseln; 2–3×; KI: kalte Füße/Hände, Durchblutungsstörungen; nicht im Fieberanstieg; ärztliche Entscheidung/Anordnung beachten (S. 30). **15.** Probleme: Fieber/Flüssigkeitsdefizit; Schwitzen/Kreislauf/Sturzrisiko; Körperpflege/Haut. Arzt informieren bei: Verschlechterung, Fieberdelir, schwerem Schüttelfrost, Krampf, Kreislaufzeichen (S. 34–36). **16.** *Nein, nicht immer:* Fieber unterstützt das Immunsystem (Antikörper ↑, Erreger gehemmt) (S. 29); senken bei speziellen Situationen/Befinden; langsam senken; Arzt entscheidet; Risiken von Antipyretika (Reye, Agranulozytose …) (S. 29–32). **17.** Blutfluss fördern, intensiv spülen/desinfizieren, sofort Arzt/Durchgangsarzt, Risiko HBV/HCV/HIV klären, HIV-PEP ≤ 2 h, Meldung BGW/Unfallkasse, Nachsorge, dokumentieren (BGW S. 20). **18.** „Frau X, ich möchte jetzt Ihre Temperatur im Ohr messen. Das dauert nur wenige Sekunden. Ich ziehe Ihr Ohr leicht nach oben, damit ich den Gehörgang gut erreiche. Ist das in Ordnung?“ (Thieme S. 11; Konj./Ankündigung)

Puanlama önerisi

MC/RF/LT/ZO: 1 puan; KA/BG: 2–3 puan (içerik + Almanca doğruluk); FA/PP/SD: 4–6 puan (yapı, bağlam, terminoloji, gerekçe, güvenlik). **Ayrı puan:** Almanca hata türü (Artikel/Fall, Verbstellung, Fachwort).

Ek 5c — Operatör formatında vaka sınavları (Übungsheft tarzı) — soru kitapçığı

> ← Ana rehber · Cevaplar: Ek5d_Operatoren_Loesungen.md (önce kendiniz yazın!) **Format = Übungsheft S. 3–4:** Fallbeispiel → *Aufgabe n – OPERATOR | AFB*. Operatör ne istiyorsa **onu** yazın (10 tablosu). Almanca, **ganze Sätze** (NENNEN hariç), Fachsprache, **BESCHREIBEN'de değerlendirme yok**, ERKLÄREN'de **„weil“**. Vakalar **kurgusaldır**. Süre: vaka başına ≈ 20 dk. Kaynak bölümler her vakanın başında.

Fallbeispiel A: Frau Keller *(Kaynak: 04, 06, 07)*

Situation: Frau Keller ist 82 Jahre alt und wird nach einer Hüftoperation auf die chirurgische Station verlegt. Sie liegt seit drei Tagen überwiegend im Bett und äußert bei Bewegung Schmerzen. Sie trinkt wenig und sagt: „Ich habe keinen Durst.“ Die Pflegefachkraft bemerkt am Kreuzbein eine Rötung, die auf Fingerdruck nicht verschwindet. Frau Keller atmet flach und hustet gelegentlich trocken. Ihre Tochter fragt, warum die Mutter „nicht einfach liegen bleiben darf“. **Arbeitsauftrag:** Bearbeite die folgenden Aufgaben und achte jeweils auf den Anforderungsbereich.

Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I — Nennen Sie drei Beobachtungen, die die Pflegefachkraft bei Frau Keller wahrnimmt. **Aufgabe 2 – BESCHREIBEN | AFB I** — Beschreiben Sie den Hautbefund am Kreuzbein. Verwenden Sie Fachsprache und bewerten Sie nicht. **Aufgabe 3 – DEFINIEREN | AFB I** — Definieren Sie den Begriff „Prophylaxe“. **Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II** — Ermitteln Sie drei Risiken, die sich aus der Immobilität von Frau Keller ergeben. **Aufgabe 5 – ERKLÄREN | AFB II** — Erklären Sie, warum eine Frühmobilisation bei Frau Keller sowohl Thrombose als auch Pneumonie vorbeugen kann. **Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III** — Begründen Sie, warum die Pflegefachkraft die Tochter anleiten und beraten und dies dokumentieren sollte. **Aufgabe 7 – ENTWICKELN | AFB III** — Entwickeln Sie zwei Pflegemaßnahmen, die Frau Kellers Selbstständigkeit fördern, und begründen Sie sie.

Fallbeispiel B: Herr Hoffmann *(Kaynak: 05, 03)*

Situation: Herr Hoffmann, 74 Jahre, wird mit einer Infektion stationär behandelt. Morgens friert er, zittert stark und hat blasse, kühle Haut; die Temperatur beträgt axillar 37,9 °C. Zwei Stunden später ist seine Haut heiß, trocken und gerötet, die Temperatur liegt bei 39,2 °C (axillar). Er klagt über Durst, Kopfschmerzen und ist müde. Er bittet: „Bitte legen Sie mir kalte Wickel an, mir ist so heiß.“ **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Nennen Sie vier Beobachtungen in der Fallsituation. **Aufgabe 2 – ZUORDNEN | AFB I** — Ordnen Sie die beiden Zeitpunkte (morgens / zwei Stunden später) den Fieberstadien zu. **Aufgabe 3 – BESCHREIBEN | AFB I** — Beschreiben Sie den Zustand von Herrn Hoffmann um den zweiten Zeitpunkt. **Aufgabe 4 – VERGLEICHEN | AFB II** — Vergleichen Sie Fieber und Hyperthermie. **Aufgabe 5 – ANWENDEN | AFB II** — Wenden Sie Ihr Wissen an: Welche Pflegemaßnahmen kommen morgens, welche zum zweiten Zeitpunkt in Betracht? (Hinweis auf ärztliche Anordnung.) **Aufgabe 6 – STELLUNG BEZIEHEN | AFB III** — Nehmen Sie Stellung zur Bitte von Herrn Hoffmann nach kalten Wickeln. **Aufgabe 7 – DEUTEN | AFB III** — Deuten Sie, warum ein ausgeprägter Schweißausbruch mit kalter, klebriger Haut nach starkem Fieberabfall für die Pflegekraft ein Warnzeichen sein kann.

Fallbeispiel C: Auszubildende Lena und Herr Roth *(Kaynak: 03)*

Situation: Lena (1. Ausbildungsjahr) versorgt Herrn Roth, der wegen Clostridioides difficile isoliert ist. Sie trägt Schutzkittel und Handschuhe, entfernt nach dem Toilettenstuhl die Handschuhe, desinfiziert ihre Hände und verlässt das Zimmer. Eine erfahrene Kollegin sagt: „Du hast etwas vergessen.“ Später stößt sich Lena beim Entsorgen einer gebrauchten Kanüle in den Finger. **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Nennen Sie die fünf Momente der Händedesinfektion. **Aufgabe 2 – BESCHREIBEN | AFB I** — Beschreiben Sie das Vorgehen beim Ausziehen von Handschuhen. **Aufgabe 3 – ERMITTELN | AFB II** — Ermitteln Sie, was Lena vergessen hat. **Aufgabe 4 – ERKLÄREN | AFB II** — Erklären Sie, warum ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel bei C. difficile nicht ausreicht. **Aufgabe 5 – ZUSAMMENFASSEN**

| AFB I — Fassen Sie die Sofortmaßnahmen nach einer Nadelstichverletzung zusammen. **Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III** — Begründen Sie, warum Kanülen nicht in die Schutzkappe zurückgesteckt (Recapping) und sofort entsorgt werden sollen. **Aufgabe 7 – DISKUTIEREN | AFB III** — Diskutieren Sie, ob das Tragen von Handschuhen die Händedesinfektion ersetzen kann.

Fallbeispiel D: Frau Weber *(Kaynak: 02, 02b)*

Situation: Eine Praxisanleiterin betritt das Zimmer von Frau Weber (86), ohne anzuklopfen, misst Blutdruck und Blutzucker und sagt am Ende: „Und jetzt noch den Popo." Frau Weber blickt zur Wand und antwortet nicht. Die Praxisanleiterin sagt der Auszubildenden: „Die redet nie." Später fragt Frau Weber leise: „Wie lange bleiben Sie heute?" **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Nennen Sie vier Formen nonverbaler Kommunikation, die in der Situation vorkommen oder fehlen. **Aufgabe 2 – BESCHREIBEN | AFB I** — Beschreiben Sie den Gesprächsverlauf in der Fallsituation. **Aufgabe 3 – ERKLÄREN | AFB II** — Erklären Sie, warum die Äußerung „Und jetzt noch den Popo" problematisch ist. **Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II** — Ermitteln Sie anhand des Vier-Seiten-Modells die vier Ebenen der Frage „Wie lange bleiben Sie heute?". **Aufgabe 5 – DEUTEN | AFB III** — Deuten Sie das Schweigen von Frau Weber aus ihrer Perspektive. **Aufgabe 6 – ENTWICKELN | AFB III** — Entwickeln Sie eine Begrüßung und eine Ankündigung der Intimpflege, die Würde und Selbstbestimmung wahren. **Aufgabe 7 – ANWENDEN | AFB II** — Formulieren Sie eine Ich-Botschaft der Auszubildenden an die Praxisanleiterin.

Fallbeispiel E: Herr Lang *(Kaynak: 08, 02b)*

Situation: Sie betreten das Zimmer 12. Herr Lang (68) liegt neben dem Bett am Boden. Auf Ansprechen und Rütteln an der Schulter reagiert er nicht. Der Brustkorb bewegt sich kaum, Sie hören vereinzelte geräuschvolle Atemzüge. Ein AED steht auf dem Flur. **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Nennen Sie die ersten Schritte nach dem Betreten des Zimmers. **Aufgabe 2 – BESCHREIBEN | AFB I** — Beschreiben Sie die Durchführung der Herzdruckmassage beim Erwachsenen (Zahlen nach Ihrem Skript). **Aufgabe 3 – ERKLÄREN | AFB II** — Erklären Sie, warum die vereinzelten Atemzüge nicht als normale Atmung gewertet werden. **Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II** — Ermitteln Sie, welche Informationen Sie bei der Alarmierung/dem Notruf geben. **Aufgabe 5 – VERGLEICHEN | AFB II** — Vergleichen Sie das Vorgehen bei bewusstloser Person mit normaler Atmung und ohne normale Atmung. **Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III** — Begründen Sie, warum der AED die Herzdruckmassage nicht ersetzt. **Aufgabe 7 – STELLUNG BEZIEHEN | AFB III** — Nehmen Sie Stellung: „Auszubildende dürfen im Notfall nichts tun, weil sie keine Pflegefachkräfte sind."

Fallbeispiel F: Frau Berger – Pflegeprozess *(Kaynak: 01, 06, 09)*

Situation: Frau Berger (78) wird nach einem Sturz zu Hause aufgenommen. Sie hat Schmerzen im rechten Hüftbereich, benötigt beim Aufstehen Unterstützung, ihre Brille liegt zu Hause. Sie sagt: „Ich möchte so viel wie möglich selbst machen." Sie lebt allein, die Tochter wohnt in der Nähe. **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Nennen Sie drei Ressourcen von Frau Berger. **Aufgabe 2 – ZUORDNEN | AFB I** — Ordnen Sie drei Informationen aus dem Fall passenden ABEDL zu. **Aufgabe 3 – DEFINIEREN | AFB I** — Definieren Sie „Selbstbestimmung (Autonomie)". **Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II** — Ermitteln Sie drei Pflegeprobleme/Risiken. **Aufgabe 5 – ANWENDEN | AFB II** — Wenden Sie die sechs Phasen des Pflegeprozesses vereinfacht auf Frau Berger an. **Aufgabe 6 – DISKUTIEREN | AFB III** — Diskutieren Sie, ob die Pflegefachkraft die Körperpflege komplett übernehmen oder Frau Berger beteiligen sollte. **Aufgabe 7 – ENTWICKELN | AFB III** — Entwickeln Sie ein überprüfbares Pflegeziel und begründen Sie es.

Ek 5d — Operatör vakaları: örnek cevaplar (Musterlösungen)

> ← Sorular · Ana rehber Örnekler **tek doğru değildir**; puan kriterleri: *operatöre uygunluk – bağlam – Fachsprache – gerekçe (weil) – güvenlik*. ⚠ Rakamlar kursunuzun/okulunuzun standardıyla kontrol edin. Kaynak: rehber bölümleri. **Sizin Herr-Schneider cevaplarınızın tarzı doğru yönde** (kısa NENNEN, ganze Sätze BESCHREIBEN, *weil* ile ERKLÄREN); aşağıda aynı biçim kullanıldı.

Fall A: Frau Keller

1 – NENNEN: (1) Frau Keller äußert bei Bewegung Schmerzen. (2) Sie trinkt wenig. (3) Am Kreuzbein besteht eine nicht wegdrückbare Rötung. *(auch: flache Atmung, trockener Husten)*

2 – BESCHREIBEN: *Am Kreuzbein zeigt sich eine Rötung, die auf Fingerdruck nicht verblasst (positiver Fingertest). Die Haut ist nach Angabe der Beobachtung nicht eröffnet. Größe und Hauttemperatur sollten ergänzt werden.* (Fachsprache: Lokalisation, Fingertest; keine Wertung wie „schlimm“.) [04 §5]

3 – DEFINIEREN: *Prophylaxen sind Maßnahmen bzw. Interventionen, die geeignet sind, Krankheiten und Komplikationen vorzubeugen bzw. zu vermindern. Der Begriff steht in enger Verbindung mit Prävention (Vorsorge).* (Erwartungshorizont S. 4) [06 §4]

4 – ERMITTELN: (1) **Dekubitusrisiko** (Druck + Durchblutung; Rötung bereits vorhanden). (2) **Thromboserisiko** (Hüft-OP = hohes expositionelles Risiko, Immobilisation, Alter, wenig Trinken). (3) **Pneumonierisiko** (flache Atmung, Husten, Immobilität). *Weitere:* Exsikkose, Kontraktur, Obstipation. [06 §3, 07]

5 – ERKLÄREN: *Frühmobilisation beugt einer Thrombose vor, **weil** die Muskel-Venen-Pumpe der Beine aktiviert wird und das Blut schneller zum Herzen zurückfließt; der verlangsamte Blutfluss ist ein Faktor der Virchow-Trias. Sie beugt einer Pneumonie vor, **weil** beim Aufsetzen/Gehen tiefer geatmet wird, die Lunge besser belüftet und Sekret leichter gelöst wird (LISA: Lungenbelüftung, Sekretmobilisation).* [07]

6 – BEGRÜNDEN: *Prophylaktische Maßnahmen müssen im Pflegeprozess geplant, durchgeführt und evaluiert werden, und Informations-, Beratungs- und Anleitungsgespräche sollen nachweislich erfolgen (Erwartungshorizont S. 4). Die Tochter versteht dadurch, warum Bewegung wichtig ist („Liegenbleiben“ fördert Folgeprobleme), kann unterstützen und die Umsetzung wird nachvollziehbar und überprüfbar. Dokumentation sichert Qualität und Verantwortung.*

7 – ENTWICKELN: (a) *Frau Keller erhält Unterstützung beim Aufsetzen an die Bettkante und steht mit Begleitung auf; sie bestimmt das Tempo. Begründung: erhält Kraft/Ressourcen, fördert Thrombose-/Pneumonieprophylaxe, wahrt Autonomie.* (b) *Anleitung zu Eigenübungen (Fußkreisen, Beine auf-/abstellen) mehrmals täglich nach Plan; Begründung: Muskel-Venen-Pumpe, Selbstwirksamkeit, Entlastung des Personals.* (Schmerzmanagement vorher **ärztlich** klären.) [07]

Fall B: Herr Hoffmann

1 – NENNEN: Frieren/Zittern; blasse kühle Haut; Temperatur 37,9 → 39,2 °C axillar; heiße, trockene, gerötete Haut; Durst; Kopfschmerzen; Müdigkeit.

2 – ZUORDNEN: Morgens = **Fieberanstieg** (Kältegefühl, Zittern, blasse kühle Haut). Zwei Stunden später = **Fieberhöhe** (heiß, trocken, gerötet, Durst, Kopfschmerz). [05 §5.1]

3 – BESCHREIBEN: *Herr Hoffmann hat eine axillar gemessene Temperatur von 39,2 °C. Seine Haut ist heiß, trocken und gerötet. Er klagt über Durst und Kopfschmerzen und wirkt müde.* (keine Deutung: „ihm geht es schlecht“.)

4 – VERGLEICHEN: *Gemeinsam ist beiden, dass die Körpertemperatur erhöht ist. Der Unterschied besteht darin, dass bei Fieber der Hypothalamus den Sollwert durch Pyrogene (Prostaglandin E) erhöht,*

während bei Hyperthermie die Wärmeregulation überfordert ist (Wärmeabgabe zu gering/Zufuhr zu hoch) und der Sollwert unverändert bleibt. Fieber ist ein Symptom einer Erkrankung; Hyperthermie kann z. B. bei Hitzschlag auftreten. (Fieber > 38,0 °C.) [05 §4–5]

5 – ANWENDEN: *Morgens (Anstieg): wärmen (Decken, Raumtemperatur), keine Kühlung; beruhigen; bei Schüttelfrost nicht allein lassen; Temperatur/Vitalzeichen kontrollieren. Zum zweiten Zeitpunkt (Höhe): Trinkangebot, leichte Bettdecke, kühlende Waschung oder Wadenwickel* ***nur nach Absprache/ärztlicher Anordnung*** *und wenn Wärme gewünscht wird, Haut/Befinden beobachten; Arzt informiert über Verlauf; dokumentieren (Zeit, Ort, Ergebnis, Maßnahme).* [05 §5.2]

6 – STELLUNG BEZIEHEN: *Meiner Einschätzung nach können kühlende Waschungen/Wadenwickel in der Fieberhöhe sinnvoll sein, da Herr Hoffmann subjektiv Hitze empfindet und kühlende Maßnahmen Verdunstungskälte erzeugen. Zu beachten ist, dass sie im Fieberanstieg kontraindiziert sind; zudem sind kalte Füße/Durchblutungsstörungen Kontraindikationen und Wärme-/Wassertemperatur lauwarm (max. 10 °C unter Körpertemperatur). Fieber unterstützt zudem das Immunsystem, daher soll die Absenkung langsam und nach ärztlicher Entscheidung erfolgen. Ich würde ihm deshalb lauwarme Wickel nach Rücksprache mit der PFK anbieten, nicht „kalte“.* [05 §5.2]

7 – DEUTEN: *Aus Sicht des Körpers deutet der kalte, klebrige Schweiß mit blasser Haut auf eine* ***Krisis*** *hin: Die Temperatur fällt innerhalb weniger Stunden, es gibt einen hohen Energie- und Flüssigkeitsverlust, der Kreislauf wird belastet (Puls kann wieder steigen = drohender Kollaps). Für die Pflegekraft ist das ein Notfallzeichen, weil Kreislaufversagen droht; sie informiert sofort PFK/Arzt und überwacht Vitalzeichen.* (Lysis dagegen: warmer großperliger Schweiß.) [05 §5.1]

Fall C: Lena und Herr Roth

1 – NENNEN: Vor Patientenkontakt; vor aseptischen Tätigkeiten; nach Kontakt mit infektiösem Material; nach Patientenkontakt; nach Kontakt mit der Patientenumgebung. [03 §4.1]

2 – BESCHREIBEN: *Die Handschuhe werden am Handgelenk gegriffen und abwärts gestreift, sodass die Haut die Außenseite nicht berührt. Sie werden auf links gedreht und ineinandergezogen und sofort im Abwurf entsorgt. Anschließend erfolgt eine hygienische Händedesinfektion.* [03 §5]

3 – ERMITTELN: Lena hat die Hände **nicht zusätzlich gründlich gewaschen**. Bei C. difficile (sporenbildend) reicht Desinfektion nicht; Waschen entfernt die Keime mechanisch. (Außerdem prüfen: Schutzkleidung korrekt abgelegt/entsorgt; Händedesinfektion vor Verlassen.) [03 §4]

4 – ERKLÄREN: *Übliche Händedesinfektionsmittel wirken bei C. difficile nicht ausreichend,* ***weil*** *das Bakterium Sporen bildet, die es bei ungünstigen Bedingungen einkapselt und sich später wieder in eine Bakterienzelle verwandeln kann. Daher werden die Keime durch gründliches Händewaschen mechanisch entfernt.* (Handout S. 8)

5 – ZUSAMMENFASSEN: *Nach einer Nadelstichverletzung fördert man den Blutfluss und spült/desinfiziert die Wunde intensiv, informiert unverzüglich Arzt/Durchgangsarzt, klärt das Infektionsrisiko (HBV/HCV/HIV), beginnt ggf. die HIV-PEP innerhalb von 2 Stunden, meldet den Unfall (BGW/Unfallkasse), sorgt für Nachsorge und dokumentiert.* (BGW S. 20) [03 §9]

6 – BEGRÜNDEN: *Gebrauchte spitze Instrumente müssen sofort in geeigneten Behältern entsorgt werden,* ***weil*** *beim Zurückstecken in die Schutzkappe (Recapping) und beim Liegenlassen die Verletzungsgefahr hoch ist; Nadelstichverletzungen übertragen Hepatitis B (≈ 30 %), C (≈ 3 %), HIV (≈ 0,3 %). Zudem erhöhen überfüllte Behälter und Zeitdruck das Risiko. Sicherheitsgeräte und ruhiges Arbeiten verringern es.* (BGW S. 4–7)

7 – DISKUTIEREN: *Pro Handschuhe: Barriere vor Kontamination, Eigenschutz, Pflicht bei Kontakt mit Blut/Ausscheidungen. Contra Ersatz: Handschuhe können kaum erkennbare Schäden (Mikroperforationen) haben, beim Ausziehen kann es trotz Vorsicht zur Kontamination der Hände kommen; zudem Hautprobleme bei langem Tragen. Fazit: Handschuhe ersetzen die hygienische Händedesinfektion nicht; nach dem Ausziehen muss immer desinfiziert werden (bei C. difficile zusätzlich waschen).* (Handout S. 9; BGW S. 8)

Fall D: Frau Weber

1 – NENNEN: Blickkontakt (Frau Weber blickt zur Wand); Körperhaltung/Abwendung; Mimik (fehlend); Gestik/Berührung (Berührung ohne Ankündigung); räumlicher Abstand; äußeres Erscheinungsbild (Dienstkleidung). Paraverbal: Tonfall.

2 – BESCHREIBEN: *Die Praxisanleiterin betritt das Zimmer ohne anzuklopfen, misst Blutdruck und Blutzucker und kündigt zum Schluss „Und jetzt noch den Popo“ an. Frau Weber blickt zur Wand und antwortet nicht. Die Praxisanleiterin äußert gegenüber der Auszubildenden „Die redet nie.“ Später fragt Frau Weber leise, wie lange die Auszubildende heute bleibt.* (Anlehnung an Fallbeispiel S. 1)

3 – ERKLÄREN: *Die Formulierung ist problematisch, **weil** sie infantilisierend und wenig respektvoll ist, die Intimsphäre und Würde nicht wahrt und keine Wahlmöglichkeit lässt. Zudem wirkt jedes Wort der Pflegenden und beeinflusst das Vertrauen der Pflegebeziehung. Besser: „Ich wasche jetzt Ihren Intimbereich. Möchten Sie das selbst übernehmen?“* (Sequenz 3 S. 17; Sequenz 2)

4 – ERMITTELN: Sachinhalt: Frau Weber möchte wissen, wie lange die Auszubildende bleibt. Selbstoffenbarung: Sie fühlt sich vielleicht einsam/unsicher/ängstlich. Beziehung: Sie vertraut der Auszubildenden (spricht sie an), anders als der Praxisanleiterin. Appell: „Bleiben Sie bitte (länger)/sprechen Sie mit mir.“ [02 §1.2]

5 – DEUTEN: *Aus Sicht von Frau Weber könnte das Schweigen bedeuten, dass sie sich übergangen und nicht gesehen fühlt, weil niemand sie anspricht oder erklärt; vielleicht ist sie ängstlich, beschämt, traurig oder schwerhörig. Möglicherweise testet sie, ob jemand wirklich Zeit hat, denn sie spricht die Auszubildende später an. Schweigen ist Kommunikation (Watzlawick).*

6 – ENTWICKELN: *Begrüßung:* „Guten Morgen, Frau Weber, ich bin … von der Pflege. Darf ich hereinkommen?“ *Ankündigung:* „Ich möchte jetzt Ihre Körperpflege durchführen. Möchten Sie Gesicht und Arme selbst waschen? Für den Intimbereich gebe ich Ihnen den Waschlappen; ich decke nur auf, was ich wasche. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn etwas unangenehm ist.* Begründung: Vorstellung/Anklopfen schaffen Vertrauen, Wahlmöglichkeit wahrt Autonomie, Abdecken schützt Intimsphäre. [02b D6]

7 – ANWENDEN: *„Ich habe mich unwohl gefühlt, als ich gehört habe, dass Frau Weber ‚nie redet‘, weil sie dadurch auf ihr Schweigen reduziert wird. Ich wünsche mir, dass wir ihr vorher erklären, was wir tun, und sie ansprechen.“* (Ich-Botschaft: Gefühl – Grund – konkreter Wunsch; Kritik am Verhalten, nicht an der Person.) [02 §1.5]

Fall E: Herr Lang

1 – NENNEN: Eigensicherung/Umgebung prüfen; Reaktion prüfen (ansprechen, an der Schulter rütteln); Hilfe rufen; Atemweg öffnen (Kopf überstrecken, Kinn anheben); Atmung prüfen (Sehen–Hören–Fühlen, höchstens 10 Sekunden); Notruf/Reanimationsteam; CPR beginnen; AED holen lassen. [08 §5.1]

2 – BESCHREIBEN: *Herr Lang liegt auf harter Unterlage mit freiem Oberkörper. Die Helferin kniet neben dem Brustkorb, legt den Handballen auf die Mitte des Brustkorbs (unteres Sternumdrittel), die andere Hand darauf, Arme gestreckt. Sie drückt 5–6 cm tief mit einer Frequenz von 100–120/min, entlastet vollständig und wechselt nach 30 Kompressionen zu 2 Beatmungen (30:2) bzw. drückt kontinuierlich, wenn nicht beatmet wird. Unterbrechungen sind kurz; Helferwechsel alle 2 Minuten.* (ZF S. 13; ⚠ Folie 140: 80–100/min – Skript klären) [08]

3 – ERKLÄREN: *Vereinzelte, geräuschvolle Atemzüge sind eine **Schnappatmung**; sie kann in den ersten Minuten eines Kreislaufstillstands auftreten und ist keine normale Atmung, **weil** sie keine ausreichende Belüftung leistet. Würde man sie als normal werten, würde die lebensrettende Reanimation verzögert.* (ZF S. 12; F 119, 163)

4 – ERMITTELN: Wo ist das Ereignis (Haus/Station/Zimmer)? Wer ruft an? Was ist geschehen (bewusstlos, keine normale Atmung)? Wie viele Betroffene? Warten auf Rückfragen. Innerklinisch: Reanimationsteam alarmieren, Defibrillator holen. [08 §3]

5 – VERGLEICHEN: *Gemeinsam: Sicherheit, Reaktion prüfen, Atemweg, Atmung prüfen, Hilfe/Notruf. Unterschied: Bei **normaler Atmung** → stabile Seitenlage, Atmung regelmäßig kontrollieren, nicht allein*

*lassen; bei **fehlender/nicht normaler Atmung** → Kreislaufstillstand: sofort Herzdruckmassage (30:2), AED anlegen, bis Rettungsdienst/Team übernimmt.* (ZF S. 12–15)

6 – BEGRÜNDEN: *Der AED analysiert den Rhythmus und kann nur bei schockbarem Rhythmus (VF/VT) einen Schock abgeben; er ersetzt nicht die Herzdruckmassage, die den Kreislauf aufrechterhält und die Überlebenschance erhöht. Beide ergänzen sich: CPR läuft weiter und wird nach dem Schock/bei „kein Schock“ sofort fortgesetzt.* (ZF S. 15)

7 – STELLUNG BEZIEHEN: *Die Aussage ist falsch. Nach § 323c StGB besteht eine Pflicht zur Hilfeleistung, wenn sie erforderlich und zumutbar ist; von Auszubildenden wird Hilfe nach ihren Kenntnissen und Fähigkeiten erwartet, im Pflegekontext besteht zudem Verantwortung gegenüber anvertrauten Pat. (Garantenstellung). Wer mit gebotener Sorgfalt hilft, muss grundsätzlich keine rechtlichen Folgen fürchten. Auszubildende handeln im eigenen Kompetenzbereich, nach Hausstandard und mit der zuständigen Pflegefachperson – aber sie handeln.* ⚠ keine Rechtsberatung. (ZF S. 8; F 66–79, 167)

Fall F: Frau Berger

1 – NENNEN: Sie kann essen und trinken selbstständig; sie kann Bedürfnisse äußern/mitwirken; hohe Motivation; die Tochter wohnt in der Nähe (soziale Ressource). (Lernskript S. 2)

2 – ZUORDNEN: Schmerzen/Aufstehen → ABEDL 2 (Sich bewegen); Brille fehlt → ABEDL 11 (sichere Umgebung) und 1 (Kommunizieren); lebt allein/Tochter → ABEDL 12 (Soziale Bereiche); „Ich möchte selbst machen“ → ABEDL 4/13. (Mehrfachzuordnung möglich; Begründung nennen.)

3 – DEFINIEREN: *Selbstbestimmung (Autonomie) bedeutet, dass ein Mensch frei und eigenverantwortlich darüber entscheidet, wie er leben, handeln und sich verhalten möchte.* (Lernskript S. 2)

4 – ERMITTELN: (1) Unsicherheit/Schmerzen beim Aufstehen → Sturz-/Mobilitätsrisiko; (2) fehlende Brille → eingeschränktes Sehen/Orientierung; (3) lebt allein → Unterstützungsbedarf nach der Entlassung. *(auch: Schmerz, Thrombose/Dekubitus bei Immobilität)*

5 – ANWENDEN: 1. Information: Sturz, Schmerz rechte Hüfte, Hilfe beim Aufstehen, Brille fehlt, Wunsch nach Selbstständigkeit, lebt allein. 2. Problem/Ressource: unsicheres Aufstehen; Mitwirkung und Motivation. 3. Ziel: sicheres Aufstehen mit Unterstützung. 4. Maßnahmen: Schmerzen/Beweglichkeit beobachten, sichere Umgebung, Unterstützung anbieten, Frau Berger einbeziehen, Brille organisieren. 5. Durchführung: gemeinsam umsetzen. 6. Evaluation: War das Aufstehen sicher? Unterstützung anpassen. (Lernskript S. 4)

6 – DISKUTIEREN: *Für vollständige Übernahme: Zeitersparnis, bei starken Schmerzen entlastend. Dagegen: Autonomie und Ressourcen gehen verloren, Abhängigkeit steigt, Frau Berger wünscht ausdrücklich Beteiligung. Abwägung: Teilübernahme – Frau Berger wäscht, was sie kann; Unterstützung nach Schmerz und Sicherheit; Wünsche respektieren. Fazit: Beteiligung ist vorzuziehen.*

7 – ENTWICKELN: *Ziel: „Frau Berger steht innerhalb von drei Tagen mit einer Pflegekraft und Gehhilfe sicher vom Bett auf und äußert dabei höchstens leichte Schmerzen.“ Begründung: patientenorientiert (sie will selbstständig sein), konkret, zeitlich überprüfbar, im Evaluationsschritt kontrollierbar.* (⚠ Schmerzskala laut Hausstandard)

Ek 6 — Klinik vaka dosyası (Bölüm G)

← Ana rehber · **Uyarı:** Vakalar **eğitim amaçlıdır, kurgusaldır** (Frau Berger/Herr Schneider/Fall Simon-Johanna kaynak PDF'lerden uyarlanmıştır; diğerleri ders içeriğine dayanarak yazılmış örneklerdir). **Gerçek hasta talimatı değildir.** İlaç, dozaj, tedavi kararı → Arzt/PFK/Hausstandard. Çözümler **tek doğru değildir**. **Kapsam notu:** Diyabet, demans, ağrı ölçeği, ameliyat sonrası ayrıntılı bakım ve dehidratasyon tedavisi derslerinizde **yeterince işlenmemiştir**; bu konulardaki vakalar eklenmedi (veya yalnızca sınırlı kısmı kullanıldı). Bu konularda ders materyali gelince genişletilir.

Fall 1 — Frau Berger (81): Veränderte Mobilität (LF 2)

Anamnese (DE): Frau Berger ist 81 Jahre alt. Früher ging sie selbstständig mit dem Rollator zum Speiseraum. Seit einiger Zeit geht sie langsamer, braucht beim Aufstehen mehrere Versuche, hält sich an Möbeln fest, bleibt häufiger im Sessel und verlässt das Zimmer seltener. *(EH S. 2)* **TR:** 81 yaşında; eskiden rolatörle yemek salonuna giderdi; son zamanlarda yavaş yürüyor, kalkarken birkaç deneme gerekiyor, mobilyalara tutunuyor, odadan az çıkıyor. **Önemli bulgular:** langsameres Gehen, Aufstehversuche ↑, Festhalten an Möbeln, Rückzug. **Sorular:** 1) Hauptproblem? 2) Welche Infos fehlen? 3) Risiken? 4) Ressourcen? 5) Ziele? 6) Maßnahmen? 7) Wann informieren? **Örnek cevap:** 1) neu aufgetretene/zunehmende Mobilitätseinschränkung mit Sturz- und Immobilitätsrisiko. 2) Schmerzen? Medikamente (neu?), Sehen/Hören, Schuhe, Gleichgewicht, Angst zu stürzen, Sturzereignisse, Stimmung, Ernährung/Trinken, Ausscheidung (Eilen zur Toilette?). 3) Sturz, Thrombose, Dekubitus, Kontraktur, Pneumonie, Isolation. 4) frühere Selbstständigkeit mit Rollator, Motivation?, Umgebung. 5) sicheres Aufstehen/Gehen, Teilnahme am Essen im Speiseraum, kein Sturz. 6) Beobachten, Ursachen abklären (Arzt), Bewegungsangebote/Training, Umgebung/Beleuchtung/Stolperfallen, Rollator/Bremsen, Schuhe, Information/Anleitung, soziale Teilhabe, Sturzrisiko dokumentieren. 7) bei plötzlicher Verschlechterung, Sturz, Schmerzen, Schwindel, Verwirrtheit. **Güvenlik:** Mobilisation nur mit Begleitung/nach Einschätzung; keine Alterszuschreibung („normal"). → 06

Fall 2 — Herr Schneider (78): Sturz, Angst, Waschen, wenig getrunken

Siehe 06 §6 (Ihre Antworten + Feedback), 09 §2 (Pflegeprozess), Klausur 5, 15. **Alternatif yaklaşımlar:** a) Waschen jetzt anbieten mit Teilübernahme vs. b) später erneut anbieten und erst Trinken/Mobilisation priorisieren: → beide vertretbar; Kriterium: **Sicherheit/Akutrisiko** (Trinkmenge, Schmerz) vor Komfort; **Autonomie** wahren. **Fehlende Infos:** Temperatur/Vitalzeichen, Sturzursache, Schmerzstärke, Orientierung, Haut. **Güvenlik:** Schmerzmittel/Infusion **nur ärztlich**; bei Delir/Fieber/Verschlechterung PFK/Arzt.

Fall 3 — Herr Aksoy (72): Bettlägerig, Thrombose-/Pneumoniegefahr (Post-OP/Immobil)

Hasta öyküsü (DE, fiktiv): Herr Aksoy, 72, vor 3 Tagen Hüft-TEP, wegen Schmerzen kaum mobil, trinkt wenig, liegt flach im Bett, raucht, hat leichten trockenen Husten und sagt: „Mein linkes Bein fühlt sich schwer an." **TR:** 72 yaşında, 3 gün önce kalça protezi; ağrı nedeniyle az hareket ediyor, az içiyor, sigara içiyor; hafif kuru öksürük; „sol bacağım ağır geliyor". **Bulgular:** Hüft-OP (**hohes expositionelles Risiko**), Alter > 60, Rauchen, Immobilität, Exsikkose-Risiko, **einseitiges Schweregefühl** (IC S. 2–3), Husten. **Sorular & Cevaplar:** *Priorität?* Schweregefühl/einseitige Beinschwellung = **mögliche TVT** → **sofort PFK/Arzt informieren, nicht selbst massieren/mobilisieren, Embolie-Zeichen (Atemnot, Brustschmerz) beobachten**; bei plötzlicher Atemnot → Notruf. *Risiken:* TVT/Lungenembolie, Pneumonie (flache Atmung, Husten), Dekubitus, Exsikkose. *Prophylaxe-Maßnahmen (nach Plan/Anordnung):* Frühmobilisation, Bewegungsübungen im Bett (Fußkreisen), Flüssigkeit, MTPS **nach Anordnung/passend gemessen**, Schmerzmanagement **(Arzt)**, LISA (Oberkörperhochlage, Atemübungen, Mundpflege, Aspirationsprophylaxe). *Ziele:* keine Thrombosezeichen, Atmung unauffällig, mobilisiert nach Plan. *Evaluation:* Beinumfang/Haut/Schmerz, Atemfrequenz, Temperatur, Trinkmenge. **Güvenlik:** Antikoagulation/Medikamente **ärztlich**; kein Ausstreichen; MTPS-KI prüfen (pAVK etc.). → 07

Fall 4 — Frau Wozny: Clostridioides difficile / Händehygiene (LF 3a)

Anamnese (aus Handout S. 8, vereinfacht): Frau Wozny hat ständige übelriechende Durchfälle (C. difficile). Pflegefachfrau Nimra legt Schutzkleidung an und **desinfiziert und wäscht** nach Kontakt mit dem Toilettenstuhl die Hände; am Zimmer hängt ein Hinweisschild. **Sorular:** 1) Warum zusätzlich waschen? 2) Welche Schutzmaßnahmen? 3) Wie Angehörige einbeziehen? 4) Fehler der Auszubildenden? **Cevap:** 1) Sporen überleben übliche HD-Mittel; Waschen entfernt mechanisch. 2) Schutzkleidung patientenbezogen, Handschuhe, HD **und** Händewaschen, Flächen-Desinfektion nach Hygieneplan. 3) Hinweisschild, Aufklärung über HD/Besuchsregeln (Hygienefachkraft). 4) Handschuhe ≠ HD; Schutzkleidung nicht gewechselt. **Güvenlik:** Einrichtungsspezifischer Hygieneplan, Hygienefachkraft fragen. → 03

Fall 5 — Frau Demir (84): Dekubitusrisiko und Hautbeobachtung (LF 3a)

Hasta öyküsü (DE, fiktiv): Frau Demir, 84, überwiegend im Bett, dünne trockene Haut. Beim Lagern fällt am Kreuzbein eine Rötung auf. Beim Druck mit dem Finger bleibt die Rötung bestehen. **Bulgular:** nicht wegdrückbare Rötung = **positiver Fingertest → Dekubitus Kategorie I (T2 S. 8)**; Altershaut/Xerosis (T2 S. 9). **Cevap:** *Problem:* beginnende Druckschädigung; *Ursachen:* Immobilität, Druck, trockene Haut. *Maßnahmen (nach Standard/PFK, DNQP-Expertenstandard Dekubitusprophylaxe ⚠ nicht in PDFs):* PFK informieren, **Stelle entlasten**, Haut beobachten/dokumentieren (Lokalisation, Größe, Fingertest), Hautpflege, Bewegung fördern. *Doku:* „Kreuzbein: Rötung ca. 3 × 2 cm, auf Fingerdruck nicht wegdrückbar, Haut intakt, Pat. gibt keine Schmerzen an. PFK informiert." **Güvenlik:** Keine Eigenmaßnahmen ohne Anleitung; Massage/Reiben vermeiden ⚠ (Expertenstandard).

Fall 6 — Patientin am Boden (Erste Hilfe, innerklinisch)

Siehe 08 §8 und Klausur 3, Fr. 14. **Varianten:** (a) Patient reagiert, klagt über Brustschmerz/Atemnot → Notfallteam, ABCDE; (b) reagiert nicht, atmet normal → Seitenlage; (c) keine normale Atmung → CPR/AED. **Lernziel:** Entscheidungsbaum + SBAR-Übergabe. **Güvenlik:** Eigenschutz (Handschuhe), Kompetenzgrenzen, Hausstandard.

Fall 7 — Johanna: „Wie alt sind Sie überhaupt?" (Kommunikation)

Siehe 02 §1.2. Aufgabe: 4 Ohren analysieren, 2 Alternativantworten schreiben. **Alternativen:** s. dort. **Güvenlik/Ethik:** Auszubildende nicht belügen/abwehren; bei Unsicherheit PFK/Praxisanleiterin einbeziehen.

Fall 8 — Herr Becker (66): Verschlucken und Husten beim Essen (Aspirationsprophylaxe)

Hasta öyküsü (DE, fiktiv): Nach einem Schlaganfall verschluckt sich Herr Becker häufig beim Essen im Liegen, hustet, die Stimme klingt „nass". Gestern Abend leichte Temperaturerhöhung, heute stärkere Atemnot. **Bulgular: Dysphagie**, Aspirationsrisiko (P S. 17); Aspirationspneumonie-Symptome **verzögert (2–12 h)**: Husten, Dyspnoe, Zyanose, Fieber (P S. 18). **Cevap:** *Maßnahmen:* **aufrecht zum Essen**, Zeit lassen, orale Ernährung abwägen (ärztlich/Logopädie ⚠), Mundpflege; *bei Atemnot/Zyanose/Fieber → sofort PFK/Arzt (Notfall)*; Beobachtung AF, Temperatur, Hautfarbe. *Doku:* objektiv, Zeit, Nahrung, Symptome. **Güvenlik:** Nicht „weiterfüttern", wenn Atemnot; keine Sondenernährung/Absaugen ohne Anleitung/Anordnung.

Yorum şablonu (her vaka için)

1. Hauptproblem · 2. Fehlende Infos · 3. Wichtige Zeichen · 4. Risiken · 5. Ressourcen · 6. Ziele · 7. Maßnahmen · 8. Evaluation · 9. Eskalation (wen/wann) · 10. Dokumentation. → 09

Ek 7 — Kişisel gelişim takip tablosu (Bölüm H / Ek 7)

← Ana rehber · Bu tabloyu kendi sürümünüzde (Markdown/Excel) doldurun. **Zayıf konu listesi** = yanlış yaptığınız her soru. **Durum:** ☐ yeni · ◐ öğreniyorum · ● biliyorum · ★ sınavda rahat. **Tekrar tarihleri:** gün 1 / 3 / 7 / 14.

1. Konu takibi

Konu	Bölüm	Durum	Son çalışma	Tekrar 1	Tekrar 3	Tekrar 7	Tekrar 14	Not
Pflegeverständnis/ABEDL/PflBG	01	☐						
Pflegeprozess	01/09	☐						
Kommunikation-Modelle	02	☐						
Berührung/Nähe-Distanz	02	☐						
Pflegedeutsch-Dialoge	02b	☐						
Hygiene/HD/5 Momente	03	☐						
Infektion/MRE/BGW	03	☐						
Zelle/Gewebe	04	☐						
Haut/Dekubitus	04	☐						
Körpertemperatur/Fieber	05	☐						
Mobilität/Sturz	06	☐						
Thromboseprophylaxe	07	☐						
Pneumonieprophylaxe	07	☐						
Erste Hilfe BLS/AED	08	☐						
Schock/Notfälle	08	☐						
Operatoren/Dokumentation	10	☐						
Grammatik	11	☐						

2. Yanlış yapılan sorular (Zayıf konu listesi)

Tarih	Klausur/Soru	Konu	Yanlış cevap	Neden? (bilgi / dil / dikkat)	Doğrusu	Tekrar planı

Neden kodları: B = Bilgi eksik · **D** = Almanca dil/terim · **O** = Operatörü yanlış anladım · **S** = Süre/Dikkat. **Öneriler:** B → konu özeti + flashcard + 3 yeni soru; D → Ek 1 sözlük, cümleyi 3 kez yaz; O → 10; S → zamanlı pratik.

3. Almanca hata günlüğü

Cümleniz	Hata türü (Artikel/Fall/Verb/…)	Neden	Doğru cümle	Yeni örnek cümlem

4. Haftalık özet

Hafta	Çalışılan süre	Çözülen soru	Doğru %	En zayıf 2 konu	Gelecek hafta hedef
1					
2					
3					
4					

5. Öğretmene sorulacaklar listesi

- ☐ Herzdruckmassage Frequenz 100–120 mi 80–100 mü? (00 §4)

- [ ] Hypothermie-Definition / Nosokomial 24 Std. vs. 48 Std.
- [ ] Hangi Kompetenzmodeli (3 Dimension vs. 4 Bereich)?
- [ ] Sınav formatı (Operatoren? Fall? mündlich?)

Ek 8 — Kaynakça ve sayfa indeksi

> ← Ana rehber · "S." = PDF sayfası (özel not yoksa). Kitap sayfası: "bas. S.".

1. Yüklenen kaynaklar ve önemli sayfalar

Dosya	Önemli sayfalar	Rehberde
Lernskript LF1A	S. 1 Pflegeformen/Kompetenz; S. 2 Frau Berger; S. 3 ABEDL; S. 4 Pflegeprozess; S. 4–5 PflBG	01
Arbeitsblatt LF1A	S. 4 Begriffe; S. 6 ABEDL-Zuordnung; S. 7–8 Pflegeprozess; S. 9–10 § 4 PflBG-Fälle	01
Handlungskompetenz (I care S. 47–48)	S. 1 Definition/Fachkompetenz; S. 2 Abb. 2.7, Sozial-/Personal-/Teilkompetenzen	01
Einstieg in die Unterrichtseinheit (9.10.2025)	S. 4 Fallanalyse-Auftrag; S. 7–8 Laswell; S. 9–10 4 Seiten	02
Fallbeispiel Merkmale u. Bedeutung...	S. 1–2 (Maria, Simon, Johanna)	02
Sequenz 2 – Fall Simon	S. 2–4 Mantz; S. 6 Schweigen; S. 7–8 Eisbrecher; S. 9 Verabschiedung	02
Sequenz 3 – Kommunikation	S. 2–6 nonverbal; S. 10–13 Watzlawick; S. 14 Feedback; S. 17 Sprache	02
Sequenz 4 – Fall Johanna	S. 3–6 Vier Ohren; S. 7 Alternativen	02
Sequenz 5	S. 3–4 formell/informell	02
PPP Berührung AI 02/04/05; Arbeitsinput 06b	AI 02 S. 3 Begriffe; AI 04 S. 5–9; AI 05 S. 2–5	02
Hyg. Grundlagen Teil I/II; Handout; Übung	T1 S. 2–5, 9, 11, 14–15, 17, 19–20; T2 S. 2–4, 16–17, 19; H S. 1–2, 5–9; Übung S. 1–2	03
BGW Take Care Infektionsschutz	S. 4–6 NSV; S. 7–9 HD/Handschuhe; S. 10–13 MRSA/TB/Skabies; S. 14 Rechtliches; S. 18–23 Fall Johanna/Leitfaden S. 20	03
LF3A Haut Teil 1	S. 1–4	04
LF3A Haut Teil 2	S. 1–10 (Turgor S. 6; Zyanose/Recap S. 7; Dekubitus/ABCDE S. 8; Alter S. 9)	04
Thieme CNE Körpertemperatur	S. 2–4 Physiologie; S. 5–14 Messung; S. 15–17 Hypothermie; S. 17–21 Hyperthermie; S. 21–29 Fieber; S. 29–36 Maßnahmen/Komplikationen	05
Erwartungshorizont Bewegung im Alter	S. 1–4	06
Sturzprophylaxe PPP	Folien 3–14	06
Thromboseprophylaxe PPP	Folien 2–4	07
Auszug I care Thromboseprophylaxe	S. 1–6 (bas. S. 417–422; S. 1 enthält zuerst Pneumonie-LISA)	07
Pneumonieprophylaxe PPP	Folien 2–21	07
Erste Hilfe (254 S.)	Anatomie 5–56; Recht 58–79; Leitlinien/Notruf 84–89; BLS 109–163; ALS 171–194; Schock 195–204; Notfälle 205–229; Pflege 230–253	08
Zusammenfassung Erste Hilfe B2	S. 1–27	08
image.jpg #1 Operatoren-Training	Übungsheft S. 3	10
image.jpg #2 Fall Herr Schneider	Übungsheft S. 4	06/10

2. Dış kaynaklar (ek bilgiler — açıkça PDF dışı)

Konu	Kaynak	Not
DNQP Expertenstandard Sturzprophylaxe, **2.**	dnqp.de Auszug · Pressemitteilung	Folie nennt 2013

Konu	Kaynak	Not
Aktualisierung 2022		
GRC-Leitlinien 2025 (BLS/PLS)	GRC Pressemitteilung · GRC Notfall+Rettungsmedizin 8/2025	Zahlen nicht verifiziert; Folien „2025“ zitieren 2021-Dokument
§ 323c StGB	https://dejure.org/gesetze/StGB/323c.html (Link aus Folie 69)	
PflBG	https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/	Sandbox’tan açılamadı → manuel kontrol
RKI / KRINKO / BGW / IfSG	https://www.rki.de/krinko · https://www.bgw-online.de (BGW S. 14–15 listeler)	Aktuelle Informationen: T2 S. 15
Hall-Distanzzonen	Folie AI 05 S. 4 Bildquelle karrierebibel.de	Zahlenwerte PDF’de yok (Allgemeinwissen, ⚠)
Prezi „Tabuzonen nach Morris“	Link Arbeitsinput 06b	Inhalt nicht erhalten

3. Doğrulanamayan / eksik

- Erste Hilfe S. 1–57 çizim sayfaları ve S. 234–254 tekrarı yalnızca taranmıştır.
- BGW S. 21–56 yalnızca taranmıştır.
- Boş çalışma kâğıtları (Arbeitsblatt LF1A, Hygiene-Handout, Pflegias-Übung): cevaplar **sizin ders notlarınızda**; ben örnek önerdim.
- Medikamente, Wundversorgung (Verbandtechnik), Diabetes, Demenz, Schmerzskalen, Delegation, Patientenrechte: PDF’lerde yok.